



**DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA Y SALUD
GLOBAL**

PROYECTO DE TESIS

**“VARIACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN LAS
CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LOS
PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO EN
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN LIMA
METROPOLITANA – 2025”**

PRESENTADO POR:

Mgtr. JANET CARITO QUISPE CORILLA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

**DOCTOR(A) EN SALUD PÚBLICA Y SALUD
GLOBAL**

LIMA

2025

Índice

ÍNDICE.....	2
ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE ANEXOS.....	4
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO	5
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	5
1.1.1. <i>Planteamiento del problema</i>	5
1.1.2. <i>Formulación del problema</i>	9
1.2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS	11
1.2.1. <i>Objetivo general</i>	11
1.2.2. <i>Objetivos específicos</i>	11
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....	13
1.3.1. <i>Justificación teórica</i>	13
1.3.2. <i>Justificación metodológica</i>	14
1.3.3. <i>Justificación social</i>	15
1.3.4. <i>Aportes en la investigación para la DIRIS Lima Centro</i>	16
1.4. LIMITACIONES DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN	17
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	19
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	19
2.1.1. <i>Internacionales</i>	19
2.1.2. <i>Nacionales</i>	34
2.2. BASES TEÓRICAS.....	37
2.2.1. <i>Desarrollo histórico</i>	37
2.2.2. <i>Fundamentación teórica</i>	41
2.2.3. <i>Marco conceptual</i>	47
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	58
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	60
3.1. HIPÓTESIS	60
3.1.1. <i>Hipótesis general</i>	60

3.1.2. Hipótesis específicas.....	60
3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	62
3.2.1. Variable 1: Características poblacionales	62
3.2.2. Variable 2: Calidad de vida.....	62
3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	62
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.....	65
4.1. ENFOQUE, TIPO Y ALCANCE DE INVESTIGACIÓN	65
4.1.1. Enfoque.....	65
4.1.2. Tipo y alcance	65
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	66
4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	66
4.3.1. Población	66
4.3.2. Muestra	68
4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	69
4.4.1. Técnicas e instrumentos.....	69
4.4.2. Validez y confiabilidad	74
4.4.3. Procedimiento de recolección de datos	78
4.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS.....	79
CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	83
5.1. PRESUPUESTO (RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICOS, TECNOLÓGICOS Y OTROS)	83
5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	84
REFERENCIAS	85
ANEXOS.....	105

Índice de tablas

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de la calidad de vida según Schalock	43
Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables.....	63
Tabla 3. Centros de Salud donde se cuenta con el servicio de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención. Solo DIRIS Lima Centro	67
Tabla 4. Muestreo del estudio.....	68
Tabla 5. Distribución de pacientes que serán entrevistados	69
Tabla 6. Clasificación de las edades en Perú	70
Tabla 7. Subescalas o dimensiones de la calidad de vida	72
Tabla 8. Escala la calidad de vida según el SF-36.....	73
Tabla 9. Administración de las preguntas y sus puntajes del SF-36	74
Tabla 10. Recomendaciones de los expertos - validación de contenido	76
Tabla 11. Confiabilidad del instrumento – valor del coeficiente alfa de Cronbach	77
Tabla 12. Presupuesto del proyecto	83
Tabla 13. Cronograma del proyecto.....	84
Tabla 14. Recomendaciones de los expertos - validación de contenido	119

Índice de Anexos

Anexo A. Matriz de consistencia	105
Anexo B. Población afiliada a SIS de Lima Metropolitana y los centros de salud	108
Anexo C. Cuestionario de calidad de vida SF – 36.....	109
Anexo D. Tabulación de las preguntas del SF-36.....	112
Anexo E. Cuestionario de características poblacionales	115
Anexo F. Consentimiento informado	116
Anexo G. Análisis estadístico	118
Anexo H. Comentarios de Juicios de expertos	119
Anexo I. Base de datos	128

Capítulo I: Planteamiento del estudio

1.1. Planteamiento y formulación del problema

Este apartado describe la problemática identificada en este trabajo de investigación, así como la formulación de la misma.

1.1.1. Planteamiento del problema

La “Calidad de Vida” en las últimas décadas se ha convertido en un concepto importante para el campo médico, su estudio se basa principalmente en conocer el impacto de las enfermedades, condiciones de vida, características laborales entre otros sobre las condiciones de salud en pacientes con enfermedades crónicas y discapacitantes tanto que tenga o no cura (Barceló et al., 2021). La información de los estudios sobre la calidad de vida aportó a la respuesta de la salud pública ante el aumento de la prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas, diabetes, cáncer entre otros (Lopera, 2020).

La calidad de vida es medida a través de sus dimensiones como la salud física, salud psicológica, salud de las relaciones sociales, salud del medio ambiente, espiritualidad e independencia del individuo (Jáuregui, 2019). Contempla a la persona como un todo, un punto de vista que debe ser tomado en cuenta en el abordaje sanitario en todos los niveles de atención, la calidad de vida no es ajena a las características de la población ya que se encuentran fuertemente ligadas (García.F, 2022).

Los servicios de salud son las herramientas de la salud pública que generan cambios positivos en la calidad de vida como es el caso de la “terapia física”, esto se debe a que tienen un abordaje amplio desde la prevención hasta el cuidado paliativo de los pacientes con diagnósticos terminales. Sus lugares de aplicación no solo se enfocan en brindar atenciones en un centro de salud, puede intervenir en centros educativos, asociaciones de madres de familia, poblaciones vulnerables entre otros, compensando así quizás su ausencia en los centros oficiales de salud,

todo esto es contemplado como el primer nivel de atención (Pereira , 2022). Estas características permiten que el servicio de terapia física sea un punto de referencia para conocer la calidad de vida de los pacientes (López.J, 2020).

Nuestra intención de conocer la calidad de vida en la ciudad de Lima se debe a que en un estudio del 2018 realizado en esta zona identificaron que el 80% de la población evaluada presentó un nivel moderado en las dimensiones de la calidad de vida como la salud física, ambiental, social y psicológica, además de contar con un 47.3% de disfunción familiar severa además de resaltar las características de la población estudiada como participe del nivel de calidad de vida. (Condezo y Quispe, 2022). Además de ser considerado como la zona que alberga a la tercera parte de la población peruana (CPI, 2023).

Se realizó una investigación a nivel mundial de la calidad de vida y todo lo que esté relacionada a ella; en España se conoce que una de las lesiones que comprometen a la calidad de vida en esta población es la lumbalgia, llegando hasta el 40-65% de los afectados a sufrir depresión por su situación de calidad de vida, actividad social, afectación del reposo e incluso en su vida sexual (San José, 2015). Estas cifras son alarmantes pues se conoce que los servicios de salud a los que acceden los pacientes, como la terapia física, logran una importante mejoría de la movilidad (16,5%) y en el aumento de calidad de vida (57,8%) (Otaegui, 2020).

En Latinoamérica, un estudio de la calidad de vida en México muestra que el 38.5% de sus evaluados por lumbalgia presenta mala calidad de vida a través de 200 encuestas, incluso las ocupaciones de oficina y operarios pueden llegar a presentar 15.18 días de incapacidad laboral (Martinez O. , 2015).

Según Flores en su estudio también realizado en México en adultos mayores, se observó que tienen una autopercepción de la calidad de vida deficiente en los mayores de 81 años de edad (60%), el género con mayor mala calidad de vida son las mujeres (42.6%), en cuanto a la religión los testigos de Jehová indicaban mala calidad de vida (60%), la dimensión de salud física se presentó una media 39.32 ± 10.80 , salud psicológica 42.67 ± 9.24 , relaciones sociales 39.3 ± 12.43 y medio

ambiente 37.4 ± 9.14 ; es decir en general presentan una mala calidad de vida (Flores et al., 2018).

En Ecuador, Lopez estudió la calidad de vida y analizó las 8 dimensiones del cuestionario SF-36 presentas puntuaciones más altas en el “funcionamiento físico” ($80,54 \pm 23,66$), desempeño emocional ($82,74 \pm 36,03$) y funcionamiento social ($85,58 \pm 21,93$), y en menor puntuación fueron la vitalidad ($62,68 \pm 20,37$) y salud general ($64,55 \pm 21,72$) también se visualiza que las mujeres presentan menor calidad de vida en todas las dimensiones (Lopez et al., 2019).

En Chile, los pacientes que presentan diagnósticos de crónico, osteoartritis, artritis reumatoides en entre otros refirieron que su calidad de vida se ha visto afecta de moderado a severo en la irritabilidad (76,9%), autocuidado (72,1%), interferencias en las AVD's (74,5%), capacidad para caminar (66,6%), actividades sociales (70,1%), trabajo (69,4%), ánimo depresivo (68,8%), actividad sexual (56,8%) y sueño (65,3%) (Bilbeny, 2019).

En Colombia se identificó que la “Calidad de Vida Relacionada con la Salud” CVRS, en su 8 dominios tienen el puntaje mayor al 60%, los de menor puntajes fueron salud general en adultos mayores de 65 años ($57,8 \pm 21$), dolor en estrato socioeconómico 3 ($49,7 \pm 37$) y vitalidad en un barrio de Bucaramanga ($62,3 \pm 5$), pero los de mayor puntuación son función física en estudiantes ($96,4 \pm 11$) y función social en el barrio San Alonso de Bucaramanga ($86,8 \pm 1$); también se observó en los varones una mejor calidad de vida que las mujeres. (Cáceres et al., 2018).

Finalmente, en el Perú para comprender la calidad de vida de la población que toma los servicios de salud se debe de conocer sus características, es así que se sabe que conforman Lima metropolitana en el 2024 supera los 9 millones de habitantes, es por esto que es considerada la ciudad más poblada del Perú de los cuales es 46% se encuentra en el nivel socioeconómico “C”; siendo la población adulta más de la tercera parte del total (CPI, 2023). La inversión en promedio en salud que realiza un poblador de Lima metropolitana es de \$41 en todos los

servicios, este monto no llegaría a cubrir un servicio de terapia física completo de forma particular u otro servicio que requiera (APEIM, 2021).

Las características socioeconómicas conocidas de los pacientes de Lima conlleva a que contemplen la atención de sus dolencias a través del uso de medicación oral u afines conseguidos en una farmacia de su zona, en una segunda instancia recién consideran la visita a un médico o especialista en los servicios del estado peruano, en esa ausencia de información predomina las costumbres que lleva a los pacientes a recurrir a los masajistas, hueseros, sobadores, quiroprácticos entre otras opciones de medicina complementaria cuyos resultados son variables ya hasta contraproducentes. Es decir, se deja al paciente a su suerte en la búsqueda de la solución a sus problemas de salud. (Bispo, 2022)

Las principales patologías identificadas que merman la calidad de vida son los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), solo al mes de enero del 2024 supera los 800 casos con tratamientos farmacológico (MINSA, 2024). Otras lesiones a las que está expuesto comúnmente el 93,02% de la población de Lima es el dolor musculoesquelético donde la afectación dolor en más de una zona es en el 75,97%, dolor lumbar 65,12%, dolor dorsal 47,29%, dolor en cuello 37,21% y dolor en codo/antebrazo 13,18%, se ha llegado a afectar sus actividades de vida diaria como el “subir y bajar escalones” 22%, “desplazarse” 9%, entre otros, en conclusión, afectan su vida diaria (Caballero, 2019).

Se conoce que a las patologías mencionadas son tratadas oficialmente por los servicios de salud a los que la población del Perú puede acceder mediante el Seguro Integral de Salud (SIS) son los que brinda el Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) en Lima, mientras que en provincias son las Gerencias Regionales de Salud (GERESA) todas estas gestionan la prevención, tratamiento y rehabilitación en sus establecimientos (MINSA, 2024).

El conocimiento de la calidad de vida en diversas zonas de Lima son un estudio realizado en La Molina, distrito de Lima, indica que la calidad de vida en la salud

de los adultos se vio afectada en el 67% por padecer dolor corporal (García.F, 2022). En el distrito de San Juan de Miraflores se identificó que el 75% de los adultos consultados refieren un nivel de regular a mala de la calidad de vida, siendo el género femenino el más afectado (Vargas y Lázaro, 2020).

En la zona de Los Olivos se halló que las condiciones sociales y económicos pueden generar una mala calidad de vida hasta en un 40% de los investigados (Cuba et al., 2013). Solo como dato importante en la región Junín, muy cercano a Lima, es frecuente la violencia familiar, depresión, consumo de alcohol y drogas. (Condezo y Quispe, 2022).

Finalmente, se ha hallado que de la calidad de vida de la población de Lima se conoce a pequeña escala y si se desea conocerla se debe recurrir a un servicio de salud que ofrece el estado peruano como es la especialidad de la terapia física y en ella analizar la calidad de vida considerando las características de sus pacientes, todo esto para dar un aporte sustancial a la Salud Publica peruana. Como menciona Cuba los profesionales de salud, en especial los del primer nivel de atención son los llamados a reconocer las características de su población atendida para orientar mejor sus abordajes y aportar en la mejora de la calidad de vida (Cuba et al., 2013).

1.1.2. Formulación del problema

Según lo expuesto en el apartado anterior se identifica que los problemas que se desean investigar son los siguientes:

1. Problema general

Sobre la base de los conceptos tratados previamente, el problema general de esta investigación se expresa en la siguiente pregunta general:

¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo a las características socioculturales de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?

2. Problemas específicos

Los problemas específicos de esta investigación son:

- ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo a la edad de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿Es diferente el nivel de calidad de vida de acuerdo al sexo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿El nivel de calidad de vida cambia de acuerdo con el nivel de instrucción de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿El nivel de calidad de vida se modifica de acuerdo con el nivel socioeconómico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿El nivel de calidad de vida difiere de acuerdo con el estado de trabajo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo con la carga familiar de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿El nivel de calidad de vida fluctúa de acuerdo con la procedencia de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿El nivel de calidad de vida cambia de acuerdo con la religión de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?

- ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo con las enfermedades preexistentes de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿El nivel de calidad de vida es diferente de acuerdo con el tiempo de enfermedades de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?
- ¿Es diferente el nivel de calidad de vida de acuerdo con el acceso al tratamiento médico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?

1.2. Determinación de objetivos

Los problemas identificados y que fueron expresados en las preguntas anteriores, serán abordados a través de los siguientes objetivos generales y específicos:

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general del presente estudios es el siguiente:

Determinar la variación del nivel de calidad de vida de acuerdo con las características socioculturales de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

1.2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos que permiten estructural la presente investigación son los siguientes:

- Examinar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a la edad de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Determinar las diferencias en el nivel de la calidad de vida de acuerdo al sexo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Comparar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al nivel de instrucción de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Evaluar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al nivel socioeconómico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Examinar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al estado de trabajo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Explicar la relación entre la carga familiar y el nivel de calidad de vida de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Identificar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a la procedencia de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Diferenciar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a la religión de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Interpretar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a las enfermedades preexistentes de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

- Analizar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al tiempo de enfermedades de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- Comparar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al acceso al tratamiento médico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

1.3. Justificación e importancia del estudio

En esta investigación se analizará el comportamiento de la calidad de vida y como ésta está relacionada con las características sociodemográficas de la población de Lima Metropolitana. Como menciona Coronel y colaboradores, las condiciones como el género, edad entre otras condiciones pueden condicionar la calidad de vida de los pacientes (Coronel et al., 2023).

Todas las teorías consultadas hablan que la calidad de vida es considera el aspecto subjetivo de cada persona, considera su realidad social, económica, emocional entre otros, información con la que no se cuenta en la población que se desea abordar (SalasC et al., 2013) (Pajares, 2015) (Nava, 2012) (Veenhoven, 2001) (Castro, 2009) (Leva, 2005) (Urzúa y Caqueo, Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto, 2012) (Suarez, 2021). Sin embargo, en la población limeña metropolitana aún no se dispone de información actualizada que permita comprender de manera integral estas dimensiones y su relación con las condiciones sociodemográficas. Por ello, esta investigación se justifica desde los planos **teórico, metodológico y social**, como se detalla a continuación.

1.3.1. Justificación teórica

Las revisiones bibliográficas realizadas en estudios nacionales e internacionales evidencian la importancia de la calidad de vida como indicador fundamental para la salud pública y el desarrollo de políticas sociales (Mayorga et al., 2019), No

obstante, la mayoría de investigaciones previas han abordado de manera parcial aspectos relacionados con la calidad de vida en poblaciones específicas o en determinados servicios de salud (Condezo y Quispe, 2022) sin considerar de forma integral su relación con las características sociodemográficas de los usuarios atendidos en el primer nivel de atención en los servicios de terapia física (Argumé y Alvarez, 2017) (Gonzáles et al., 2018) razón por la cual, resulta relevante realizar el presente trabajo.

En ese sentido, el presente estudio busca aportar evidencia empírica que complemente los marcos teóricos existentes, analizando las condiciones de calidad de vida de los individuos en función de variables culturales, educativas, laborales, clínicas y sociales. Esta información contribuirá al fortalecimiento del conocimiento científico y a la toma de decisiones en salud pública, al proporcionar datos relevantes sobre los determinantes sociales de la salud en Lima Metropolitana, particularmente en los servicios de terapia física y rehabilitación.

1.3.2. Justificación metodológica

La justificación metodológica se centra en el análisis del instrumento de calidad de vida sf-36. Al respecto es preciso mencionar que los instrumentos de evaluación de la calidad de vida son diversos (Misrach y Espinoza, 2005), algunos, divididos en dimensiones los cuales son cuantificados en puntajes o porcentajes. Es así que en esta investigación se empleará uno de los más usados en el medio científico como el sf- 36 el cual puntúa por cada dimensión en porcentajes y también de forma general este porcentaje encaja en una escala ordinal del tipo de calidad de vida (Barceló et al., 2021).

Este instrumento, compuesto por 36 ítems distribuidos en ocho dimensiones, permite obtener puntajes específicos y un índice global, los cuales pueden ser interpretados de manera continua o categórica. Sin embargo, algunos estudios han señalado inconsistencias en su estructura interna, especialmente en aquellas dimensiones que cuentan con un número reducido de ítems (González, 2014). Por tal motivo, se aplicará un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), con el propósito de validar el SF-36 en la población de Lima Metropolitana y determinar su ajuste

cultural y estadístico. Este modelamiento permitirá identificar la estructura factorial más adecuada, evaluando la consistencia interna y la validez del instrumento a partir de las respuestas recolectadas mediante una escala tipo Likert.

Para este fin se empleará una población representativa de toda la ciudad de Lima metropolitana (CPI, 2023), lo que permitirá analizar el comportamiento de las variables sociodemográficas y de calidad de vida en un contexto urbano diverso. De este modo, se generará una base de datos confiable que podrá ser utilizada en futuras investigaciones y en la elaboración de instrumentos adaptados a la realidad peruana, contribuyendo así a la mejora de la gestión en salud pública.

Con este fin, se aplicarán análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, además de procedimientos multivariados. En primer lugar, se calcularán frecuencias absolutas, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión para describir las variables sociodemográficas y los puntajes del SF-36. Posteriormente, se emplearán pruebas inferenciales no paramétricas y paramétricas, tales como la Chi cuadrado y ANOVA con el propósito de examinar las variaciones en los niveles de calidad de vida según edad, sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico, estado laboral, procedencia, religión, carga familiar, enfermedades preexistentes, tiempo de enfermedad y acceso a servicios de salud.

1.3.3. Justificación social

La justificación social de este estudio deriva de la necesidad de generar un potencial impacto que resulte de la información obtenida y que representará en forma real la calidad de vida y las características de la población de Lima metropolitana. Vale mencionar, sin embargo, que la región de Lima es escogida en esta investigación porque en ella está la tercera parte de la población peruana, tener los recursos con mayor prontitud y los centros de salud con mejores condiciones que resto del país (CPI, 2023).

Contar con un diagnóstico preciso del nivel de calidad de vida permitirá diseñar estrategias de intervención más efectivas y equitativas en el primer nivel de atención. Los resultados obtenidos serán de utilidad para las autoridades

sanitarias, instituciones académicas y organismos gubernamentales, al ofrecer una base empírica sólida para el diseño de programas y políticas orientadas a la promoción del bienestar.

En última instancia, mejorar la comprensión de la calidad de vida y sus determinantes contribuirá a optimizar los servicios de salud, reducir los costos derivados de enfermedades crónicas y fortalecer las acciones preventivas. Esto redundará en un sistema sanitario más eficiente y en una población con mayores niveles de bienestar y satisfacción general (Cuba et al., 2013), así como la creación de programas adecuados que acompañe y se adapte a la realidad de sus usuarios con el fin de tener mejores resultados que se traducirán en una mejor calidad de vida, un menor gasto en la salud y descongestión de nuestro sistema de salud por el control adecuado de las enfermedades con alta prevalencia.

1.3.4. Aportes en la investigación para la DIRIS Lima Centro

El presente estudio tiene como propósito fundamental brindar información actualizada y relevante sobre la población de Lima Metropolitana en la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, enfocándose en la evaluación de la calidad de vida y las características sociodemográficas que la determinan. A través de este análisis, se busca identificar cómo varían los niveles de calidad de vida en función de factores como la edad, el género, el nivel educativo, la ocupación, el estado civil y las condiciones socioeconómicas, entre otros. Esta información permitirá no solo comprender el panorama actual del bienestar de la población que recibe la atención de los servicios de terapia física de la DIRIS Lima Centro, sino también ofrecer una base sólida para la toma de decisiones en materia de salud pública, planificación social y desarrollo comunitario. De esta manera, el estudio contribuirá a visibilizar las brechas existentes y a proponer estrategias que mejoren la calidad de vida de los diferentes pacientes considerando sus determinantes sociales

Asimismo, los datos recopilados servirán para la validación del cuestionario SF-36 mediante la aplicación de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), con el objetivo de generar un instrumento ajustado a las particularidades culturales, sociales y lingüísticas de la población de Lima Metropolitana como el de la DIRIS Lima Centro.

La aplicación del estudio en centros de salud seleccionados aleatoriamente garantizará la representatividad de los resultados, abarcando tanto instituciones con personal contratado como aquellas con personal provisional como los SERUMISTAS. Esta diversidad permitirá obtener una visión más completa del contexto sanitario y social de estos servicios sin importar el tipo de personal lo está brindando, fortaleciendo la pertinencia del instrumento y su posible implementación en futuras investigaciones y evaluaciones sobre la calidad de vida en el ámbito metropolitano y nacional en el primer nivel de atención.

1.4. Limitaciones de la presente investigación

Considerando la complejidad del estudio, de las herramientas que se van a aplicar y de la población objeto de la investigación, las posibles limitaciones del presente trabajo son:

Limitación de muestra: La población proyectada para el estudio es más de 1000 personas por lo que se puede complicar el manejo de la muestra y como clasificarla, sin contar la asistencia de los pacientes que pueden ser inconstantes. La contingencia es el muestreo probabilístico aleatorio (Celis y Labrada, 2014) distribuido de forma equitativamente en proporción de los centros de salud y población que se atiende en cada uno de ellos, también se hará de forma coordinada con los fisioterapeutas de los centros de salud para entrevistar de forma aleatoria y no por elección de ellos a fin de no sesgar la información.

Limitación de datos: La investigación cuenta con un cuestionario de datos sociodemográficos que quizás sea muy sensible para algunos participantes y se nieguen o alteren las respuestas al contestar. La contingencia será la presentación del consentimiento informado (Romero et al., 2022) donde se detalla en que consiste el estudio y para que será usado sus datos, además de una aclaración en todo el momento que deseen consultar por parte del personal de recolección de datos.

Limitación de sesgo: En la investigación se puede obtener respuestas direccionadas a la calidad de atención ya sea de forma positiva o negativa

generando una indisposición del entrevistado con el encuestador. La contingencia será la presentación del consentimiento informado donde se detalla en que consiste el estudio, origen de los encuestadores (ajenos al MINSA), además de una aclaración en todo el momento que deseen consultar por parte del personal de recolección de datos.

Capítulo II: Marco teórico

2.1. Antecedentes de la investigación

Se ha realizado una revisión de estudios que preceden a este donde se expone realidades problemáticas muy similares al nuestro a nivel internacional como nacional

2.1.1. Internacionales

Las investigaciones de calidad de vida a nivel internacional de detallan a continuación:

En el estudio de Rada et al. el 2023, se buscaban la existencia de la calidad de vida relacionada con la salud en 500 chilenos. Rada empleó un estudio cuantitativo, analítico, transversal, observacional y psicométrico; la muestra fue de 500 chilenos de forma no probabilística a conveniencia aplicando instrumentos como EQ-5D-3L, instrumento de caracterización sociodemográfica y escala visual análoga. El tratamiento de los datos se da por promedios, desviación estándar, Chi cuadrado, CFI, RMSEA y SRMR. (Rada et al., 2023)

Los resultados hallados fueron un predominio de mujeres con un 68.08%, edad media de 36,36 años, 48,40% laboraba, nivel secundario 46,40%, sedentarismo de 65,60%, dolores musculoesqueléticos 29,40%, obesidad 22,40%, nivel de EQ-5D-3L sin problemas la movilidad 89,8%, autocuidado 96,8%, actividades diarias 93,6%, dolor 53,6% y ansiedad 52%; $\chi^2 = 6,992$, $p = 0,221$, CFI = 0,996, TLI = 0,993, RMSEA = 0,028 (IC90%: 0,000-0,073) y SRMR = 0,067. Por lo que se concluyó que el dolor y ansiedad son las dimensiones más comprometidas, los resultados psicométricos indican que existe un gran impacto en la calidad de vida (Rada et al., 2023).

Complementariamente, el equipo de investigadores de Oluwatoyosi et al en el 2023 en EE.UU., identificaron la relación de la gravedad del esguince de tobillo con el

nivel de la calidad de vida en jóvenes de 3 a 15 años. El estudio fue de cohorte donde incluyó a 50 adultos jóvenes (edad media, 23 años) con antecedentes de 3 a 15 años de un "esguince de tobillo significativo" (SAS) relacionado con el deporte juvenil. (Owoeye et al., 2023)

Los autores consideraron a la variable independiente principal fue la gravedad de la lesión, que se capturó en el índice de detalles de la lesión SAS a través de entrevistas. El SAS se definió como lesiones de ligamentos y otras estructuras intra/extraarticulares que interrumpieron la participación deportiva juvenil, al menos 3 días de pérdida de tiempo y requirieron consulta médica. El SAS grave se definió como SAS que involucraba >28 días de pérdida de tiempo, y el SAS no grave solo involucraba ligamentos del tobillo y/o con ≤28 días de pérdida de tiempo. (Owoeye et al., 2023)

Uno de los instrumentos empleador fue el cuestionario de puntuación de resultados del pie y el tobillo se utilizó para evaluar los síntomas y la función del tobillo. Se utilizaron estadísticas descriptivas y modelos de regresión lineal multivariable con el fin de examinar la relación entre la gravedad del SAS y los resultados, con el sexo y el tiempo desde la lesión como covariables. (Owoeye et al., 2023)

Los resultados que obtuvieron Oweye y colaboradores fueron en comparación con los participantes con SAS no grave, los participantes con antecedentes de SAS grave demostraron resultados significativamente peores en los síntomas [-18,4 (IC del 99 %: -32,2 a -4,6)], dolor [-10,1 (IC del 99 %: -19,2 a -1,1)] y calidad de vida [-17,1 (IC del 99 %: -33,1 a -1,1)] en modelos de regresión lineal multivariable. Se concluye que un esguince de tobillo grave con una pérdida de > 4 semanas de participación deportiva en el momento de la lesión se asocia de forma independiente con peores síntomas de tobillo, dolor y calidad de vida relacionada con el tobillo después de 3 a 15 años (Owoeye et al., 2023).

Por otra parte, Gribble et al. en el 2022 en EE.UU. realizaron un estudio que tuvo como meta examinar los marcadores de la salud general (dolor, actividad física e IMC) y la calidad de vida relacionada con la salud actual en una muestra

representativa de la población general con y sin antecedentes de esguinces de tobillo declarados por los propios pacientes. Utilizando un diseño de estudio transversal de una muestra aleatoria con 3.660 adultos, estos se encontraban entre los 18 y 80 años, se aplicaron instrumentos como la escala de Tegner, SF – 8. El análisis estadístico fue descriptivo, la prueba de Shapiro-Wilkes, Mann - Whitney U. (Gribble et al., 2022)

Los resultados obtenidos fueron unos 1.552 encuestados que informaron antecedentes de esguince de tobillo únicamente (esguince de tobillo; n = 553) o no informaron lesiones en la parte inferior del cuerpo (Control; n = 999). La altura y la masa fueron medidas estadísticamente diferentes entre los grupos, ya que los encuestados con esguince de tobillo mostraron mayor altura y masa que los controles. Los encuestados con esguince de tobillo informaron un IMC estadísticamente más alto, dolor general y peores puntuaciones en el SF-8 PCS que los controles ($p < 0,001$ para todos los resultados). (Gribble et al., 2022)

Se halló que no hubo diferencia estadística entre los grupos en la actividad física informada ($p = 0,27$) o puntuaciones SF-8 MCS ($p = 0,60$). Sin embargo, al examinar la significación clínica de las comparaciones entre grupos, las diferencias entre grupos en todos los resultados superaron los MDD lo que sugiere que los encuestados con esguince de tobillo tienen un IMC y un dolor general más altos, una actividad física menor y peores puntuaciones en SF-8 PCS y MCS que los controles no lesionados (Gribble et al., 2022).

Otro estudio destacado es el de Lorenzo en el 2022, tesis doctoral que busco determinar la prevalencia de la sarcopenia en pacientes con diagnóstico de fibromialgia y la relación con la calidad de vida en un hospital de Argentina a través de un estudio observacional, de corte transversal prospectivo aplicado en pacientes 79 pacientes entre 18 a 65 años mediante un muestreo no probabilístico a conveniencia. (Lorenzo, 2022)

Las variables empleadas por Lorenzo fueron la sarcopenia que fue medida por los criterios del consenso europeo de sarcopenia, el Impacto de la enfermedad en la

calidad de vida mediante el cuestionario de impacto de la fibromialgia; los datos fueron trabajados con una estadística descriptiva e inferencias mediante el Chi cuadrado. (Lorenzo, 2022)

Los resultados obtenidos fueron una media de 47,5 años, el 98% es femenino en los cuales presentan una sarcopenia probable, el IMC es de 27,05 puntos; FIQ con impacto severo >59 son el 55,38%, actividad física con una media de 22 y la intensidad de actividad física no realizada es el 53,85%; por otro lado, la fuerza muscular predominante es baja en menores de 30 años con un 80%; no existe relación entre impacto en la calidad de vida y alto porcentaje de masa grasa corporal ($p=0,443$), tampoco hubo entre impacto en la calidad de vida y fuerza muscular ($p=0,449$). En conclusión, los resultados indican una falta de relación y también hubo una reducción de la funcionalidad (Lorenzo, 2022).

En otra parte del mundo el investigador Terrens en el 2021 en Australia quien realizó un estudio anidado simultaneo con una prueba piloto simple ciego donde aplicó un tratamiento de fisioterapia acuática a 21 personas diagnosticados con Parkinson aceptado por el Comité de Ética en Investigación Humana de Peninsula Health (HREC) y del HREC de la Universidad de Monash; se midió las variables estudio mediante un Cuestionario de la enfermedad de Parkinson-39 (PDQ-39) y el Índice de bienestar personal en adultos (PWI). (Terrens et al., 2021)

En los resultados se logró identificar que predominaron las mujeres 81%, el 95% sintió que es un tratamiento adecuado, con un bienestar deficiente de 41.6 puntos calidad de vida de 31 puntos y un PDQ-39 con un 13,2, se visualizaron las barreras de los pacientes para ejecutar la terapia acuática, incluida la seguridad al vestirse, la fatiga y el transporte; por otro lado se visualizaron muchos facilitadores, incluida una mejora en la función, menos caídas y socialización en grupo (Terrens et al., 2021).

En Europa, Gálvez et al en el 2021, en España, realizaron un estudio donde se buscó la relación entre las condiciones sociodemográficas y la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus en una población de Badajoz; a través de una

metodología observacional descriptivo transversal en una muestra de 60 pacientes con diagnóstico de DM 1 y/o 2 (5 años mínimo de dx) de forma no pirobalística a conveniencia. La información fue recabada a través de un cuestionario de datos sociodemográficos, cuestionario Duke-UNC para los datos de apoyo social recibido, cuestionario de salud SF-36 con sus 8 dimensiones. (Gálvez et al., 2021)

Los resultados usaron porcentajes, medias, test Kolmogorov-Smirnov, t de Student, ANOVA y el coeficiente de Pearson ($p=0.05$). Los hallazgos fueron un predominio de mujeres 55%, edad media $68,67 \pm 11,09$ años, DM tipo 2 90%, CVRS es menos en damas que en varones FF $p = 0,014$, RF $p = 0,046$, DC $p = 0,010$, SG $p = 0,026$, RE $p = 0,047$, SM $p = 0,010$ y V $p = 0,023$. (Gálvez et al., 2021)

En los hallazgos, se detalla que existe una relación inversa entre la edad, años de diagnóstico, frecuencia de complicaciones, uso de fármacos y calidad de vida, a diferencia del colesterol, tensión arterial e IMC que no presentó relación alguna. Otra relación para destacar, es la significativa entre el apoyo social y CVRS. Condiciones económicas inadecuadas, falta de educación, ausencia de trabajo muestran bajos valores de CVRS (Gálvez et al., 2021).

En otro punto de Europa, Walter et al en el 2021 en Alemania investigaron el impacto de las infecciones relaciones de las fracturas de huesos largos con la CV. Esto se logró mediante un estudio descriptivo de tipo cohortes, retrospectivo; se analizaron 37 pacientes tratados entre noviembre de 2009 y marzo de 2019, que lograron erradicar la infección y lograron una consolidación ósea estable después de una FRI en huesos largos. (Walter et al., 2021)

En este estudio la calidad de vida se evaluó con el cuestionario de cinco dimensiones EuroQol (EQ-5D) y los instrumentos de resultados German Short-Form 36 (SF-36), así como con una clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE) -10 basada en la calificación de síntomas (ISR) y se comparó con datos normativos. Los datos obtenidos se calcularon estadísticas descriptivas para todas las variables, las variables continuas se expresaron como media y desviación estándar (DE), las correlaciones entre las

puntuaciones de los resultados y los datos demográficos se calcularon utilizando el coeficiente de correlación de Pearson de significancia de $p < 0,001$. (Walter et al., 2021)

Los resultados obtenidos fueron una edad de 4,19 años (DE 2,7) tras la última cirugía, la puntuación media del SF-36 fue de 40,1 (DE 14,6) en el componente de salud física y de 48,7 (DE 5,1) en el componente de salud mental, frente a los valores normativos alemanes de 48,4 (DE 9,2) ($p < 0,001$) y 50,9 (DE 8,8) ($p = 0,143$). El índice medio del EQ-5D alcanzó 0,76 (DE 0,27) con una puntuación media de la escala analógica visual (EAV) del EQ-5D de 65,7 (DE 22,7) en comparación con las puntuaciones de referencia de 0,88 ($p < 0,001$) y 72,9 ($p < 0,001$). (Walter et al., 2021)

Las puntuaciones medias del ISR no revelaron una carga significativa de síntomas psicológicos, mientras que un análisis individual mostró deterioros moderados a graves en el 21,6% ($n = 8$) de los pacientes. En conclusión, los pacientes indican una calidad de vida significativamente inferior en comparación con los de resolución pronta de las fracturas (Walter et al., 2021).

Otra investigación en España fue la realizada por Ausin et al en el 2020, quienes analizaron la relación entre Calidad de Vida y Variables Sociodemográficas, de Salud Física y Mental en mayores de 65 Años en la Comunidad de Madrid a través de un método descriptivo correlacional, participaron una muestra de 555 adultos mayores, esta muestra fue seleccionada al azar y está conformada por hombres y mujeres entre 65 y 84 años de edad. (Ausín et al., 2020)

Los instrumentos empleados en este estudio fueron la entrevista para las variables sociodemográficas, “Entrevista Diagnóstica Compuesta Internacional para personas mayores de 65 años” (CIDI65+) para los trastornos mentales y una versión reducida de la escala BREF de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud para evaluar la calidad de vida (WHOQoL-BREF) para la calidad de vida. Se realizaron análisis de medias, ANOVA y regresión lineal múltiple. Las

mujeres tienen peor calidad de vida que los hombres y la calidad de vida empeora con la edad. (Ausín et al., 2020)

El modelo de regresión para la variable dependiente donde “Escala WHOQoL BREF” explica el 41,43% de la varianza ($R^2 = 0,413$). Las variables que más impacto tienen en la CV son las siguientes: un mayor número de síntomas físicos y psicológicos, experimentar dificultades económicas y la presencia de algún trastorno psicológico, mientras se continúa trabajando tiene un efecto positivo en la CV. Los trastornos físicos y mentales tienen un impacto parecido en la calidad de vida. La presencia de un mayor número de síntomas psicológicos (sin necesariamente cumplir criterios de trastorno mental) es una variable predictiva de peor CV. La salud mental supone una carga para la calidad de vida de las personas mayores de 65 años que es tan poderosa como la salud física (Ausín et al., 2020).

Adicionalmente, en una investigación de Europa Fernández et al en el 2020, realizaron un estudio en la población adulta mayor en España donde se trató de identificar la fragilidad y calidad de vida en este grupo poblacional de Valencia; este fue un estudio descriptivo transversal empleando la “Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE)” aplicada a 4498 adultos mayores de 60 años, pero se consideró criterios de exclusión como “No residentes en España” ($n = 62595$) y “< 60 años” ($n = 1138$). (Fernández et al., 2020)

La estadística que emplearon los españoles fue un modelo de ecuaciones estructurales con el Chi cuadrado (χ^2). Los resultados fueron 46,1% hombres y el 53,9% mujeres; la media de edad fue 73,56 años (DT = 8,89). El 72,6% aún presentaba pareja y el 19,2% son viudos. La relación de la fragilidad con la movilidad es $p=0,87$, con el apetito $p=0,57$, fatiga $p=0,63$, actividades $p=0,58$, fuerza $p=-0,49$, calidad de vida $p=-0,63$ y salud percibida $p=-0,78$. RMSEA = 0,067 IC 90% [0,061-0,074], CFI = 0,977, SRMR =0,041. En conclusión, la fragilidad impacta de forma importante en la calidad de vida (Fernández et al., 2020).

En el medioriente, Lodhi et al en el 2019 en Pakistán, evaluaron la calidad de vida de la población general pakistaní y sus factores asociados mediante el instrumento

de calidad de vida WHOQOLBREF mediante un estudio transversal de base poblacional en los 52 Consejos de la Unión del Distrito Abbottabad, provincia de Khabar Pkutunkhua, Pakistán, entre marzo de 2015 y agosto de 2015. (Lodhi et al., 2019). (Lodhi et al., 2019)

En dicho estudio se empleó la técnica de muestreo por conglomerados de múltiples etapas. La calidad de vida se midió utilizando el instrumento validado WHOQOL-BREF, junto con preguntas socioeconómicas, demográficas y de capital social del Banco Mundial en este estudio de base poblacional. Los datos se recopilaban a través de hogares, utilizando entrevistas. La asociación entre las variables sociodemográficas y los dominios de calidad de vida se determinó utilizando análisis univariados y multivariados. Se derivaron estadísticas descriptivas y se logró una regresión lineal multinivel utilizando análisis regresivo que permitió obtener el modelo final para cada dominio para reconocer las variables que afectan la puntuación de calidad de vida. (Lodhi et al., 2019)

Para el estudio, incluyeron un total de 2063 participantes (51,2% hombres, 48,2% mujeres). Se obtuvo unos resultados donde la edad media de los participantes fue de 37,9 años, DE = 13,2; con un rango de 18 a 90 años. La puntuación media de los dominios de calidad de vida (física, psicológica, relaciones sociales y dominios ambientales) fue de 65,0 (DE = 15,2), 67,4 (DE = 15,0), 72,0 (DE = 16,5), 55,5 (DE = 15,0), respectivamente. En general, se estableció que el nivel socioeconómico es el predictor más fuerte de una peor calidad de vida para todos los dominios, ya que un cambio en el nivel socioeconómico de alto a bajo da como resultado una reducción de aproximadamente ($\beta = -5,85$, $\beta = -9,03$, $\beta = -8,33$, $\beta = -9,98$, $p < 0,001$). (Lodhi et al., 2019)

De manera similar, el tipo de residencia se asoció negativamente con los dominios físico, psicológico y ambiental, mientras que la edad y el sexo se asociaron negativamente con los dominios físico, psicológico y de relación en el modelo final. Además, el capital social ($\beta = 0,09$, $\beta = 0,13$, $\beta = 0,14$, $\beta = 0,15$, $p < 0,001$) tuvo un efecto positivo en la calidad de vida de los pakistaníes. En general, se encontró que

la calidad de vida subjetiva era baja en nuestra población y extremadamente variada según las variables sociodemográficas (Lodhi et al., 2019).

En Latinoamérica, Peña et al en el 2019 en Guerrero – México, realizaron un estudio cuantitativo, transversal y analítico a 75 adultos mayores de asilos cuya selección fue no probabilística, casas de día y localidades rurales cuyo fin fue descubrir la calidad de vida de los participantes por medio del Cuestionario sociodemográfico y Cuestionario de Salud SF-36 versión 2 española Health Survey. (Peña et al., 2019)

Los resultados mostraron que la mayoría de participante fue del sexo femenino 52%, en la edad predominante de 73 año, predomina la calidad de vida regular 61% en estado de salud y 52% en salud mental. Resalta que el 97,3% percibe que no cuenta con buena salud, el 71% indica que sus AVDs han sido afectados por sus dolencias físicas y/o emocionales. Lo cual nos indica que las condiciones de vida no son la adecuadas para esta parte del mundo por su condición alta de pobreza (Peña et al., 2019).

En otro lugar de Europa, Gobbens y Remmen en el 2019 en Países Bajos, realizaron una investigación de los efectos de los factores sociodemográficos sobre la calidad de vida de las personas de 50 años a más con sF-12, WhoQOI-BreF y WhoQOI-OLD con las asociaciones al sexo, la edad, el estado civil, la educación y los ingresos en una muestra de 1.492 holandeses de 50 años de edad en un estudio transversal; el análisis estadístico se da de forma descriptiva y la correlación de Pearson. Se aplicó los instrumentos de “Senioren Barometer”, sF-12, WhoQOI-BreF y WhoQOI-OLD. (Gobbenss y Remmen, 2019)

Los resultados obtenidos fueron que 900 (60,3%) eran hombres, la edad media fue de 69,5 años (rango 50-95 años, DE 7,8), y el 70,0% estaban casados o en convivencia, la mayoría de los participantes (44,4%) tenían un nivel de estudios correspondiente a la educación secundaria, y el 34,3% tenían un ingreso ,€2.000; todos los factores sociodemográficos en conjunto explicaron una parte significativa de la varianza de las puntuaciones de todos los dominios de calidad de vida, que

oscilaron entre el 5% y el 17% para el WHOQOL-BREF, el 5,8% y el 6,7% para el SF-12 y el 1,4% y el 26% para el WHOQOL-OLD. (Gobbenss y Remmen, 2019)

En este estudio, análisis estadísticos adicionales, mostraron que la autonomía estaba significativamente asociada con la salud física (WHOQOL-BREF), el dominio físico (SF-12) y las habilidades sensoriales (WHOQOL-OLD), representadas por coeficientes de Pearson de 0,52, 0,43 y 0,34, respectivamente. El género femenino y edad avanzada se relacionaron negativamente con 2 y 4 dominios de CV, respectivamente. Las mujeres casadas o cohabitantes y que tener una educación superior y un ingreso más alto se asociaron positivamente con seis, seis, 1 y 11 dominios de CV, respectivamente (Gobbenss y Remmen, 2019).

Por otro lado, en América Simón y Docherty en el 2018 en EE.UU., buscaron hallar la calidad de vida relacionada con la salud de los adultos de mediana edad con inestabilidad crónica del tobillo mediante un estudio transversal. Para ello 200 personas de 40 años o más se ofrecieron como voluntarias para participar en el estudio dentro de ello 75 personas fueron clasificadas con inestabilidad crónica del tobillo ($51,5 \pm 7,3$ años, $175,8 \pm 3,7$ cm, $86,5 \pm 18,9$ kg) y 125 clasificados como sin inestabilidad crónica del tobillo ($53,2 \pm 7,3$ años, $176,2 \pm 5,4$ centímetros, $81,3 \pm 17,6$ kg). (Simon y Docherty, 2018)

Los participantes completaron la Identificación de la inestabilidad funcional del tobillo como encuesta de inclusión y se siguieron las pautas del Consorcio Interno del Tobillo para clasificar a los individuos. Después de la encuesta de inclusión, los participantes completaron el Cuestionario de miembros inferiores de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos y el SF36 v2. Los resultados hallados indicaron que del cuestionario de miembros inferiores de la Academia de cirujanos ortopédicos y la puntuación del resumen del componente físico del Short Form-36 v2 fueron estadísticamente diferentes entre los grupos ($p < 0,05$). (Simon y Docherty, 2018)

En concreto, la diferencia media fue de 16,7 puntos y 12,3 puntos para el cuestionario de miembros inferiores de la Academia de cirujanos ortopédicos y la

puntuación del resumen del componente físico, respectivamente, y los participantes del CAI obtuvieron peores puntuaciones. Se pudo evidenciar que las personas con CAI mostraron una disminución en la calidad de vida relacionada con la salud genérica y una reducción en la función del tobillo (Simon y Docherty, 2018).

En otro estudio, Salaffi et al en el 2018 en México, referido al impacto de diferentes enfermedades reumáticas en la calidad de vida relacionada con la salud: una comparación con una muestra seleccionada de individuos sanos utilizando los valores de utilidad del cuestionario SF-36 y del EQ-5D y del SF-6D. Se incluyeron 2633 pacientes de una cohorte en curso. Las enfermedades reumáticas se clasificaron en cinco grupos diagnósticos: enfermedades reumáticas inflamatorias, trastornos del tejido conectivo, osteoartritis periférica sintomática, trastornos de los tejidos blandos y osteoporosis. (Salaffi et al., 2018)

Para la comparación los investigadores utilizaron 649 controles sanos. La calidad de vida relacionada con la salud se evaluó con la Encuesta de salud de formato corto 36 del Medical Outcomes Study (SF-36), el cuestionario EuroQol de cinco dimensiones (EQ-5D) y el cuestionario de formato corto de seis dimensiones (SF-6D). Los cinco grupos principales de enfermedades reumáticas, en comparación con las personas sanas, deterioraron significativamente los ocho conceptos de salud del SF-36 ($p < 0,0001$). (Salaffi et al., 2018)

Se encontraron resultados similares para EQ-5D y SF-6D. Los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias tienen un estado de salud autoinformado peor que aquellos sin artritis en todos los dominios de la vida, pero particularmente con respecto a las escalas que miden aspectos del funcionamiento físico o la movilidad, la limitación de roles debido a problemas de salud física y actividades habituales, y el dolor corporal. La artritis reumatoide tuvo el mayor impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud, seguida de la fibromialgia, las fracturas vertebrales debido a la osteoporosis, la osteoartritis de cadera y la esclerosis sistémica (Salaffi et al., 2018).

Por otro lado, un estudio muy representativo fue el de Svedbom et al en el 2018 en Australia, Austria, Estonia, Francia, Italia, Lituania, México, Rusia, España, el Reino Unido y los EE. UU, donde se estudió de la calidad de vida hasta 18 meses después de fracturas de baja energía de cadera, vértebras y antebrazo distal empleando los resultados del estudio ICUROS. Se planteó a través de un estudio observacional multinacional, los datos se recogieron en cuatro puntos temporales para cinco estimaciones puntuales de la calidad de vida dentro de las 2 semanas posteriores a la fractura (incluido el recuerdo previo a la fractura) y a los 4, 12 y 18 meses posteriores a la fractura. (Svedbom et al., 2018)

La calidad de vida se midió como valores de utilidad del estado de salud (HSUV) derivados del EQ-5D-3L. Se realizó un análisis de casos completo como caso base con los casos disponibles y la imputación múltiple realizada como análisis de sensibilidad. Se realizó un análisis multivariado para explorar los predictores del impacto de la fractura en la calidad de vida. De los resultados obtenidos 5456 pacientes fueron reclutados mediante muestreo por conveniencia, 3021 pacientes fueron elegibles para el análisis de caso base (1415 fracturas de cadera, 1047 fracturas de antebrazo distal y 559 fracturas vertebrales). (Svedbom et al., 2018)

La diferencia media (DE) entre HSUV antes y después de la fractura para fractura de cadera, vertebral y antebrazo distal se estimó en 0,89 (0,40), 0,67 (0,45) y 0,48 (0,34), respectivamente ($p < 0,001$ para todos los tipos de fractura). Dieciocho meses después de la fractura, los valores medios de HSUV fueron inferiores a los de antes de la fractura en pacientes con fractura de cadera (0,66 frente a 0,77). $p < 0,001$ y fractura vertebral (0,70 frente a 0,83) $p < 0,001$). (Svedbom et al., 2018)

Interesantemente se halló que la hospitalización y una mayor calidad de vida recordada antes de la fractura se asociaron con un mayor impacto en la calidad de vida para todos los tipos de fracturas. Se concluyó que las fracturas de cadera, vértebras y antebrazo distal implican una pérdida sustancial de la calidad de vida y, en el caso de los pacientes con fractura de cadera o vértebras, la calidad de vida se ve notablemente afectada durante al menos 18 meses (Svedbom et al., 2018).

En otro país Sudamericano, Comachio y colaboradores en el 2018, en Brasil, busco identificar la asociación entre la discapacidad, kinesiofobia, dolor, y calidad de vida en pacientes con dolor lumbar crónico. Para ello el estudio transversal incluyó a 132 pacientes con dolor de espalda crónico, con edades comprendidas entre 18 y 65 años. Los instrumentos para medir la kinesiofobia se evaluó mediante la Escala de kinesiofobia de Tampa, la intensidad del dolor se midió mediante la Escala de calificación numérica con un punto de corte mayor de 3 para la inclusión en el estudio, la discapacidad se evaluó mediante el cuestionario de Roland Morris, la calidad del dolor se evaluó mediante el cuestionario de McGill y la calidad de vida se evaluó mediante el cuestionario de calidad de vida SF-36. (Comachio et al., 2018)

Los resultados de este estudio son estadísticamente significativos, la edad promedio fue de 47,4 años, IMC 27,2, predomina los casados con 59%, el 73% usa medicamentos, la intensidad del dolor tiene una media de 7,7, la discapacidad tiene una media de 14 puntos. Se encontraron asociaciones débiles entre la kinesiofobia y la intensidad del dolor ($r = 0,187$), calidad del dolor (sensorial, $r = 0,266$; afectivo, $r = -0,174$; y total $r = 0,275$), discapacidad ($r = 0,399$) y calidad de vida física (emocional) $r = -0,414$). Los resultados sugieren que las correlaciones entre la kinesiofobia y la discapacidad y la calidad de vida son estadísticamente significativas (Comachio et al., 2018).

Complementariamente a las investigaciones europeas, Gobbens y Van en el 2018 en Países Bajos, realizaron un estudio de Asociaciones de factores ambientales con la calidad de vida en adultos mayores en un estudio transversal utilizando una muestra de 1.031 holandeses de 65 años o más. Los participantes completaron un cuestionario basado en Internet, el "Senioren Barometer.". Se formularon cuarenta y dos preguntas sobre factores ambientales y se evaluaron los dominios de la calidad de vida mediante el WHOQOL-BREF. Se construyeron siete escalas (que comprendían de 3 a 9 ítems) de entorno: vivienda, instalaciones, molestias, residentes, vecindario, mal olor/ruido y tráfico. (Gobbens y Van, 2018)

La edad media de los participantes fue de 73,4 años (desviación estándar = 5,8); el 66,8% eran hombres y el 71,1% estaban casados o convivían. Todos los dominios de calidad de vida (físico, psicológico, social, ambiental) se asociaron con al menos una escala ambiental. Vivienda, residentes y molestias se asociaron con 4, 3 y 2 dominios, respectivamente; calidad de vida ambiental ($F_2 = .25$) y efectos pequeños a medianos en los otros dominios ($F_2 = .047$ para lo social, $F_2 = .074$ para el psicológico, y $F_2 = .101$ para el dominio físico). Instalaciones, vecindario, mal olor/ruido y tráfico se asociaron solo con la calidad de vida ambiental (Gobbens y Van, 2018).

Otro estudio en Asia, es el de Vidyaniati y colaboradores en el 2018, en Indonesia, que buscaba la relación de la actividad de la artritis reumatoide y la calidad de vida. A través de un estudio un estudio analítico, descriptivo, diseño transversal que tomó datos primarios de pacientes con AR sometidos a tratamiento en la Clínica de Reumatología del Hospital Hasan Sadikin de febrero a mayo de 2015. Los datos del paciente incluyeron sexo, edad, estado civil, situación laboral, nivel educativo, estado serológico (RF y Anti-MCV), duración del diagnóstico, número total de medicamentos, número total de DMARD, puntajes DAS28-ESR y puntajes SF-36. (Vidyaniati et al., 2018)

La información recabada se analizó con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, seguida del análisis de correlación de Rank-Spearman. Los resultados mostraron que participaron 42 pacientes, con una edad media de 41 ± 12 años. La relación entre mujeres y hombres fue de 20:1, y la mayoría de los sujetos (73,8%) tenían un estado serológico positivo (RF y/o anti-MCV). La puntuación media de DAS28-ESR fue de 4,3, mientras que la puntuación media de SF-36 PCS fue de 39,8 y la puntuación media de SF-36 MCS fue de 48,2. (Vidyaniati et al., 2018)

Con base en el análisis de Rank-Spearman (IC del 95%), hubo una correlación entre la puntuación DAS28-ESR y la puntuación SF-36 PCS, con un coeficiente de correlación (r) de $-0,577$ ($p < 0,001$), también hubo una correlación entre la puntuación DAS28-ESR y la puntuación SF-36 MCS con un r de $-0,368$ ($p = 0,008$). Por lo que concluyeron que existe una fuerte correlación negativa entre la actividad

de la enfermedad y el componente físico de la calidad de vida, y una correlación negativa moderada entre la actividad de la enfermedad y el componente mental de la calidad de vida, y las dos correlaciones fueron estadísticamente significativas (Vidyaniati et al., 2018).

En otro punto de Sudamérica, Ulloa en el 2017 en Quito – Ecuador realizó un estudio descriptivo correlacional que contó con una muestra de 163, de los pacientes diagnosticados con parálisis facial atendidos entre el 2015 a 2017 donde se deseaba conocer la influencia de la fisioterapia en la calidad de vida a través de un tratamiento. El estudio es de enfoque cuantitativo, observacional, descriptiva, diseño experimental. (Ulloa y Tipán, 2017)

Ulloa y Tipán aplicaron una encuesta a los participantes y lo hallado fue que los logros de la fisioterapia para su patología son predominantemente de poco a medianamente con un 50%, lo cual conlleva a las personas a identificar que el servicio de terapia física contribuye en un 55.21% de forma positiva en su calidad de vida. La atención recibida es percibida como buena en un 55%. El análisis inferencial por el método Chi-Cuadrado indica que la fisioterapia genera un impacto en la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con parálisis facial con un $\chi^2 102,38 > 7,81$ ($p = 0.05$) (Ulloa y Tipán, 2017).

Finalmente, a nivel internacional Borda et al. en el año 2017 desarrolló un estudio analizando el dolor en el adulto mayor, la CV, funcionalidad y factores asociados en Colombia, fue un estudio transversal donde participaron 2000 personas hallada con probabilística por conglomerados (cobertura del 81.9%). La «Presencia de dolor» se relacionó con los factores sociodemográficos, la autopercepción de salud, las comorbilidades, el estado funcional, el estado cognoscitivo y la calidad de vida, esta última estimada con la Escala visual analógica del grupo EuroQOL. (Borda et al., 2016)

Los resultados fueron un predominio de mujeres (63,4%); la edad media fue 71,17 (DE = 8,05), con mayor frecuencia de individuos de 60 a 69 años (48%). Se encontraron una relación significativa en el grupo que presenta dolor ($P < .001$) en

la escala de funcionalidad y en la de calidad de vida EQ-VAS. Las asociaciones más fuertes con el dolor fueron: enfermedades articulares (OR: 3,08 [2,24-4,23]), depresión severa (OR: 2,80 [1,63-4,79]) y deterioro funcional de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) (OR: 2,45 [1,31-4,58]). Se concluye que el dolor impacta negativamente en la independencia funcional y la percepción de la calidad de vida, predisponiéndolos a resultados adversos (Borda et al., 2016).

2.1.2. Nacionales

Las investigaciones de calidad de vida a nivel nacional de detallan a continuación:

La primera investigación es el de Lima (2021) donde quiso hallar el nivel de calidad de vida de 56 pacientes de un centro de fisioterapia en Carapongo - Lima a través de un estudio transversal, cuantitativo – descriptivo empleando el cuestionario sf-32 con preguntas cerradas. La selección de estos participantes fue de forma censal hallándose el 57,1% de mujeres y 42,9% de varones. Los resultados fueron predominantes fueron de calidad regular en las dimensiones de salud mental 26,4%, rol físico 35,7%, dolor corporal 31,25% y función social 34,8%; el nivel de calidad buena se observó en la dimensión de función física y rol emocional con 48.3% y 50%; la mala de calidad de vida corresponde a las dimensiones de salud general 17,5% y vitalidad 21,4% (Lima, 2021).

Otra investigación realizada en la capital peruana es el de León, pues en su estudio en el 2019 en Perú busco conocer los niveles de calidad de vida en adultos mayores que frecuentan un taller privado de salud en el Rímac. Esto se desarrolló mediante un estudio descriptivo, cuantitativo, no experimental - transversal; los instrumentos empleados fue el SF-36 aplicado a 80 adultos mayores de un muestreo no probabilístico. (León, 2019)

Los resultados indicaron un predominio de personas viudas 33,1%, sin ocupación 31,9%; en cuanto a las dimensiones de función básica predomina el nivel bajo con 90%, rol físico con nivel bajo de 61%, dolor corporal con nivel bajo con 85%, salud general con nivel bajo con 87%, vitalidad con nivel menos con 98%, función social

con nivel bajo con 72%, salud mental con nivel bajo con 96%, finalmente de forma general el 60% presento un nivel bajo de calidad de vida con valores más altos en mujeres en varones (León, 2019).

Una investigación adicional y cerca a Lima es la de Jáuregui quien, en el 2019 en su estudio no experimental, descriptivo - transversal aplicado en a 65 adultos mayores de Palpa y 30 adultos mayores de Nasca del Programa Gerontológico Social de Ica – Perú busco conocer el nivel y características de la calidad de vida de los participantes mediante el Cuestionario de Salud SF-36 con preguntas cerradas. En Nasca se obtuvo que el 90% tiene calidad de vida alta en la dimensión de salud mental, en Palpa se observó que el 60% presenta calidad regular en vitalidad, 81,5% alta calidad en salud mental, 63.1% calidad baja en rol físico, y se resume que presentan una calidad de vida alta. Por lo tanto, el programa tiene entre sus pacientes calificados como alta calidad predominantemente (Jáuregui, 2019).

Por otro lado, Caycho et al en el 2019 en Perú, buscaron identificar la relación del funcionamiento cognitivo, comportamental y la calidad de vida mediante un estudio correlacional. Los adultos mayores analizados fueron 51 varones y 42 mujeres de 65 a 88 años elegidos por un muestreo aleatorizado simple. Los instrumentos aplicados fueron la batería de procedimientos para adultos mayores (CLIFTON) y la escala de calidad de vida de Olson. Los resultados indican que existe una relación significativa entre las medias de funcionamiento cognitivo, comportamental y la calidad de vida ($p < 0,01$ y $r > 0,20$). (Caycho et al., 2019)

Por otro lado, también se halló una incapacidad física para realizar AVD, relaciones, comunicación y entorno social tienen una relación con niveles de calidad bajo. También es importante resaltar que las dimensiones incapacidad física (IF) y psicomotricidad (PM) ($F=21,771$; $p<0,000$) es decir poseen la capacidad de generar una varianza en la calidad de vida del 31,1%. Se concluye que el funcionamiento cognitivo y comportamental tienen una fuerte relación con la autonomía e independencia, mientras que las condiciones ambientales llegan a generar estrés indisponiendo al adulto mayor frente a cualquier patología con una respuesta adecuada (Caycho et al., 2019).

Otro estudio peruano es el de Argumé y Alvarez en el 2017 quienes realizaron un estudio en que se evaluó la calidad de vida en los adultos que presentaban dolor lumbar crónico que recibieron una atención fisioterapéutica de ejercicios en el agua. Esto se realizó por medio de un estudio observacional y longitudinal con una aplicación de pre y post test. La muestra se dio de forma no probabilística a conveniencia. El instrumento aplicado fue el SF – 36. El tratamiento de los datos se da por medidas de tendencia central, dispersión, prueba de Saphiro Wilk y la prueba de Wilcoxon. (Argumé y Alvarez, 2017)

Los resultado de las 13 personas evaluadas indican que el 92,3% son mujeres, la edad media de fue de 71 años, el 53,8% presentaba un peso normal, la dimensión función física subió de 59,2 a 68,8, el rol físico de 46,2 a 73,1, dolor corporal de 51 a 73,8, la salud general de 54,2 a 60,8, vitalidad de 56,5 a 71,2, función social de 66,3 a 76,9, rol emocional se mantuvo en 84, 6 y la salud mental de 65,8 a 77,5; por otro lado la puntuación media general de SF-36 subió después de la aplicación del programa de 46,1 a 73,1. Por lo que se concluye que el programa propuesto si mejora la calidad de vida (Argumé y Alvarez, 2017).

Finalmente, Hernández et al en el 2016 en Perú, desarrollaron un estudio que buscó identificar la calidad de salud de dos poblaciones rural y urbana de adultos mayores, para ello realizaron un estudio transversal aplicado a 4 distritos de zona rural y 4 de zona urbana entre los años 2014 – 2016. Los instrumentos empleados fueron el WHOQOL-BREF y WHOQOL-OLD. Los datos fueron analizados por una regresión lineal simple y múltiple, la prueba de chi cuadrado y la suma de rangos de Wilcoxon. (Hernandez et al., 2016)

Los resultados hallados en los 447 adultos mayores fueron de que tenían una edad media de $69 \pm 6,46$ años, 207 pertenecían al área rural donde predominantemente trabajaban y nivel de educación menor, mientras tanto en la población adulta mayor del área rural presentó calidad de vida con mayor puntaje en las dimensiones física ($p < 0,001$) – psicológico ($p < 0,001$) - medioambiente ($p < 0,001$) del WHOQoL-BREF, del mismo modo con niveles altos del WHOQoL-OLD de las dimensiones

habilidades sensoriales ($p<0,001$) – participación total ($p<0,001$) – actividades ($p<0,001$). Se concluyó entonces, que la zona de vivienda influye sobre la calidad de vida y está a su vez sobre la salud de la población adulta mayor por lo que los que viven en el área presentan mayor calidad de vida en la mayoría de las dimensiones (Hernandez et al., 2016).

2.2. Bases teóricas

En general, es sabido que el objetivo de la atención sanitaria y la medicina preventiva es mejorar la salud. (Aliaga et al., 2016). En los últimos 50 años, ha habido un creciente reconocimiento entre los investigadores y los médicos que la medición integral de los resultados de salud incluye una combinación de la esperanza de vida y la calidad de vida relacionada con la salud durante los años previos a la muerte (Castell et al., 2021).

La medición son los informes de los pacientes sobre el funcionamiento y el bienestar en los dominios físico, mental y social de la vida (Gribble et al., 2022). El funcionamiento incluye el funcionamiento físico, como el cuidado personal (p. ej., bañarse, vestirse, caminar); el funcionamiento de roles, como las actividades relacionadas con el trabajo (ya sean remuneradas o no) como las tareas domésticas y la carrera; y el funcionamiento social, el grado en que uno es capaz de interactuar con familiares y amigos. El bienestar es más subjetivo que la funcionalidad e incluye felicidad, tristeza, depresión o ansiedad (bienestar emocional), dolor y letargo (Kaplan y Hays, 2022).

2.2.1. Desarrollo histórico

El desarrollo del concepto de calidad de vida se remonta a los años 30 y se ha ido adaptando a las corrientes y disciplinas que la adoptaron a su necesidad, en el presente apartado se detalla esta evolución (Verdugo et al., 2013); también para comprender como es considerada la calidad de vida en el sistema de salud peruano se hace un pequeño recuento de esta situación sanitaria.

- **El concepto de “Calidad de vida” y su evolución**

El termino de “Calidad de Vida” al parecer está presente los años 30, fue mencionada por Arthur Pigou en su libro “The Economics Of Welfare” donde menciona a la calidad de vida como una cuantificación de un “producto social marginal neto” (Ramírez et al., 2020)

Después de la segunda guerra mundial la ONU propone evaluar las condiciones sociales de los países a través del “Nivel de vida” como un indicador de las necesidades globales de una población considerando las psicológicas y biológicas, así como las características socioeconómicas y ambientales (Tonon, 2009).

Para el año 1961 la ONU genera una clasificación de los 12 componentes del “bienestar social” doce componentes: salud, educación, condición laborar, vivienda, transporte, ahorro y consumo, alimentación, vestimenta, vivienda, situación de empleo, libertades humanas y entretenimiento (Salas y Garzón, La noción de calidad de vida y su medición, 2013).

A partir de los años 90” la calidad de vida se mide por dimensiones y es la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien la define como "La percepción de los individuos de su posición en la vida en el contexto de los sistemas de cultivo y de valor en el que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares, y preocupaciones. Es un concepto de amplio alcance que refleja en una manera compleja la salud física de la persona, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, y su relación con características más destacadas de su entorno" (WHOQOL, 1995).

En el año 1995 se crea la “International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS)” como una institución cuyo objetivo es investigar la calidad de vida a nivel mundial considerando a diversos campos disciplinarios como la política, sociología, psicología, medicina entre otros (Campbell et al., 1976).

Para el año 1997 el autor Casas fundó el “Instituto de Investigación sobre la Calidad de Vida” (IRQV) en la Universidad de Girona (España) donde se estudia constantemente el Bienestar Psicológico y calidad de vida (Tonon, 2009). Casas define que la calidad de vida son las “aspiraciones, percepciones, satisfacciones, necesidades y representaciones sociales” de cada persona con respecto a su entorno social (Tonon G y Castro, 2012).

Culmins en 1998 refiere que la calidad de vida es de carácter objetivo y subjetivo en su obra “Quality of Life Definition and Terminology: A Discussion Document from the International Society for Quality of Life Studies” (Tonon, 2009). En estos mismos años se agrega el concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en los estudios de Stineman y Cols dirigiéndose a los pacientes que presenten alguna patología (Ruidíaz y Cacante, 2021). Lawton en el 2001 propone que la calidad de vida es una “Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental de un individuo” (Urzúa y Caqueo, Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto, 2012).

Para las últimas décadas se han enfocado en darle nuevas definiciones, así como hallar los instrumentos más adecuados para su valoración, siempre rigiéndose de las instituciones como la OMS, ONU, entre otros (Bautista, 2017). Además de ser una terminología adoptada por la salud pública y ética médica ya que buscan ser consideradas en todos los tratamientos médicos con el fin de garantizar la integridad de los pacientes (Cardona y Agudelo, 2005).

- **Acciones del estado para mejorar la calidad de vida del peruano en el primer nivel de atención**

La política Nacional Multisectorial de Salud hacia el 2030 tiene dentro de sus intereses mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en la población infantil y adolescente se ha presentado el “Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA). Se indica que ha habido una mejora significativa en la calidad

de vida en las familias del interior del país, pues a través de la teleatención se ha reducido la brecha de la distancia. (Carbone, 2023)

En el Perú el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud es un documento técnico referencial propuesto por el Ministerio de Salud donde uno de sus ejes temáticos es la “Actividad Física” (AF) que considera mantener los dominios de Transporte, recreación, domestico, ocupacional y escuela en buenas condiciones (MINSA, 2024). Las estrategias alienadas con a este eje temático es la comunicación y educación para la salud junto a la Intersectorialidad. Los programas que se ejecutarían son Programa de Familias y Viviendas Saludables, Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas y Programa de Municipios y Comunidades Saludables (MIINSA, 2008)

En la actualidad el Estado peruano se encuentra en la etapa del Aseguramiento Universal en Salud para asegurar el acceso de la población en su totalidad a los servicios de salud, hay dificultades con las coberturas. Para el primer nivel atención se ha presentado un documento técnico “La Salud Integral Compromiso de Todos: El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).” (Salud Sin Limites Peru, 2012)

Es así como, las atenciones en el primer nivel se agrupan por servicios y programas presupuestales como Salud materno neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades metaxenicas y zoonosis. Además, incluye, Enfermedades no transmisibles, Prevención y control del cáncer, Reducción de vulnerabilidad; seguida de la atención de emergencias por desastres, Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médica, Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. Terminando con, el Control y prevención en salud mental dentro de los cuales está presente la terapia física a través de la atención de sus pacientes y discapacitados mediante la “Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC”, luego de ello no es encuentra mapeada la intervención de esta especialidad en estos programas (Ministerio de Salud;, 2024)

Una de las poblaciones vulnerables son los adultos mayores, el MINSA a través de su programa Taita Wasi atención multidisciplinaria a la persona adulta mayor con atención médica, nutricional, odontológica, terapia física, laboratorio y farmacia; en sus centros de salud u hospitales cuentan con “clubes de adulto mayor” en el cual se promueve actividades integrales preventivas – promocionales. Essalud a través de sus programas dentro de sus hospitales de “Adulto mayor” y PADOMI brindan atención a esta población. (MINSAA, 2019)

Por otra parte, las fuerzas armadas y policiales tienen sus Hospitales de día geriátrico (HODIGE) y de Atención domiciliaria (ADOGE). Una de las instituciones paralelas al MINSA son el Centro Integras del Adulto Mayor (CIAM), esta es una institución donde las municipalidades de distritos y provincias brindan atención a los adultos mayores con actividades recreativas, enseñarles actividades económicas para su independencia, atenciones nutricionales, psicológicas y fisioterapéuticas a modo de cubrir las necesidades de esta población. (Casas et al., 2016)

2.2.2. Fundamentación teórica

La calidad de vida es un concepto que se basa en varias teorías y múltiples estudios, en este apartado se desarrollará teorías y modelos de la calidad de vida:

Modelo de capacidades de Amartya Sen

Amartya Sen en su teoría se centra en los funcionamientos y las capacidades, estos conceptos tratan de explicar cómo las condiciones sociales como la pobreza, falta de desarrollo humano, desigualdad, injusticia y la calidad de vida generan un impacto negativo en el estado de bienestar de la persona (Sen y Nussbaum, 1993).

Este impacto no se centra en las necesidades básicas si no en la capacidad de la libertad de hacer su voluntad la alcanzar sus metas o de ser una persona con identidad. El concepto de “las capacidades” desde la óptica de Sen supera en entender que todos somos iguales por lo que en 1979 propone el término de “igualdad de capacidad básica” y propone su uso para el área de salud, políticas

públicas, educación, filosofía, desarrollo humano y ética. Define que los funcionamientos son importantes para analizar el bienestar de la persona y las capacidades evalúan las posibilidades (Anand et al., 2005). La presente teoría aporta a nuestro estudio la importancia de estudiar las condiciones de vida o las características de una persona para conocer su calidad de vida ya que intervienen los funcionamientos y capacidades (Unquijo, 2014).

La teoría homeostática del bienestar

Esta teoría del bienestar fue propuesta por Cummins a inicios del 2000 en donde adaptó el término “homeostasis” que es usual en la biología (Arita, Satisfacción por la vida y teoría homeostática del bienestar, 2005).

En sus fundamentos, las respuestas del entrevistado durante su evaluación son una expresión de su estado de bienestar subjetivo en forma general, la satisfacción de vida y su mecanismo de autorregulación que emplea como un sistema de equilibrio que siempre está alterado por exterior y sus variaciones. Este mecanismo siempre tiene un objetivo positivo y es personalizado al individuo. Esta teoría le da soporte a la “satisfacción con la vida” la cual es una autoevaluación del bienestar subjetivo consideran en cierta parte como una dimensión de la “calidad general de su vida”. La presente teoría aporta a nuestro estudio la importancia de comprender las condiciones de vida o las características de una persona, pues estas son parte de las herramientas que tiene el ser humano para responder a su entorno y cuantificar su calidad de vida. (Ortigosa, 2024).

Modelo multidimensional de calidad de vida

Este modelo tuvo su origen en 1997 donde Schalock propone el enfoque del modelo con un carácter multidimensional. Definiendo a las dimensiones como un “grupo de factores” que son parte del bienestar personal, son tomados como indicadores de medición del nivel de calidad de vida, realmente se considera que lo que refiera en entrevistado son sus percepciones, condiciones específicas o conductas (Verdugo et al., 2013).

Llegaron a determinar ocho dimensiones con sus divisiones: Bienestar Emocional; Relaciones Interpersonales; Bienestar Material; Desarrollo Personal; Bienestar Físico; Autodeterminación; Inclusión Social y Derechos. El presente modelo aporta

a nuestro estudio la importancia de comprender que las respuestas que nos brinden los entrevistados sobre las dimensiones e indicadores de su calidad de vida deben ser correctamente interpretados para cuantificarlos (tabla 1) (Shalok y Verdugo, 2003).

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de la calidad de vida según Schalock

Dimensión	Indicadores
Bienestar Emocional	Esta dimensión mide: • Satisfacción: sensación de tranquilidad. • Autoconcepto: sentirse seguro. • Ausencia de estrés: no estar nervioso.
Relaciones Interpersonales	Esta dimensión mide: • Interacciones: Relación con distintas personas, poseer amigos y llevarse bien con su entorno. • Relaciones sociales: Tener amigos claramente identificados, entre ellos también está la pareja. • Apoyos: Contactos sociales positivos y gratificantes.
Bienestar Material	Esta dimensión mide: • Estatus Económico: le permite acceder a un estilo de vida. • Empleo: le permite recibir un salario o ingreso constante. • Vivienda: son las posesiones que tiene o carece.
Desarrollo Personal	Esta dimensión mide: • Educación: la capacidad de acceder a nuevos aprendizajes y tecnologías • Competencia Personales: es la conducta adaptativa. • Desempeño: es la destreza que muestra en sus actividades.
Bienestar Físico	Esta dimensión mide: • Salud: poseer hábitos de salud adecuada • Actividades de la vida diaria: es lograr realizar todas sus actividades de forma independiente. • Atención Sanitaria: acceso a los sistemas de salud. • Ocio: la realización de actividades ajenas al trabajo o responsabilidades.
Autodeterminación	Esta dimensión mide: • Autonomía: puede realizar actividades por iniciativa propia. • Control Personal: control de emociones y situaciones. • Metas: tiene trazada sus horizontes. • Valores Personales: tiene claro los valores que lo conducen. • Elecciones: capacidad de elegir sin coacción alguna.
Inclusión Social	Esta dimensión mide: • Integración y Participación en la comunidad: facilidad de pertenecer a un grupo social. • Roles Comunitarios: puede realizar una acción dentro de una comunidad y se identifica con ello. • Apoyos Sociales: es parte de los que pueden asistir así como ser asistidos.
Derechos	Esta dimensión mide: • Derechos Humanos: tiene claro los derechos los respeta y se hace respetar. • Derechos Legales: entiende las reglas de una sociedad y se adapta.

Nota: Fuente propia adaptada de (Shalok y Verdugo, 2003) (Verdugo et al., 2013)

Teoría hedonista

Esta teoría parte del utilitarismo donde trata de comprender a la felicidad y para ello emplea el hedonismo donde resalta la sensibilidad, indica que para tener una buena vida “no debe llevar a no reducirla a la cualidad y la calidad de la conciencia psicológica” (Pajares, 2015). Para definir su calidad de vida y medirla las personas recurre a las experiencias conscientes vivida de amor, felicidad, placer, disfrute y la satisfacción de los deseos o disfrute (Nava, 2012) (Salas et al., La noción de calidad de vida y su medición, 2013). Las experiencias previas en la medida que sean positivas crean una calidad de vida valiosa (Cardona y Agudelo, 2005).

Teoría de la satisfacción de los deseos

Esta teoría indica que la persona puede llegar a obtener la satisfacción a través de vivencias o experiencias en situaciones u objetos mientras tenga un buen estado de conciencia, esta condición se denomina “bienestar” (Nava, 2012) (Salas et al., La noción de calidad de vida y su medición, 2013). También se conoce que esta teoría va realizando ajustes para “corregir preferencias” que se ven afectadas en informaciones incorrectas, es decir al final persona elige lo que le hace más feliz, por ello la calidad de vida se ajusta a sus expectativas logradas o aún pendientes (Cardona y Agudelo, 2005).

Teoría de una buena vida

En esta teoría la persona realiza “ideales específicos, explícitamente normativos como la autodeterminación o autonomía”, todos los componentes que emplee el sujeto aportaran a cuantificar la calidad de vida, ya que mide las capacidades de las personas para escoger un tipo de vida entre otras opciones (Nava, 2012) (Salas et al., La noción de calidad de vida y su medición, 2013).

Esta teoría no solo se enfoca en las capacidades positivas que presenta la persona como la autodeterminación o autonomía, también considera las ideas de limitaciones que la persona considera para lograr la felicidad o satisfacción (Cardona y Agudelo, 2005). Según las dimensiones de la calidad de vida el termino de “buena vida” también se le puede conocer como “vida llevadera” o “capacidad para vivir” (Veenhoven, 2001).

Teoría de la comparación social

Esta teoría indica que los individuos toman sus características y estándares de vida para analizar su situación, si no la encuentra muy agradable o se siente satisfechos emplea las comparaciones sociales de forma selectiva; emplea las figuras de personas con condiciones no favorables o “hacia abajo” mediante una práctica activa o pasivamente con acciones donde “denigran” a los demás para acrecentar para sentirse superior mediante palabras o acciones (Castro, 2009).

Para realizar la comparación toman las características de su salud, deseos a futuro, sistema de afrontamiento; el resultado de la comparación puede generar cambios en la autoevaluación, cambios de humor, satisfacción personal y estrategias de afrontamiento de forma subjetiva (Nava, 2012).

Teoría de la subjetividad

Esta teoría sustenta que las personas para comprender su vida y compararse emplea la construcción de ideas subjetivas basadas en su realidad, vivencias y vida personal, esto genera una imagen de sí misma y la compara con realidades “mejores” o “peores” (Nava, 2012). Al contar con lo que las personas externalizan le transfieren en la interacción con la persona puede que altera las preferencias y autonomías de las personas (Leva, 2005) (Urzúa y Caqueo, Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto, 2012)

Teoría de la observación de la propia vida y de la propia realidad

Esta teoría nos indica que las personas o un grupo poblacional luego de haber realizado el proceso de comparación empleando la subjetividad cognitiva o emocional, recién emite un juicio de su bienestar personal o conocida como calidad de vida, de esta teoría parte la teoría de la actividad (Nava, 2012) (Suarez, 2021). Entonces se puede decir que una buena calidad de vida para una persona es cuando ha logrado sus metas y ambiciones, mientras que si estas no se logran y se siente inferior a su entorno sentirá que su calidad de vida es mala (Agüero, 2019).

La teoría de la actividad

Definir esta teoría es un poco compleja porque no se enfoca en la persona si no en la acción ejecutada, para ello si considera los componentes subjetivos como “factores personales, las diferentes concepciones de actividad, las historias de cada persona” (Nava, 2012). Esta teoría indica que los elementos de evaluación de la calidad de vida como la felicidad, satisfacción, el bienestar; además de considerar los ingresos económico y el acceso a los recursos (Suarez, 2021). Por tanto, para definir una buena calidad de vida se debe considerar un buen ingreso económico que le permita cubrir sus necesidades (Agüero, 2019).

Teoría de la Calidad de vida según Maslow

En el año 1991 Abraham Maslow organizó las necesidades humanas en una pirámide, la cual la persona va escalando según lo que vaya adquiriendo y logre estar satisfecha. El orden inicia la necesidad fisiológica (alimentación, respirar, acceso al agua), continúa con la necesidad de seguridad, prosigue la necesidad de aceptación del entorno social (amistad, cariño, amor y pertenencia), en la siguiente escala es la necesidad de autoestima (autorreconocimiento, confianza prestigio, respeto) y finalmente esta la necesidad de autorrealización (logros, crecimiento personal, dar lo que uno es capaz) (Suarez, 2021). Esta clasificación considera el “Hacer”, “Tener” y “Ser” de una persona (Escobar y Osuna, 2013).

Dimensiones de la calidad de vida

Todas las teorías expuestas dieron paso a la definición de diversas dimensiones que dependerán de factores materiales y ambientales (Urzúa y Caqueo, Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto, 2012). Las dimensiones conocidas son: Bienestar emocional, Bienestar físico, Relaciones entre personas, Desarrollo personal, Bienestar material, Autodeterminación, Derechos, Inclusión social. Según el Análisis multidimensional considera como dimensiones a los mencionados más la Plena inclusión (Nava, 2012). Cada evaluación de la calidad de vida tiene su propia clasificación de dimensiones, pero casi todas parten de las descritas en este párrafo. (SalasC et al., 2013)

2.2.3. Marco conceptual

Los modelos y teorías expuestas en el apartado anterior son la base de lo que se conoce como la calidad de vida, seguidamente, en este apartado, se desarrolla el concepto, así como las variables de control y lo que conoce de su interacción.

- **Calidad de vida**

La definición del concepto de “calidad de vida” contempla al total de los aspectos de nuestras vidas en los ámbitos donde vivimos, trabajamos, estudiamos, es decir donde realizamos nuestras Actividades de vida diaria (Ambriz et al., 2015). Cuando se relaciona a la calidad de vida con la salud comprenden aquellas dimensiones que son afectados por problemas de salud (Misrach y Espinoza, 2005). Vera indica que ‘Calidad de vida’ es una “expresión lingüística” de carácter subjetivo; involucrada directamente con la personalidad, con el bienestar y satisfacción que da vivir y la forma en que lo hace una persona, se basa en las experiencias previas, círculo social entre otros factores más. (Vera M. , 2007)

La calidad de vida se ve mucho más comprometida en los adultos y adultos mayores en dimensiones como la función social, salud mental, vitalidad, rol físico, dolor corporal en porcentajes menos del 60% según el SF-36. (Peña et al., 2019) Estudios resaltan que las mujeres presentan tasas más altas de calidad de vida que lo varones ya que se asocia con las actividades del hogar y el constante trajinar que le aporta favorablemente a la mejora de sus condiciones de vida (Castell et al., 2021).

En cuanto a los jóvenes, la calidad de vida se puede ver mermado por una serie de variables tales como las condiciones del sexo, índice de masa corporal, año, rendimiento académico, estado civil, situación laboral, ingresos familiares, condiciones de vivienda, número de enfermedades reportadas, hábito de fumar, consumo de alcohol, actividad física y síntomas depresivos (Lins et al., 2015).

Otro termino importante es el de “calidad de vida familiar” que está presente desde los 80’s que en un principio se centraba en la discapacidad y el impacto que generaba en su familia, pero en la actualidad se ha generado instrumentos que analizan el impacto de múltiples enfermedades sobre su entorno familiar, quien tiene una influencia muy importante en las condiciones de vida de los pacientes (Jemes , 2022).

Otras definiciones de calidad de vida están relacionados al trabajo (CVL) (Daubermann et al., 2013), en especial por la presencia del Estrés laboral que está asociada con signos y síntomas en su salud que afectan la satisfacción laboral. (Bustamante et al., 2020)

Una definición adicional es la Calidad de vida familiar (CVF), concepto que es considerado en el bienestar que presenta el individuo y la familia en conjunto en el aspecto económico, emocional, condición física e incluso espiritual en función de sus características y su respuesta frente a los problemas de salud (Condezo y Quispe, 2022).

- **Instrumentos que generalmente se emplean en la valoración de la calidad**

En general, los instrumentos que cuantifican la calidad de vida deben de evaluar y hacer seguimiento de los problemas psicosociales del paciente, detectar los problemas de salud referidos por la población, generar una auditoria médica, evaluar las condiciones de los servicios de salud, proponer los estudios clínicos y analizar de costo-efectividad de los procedimientos. (Misrach y Espinoza, 2005)

Es así como, los instrumentos que valoran la calidad de vida más empleados es el Cuestionario Short Form 36 (SF-36) que está compuesto por 36 preguntas agrupados en 8 dimensiones como es: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental, el resultado se obtiene en porcentajes que finalmente se juntan en 2 componentes como el físico y mental. Otro instrumento es el Euro Quality of Life 5D (EuroQol-5D), está

compuesto de 3 niveles: gravedad por dimensiones, EVA y índice de valores sociales (Zambrano, 2021).

Por otra parte, el instrumento de WHOQoL-BREF evalúa la calidad de vida de individuos tanto sanos como enfermos. Consta de 26 preguntas que permiten evaluar 4 áreas de la vida: social, física, psicológica y ambiental. El cuestionario contiene 2 preguntas, analizadas por separado, relativas a la evaluación de la calidad de vida, satisfacción y salud. El número de puntos que se pueden conseguir oscila entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el número de puntos obtenidos en el cuestionario, mejor será la calidad de vida (Mroczek et al., 2020).

Adicionalmente, Los instrumentos conocidos para la valoración de calidad de vida de familia son: Escala de Calidad de Vida Familiar del Beach Center, Encuesta de Calidad de Vida Familiar (FQOL), Escala Española de Calidad de Vida Familiar para familias con un hijo con DID menor de 18 años, Escala de Calidad de Vida de las familias en Atención Temprana (FEIQoL) dirigido tanto a los cuidadores principales y todos los miembros de la familia (Jemes , 2022).

A modo de ejemplo, un instrumento interesante es el Instrumento de medición del Índice de Calidad de Vida Urbana: Barrios Urbano Marginales (CVU en BUM) que cuenta con la dimensión urbana-ambiental, dimensión social y dimensión económica con sus respectivas visiones objetivas y subjetivas los cuales a través de sus intervalos define la calidad de vida de mala a muy buena, tiene como público objetivo a gobiernos locales, organizaciones de vigilancia ciudadana y dirigentes vecinales (Valdivia et al., 2020).

- **Dimensiones de la calidad de vida**

A nivel nacional, se encontró estudios donde se indica que las dimensiones tales como la salud física no limitan sus actividades de autocuidado, traslado y movilidad (Lima, 2021) (León, 2019) (Caycho et al., 2019) (Argumé y Alvarez, 2017) (Hernandez et al., 2016); en el desarrollo de sus actividades han referido que su desenvolvimiento es menor a lo programado. El dolor corporal suele estar en el

desarrollo de este tipo de trabajos, de forma permanente. A pesar de todo esto, los pacientes tienen una perspectiva positiva de su salud y negación a continuar con la enfermedad. La salud física o emocional puede ser llevado a la par de las sus actividades sociales ni en su trabajo. Finalmente se presenta un considerado control de conducta y emociones frente las situaciones o problemas que se les presente (Jáuregui, 2019):

- **Función física:** Desarrolla las actividades de vida diaria como el aseo, traslado, estudio, alimentación y las otras actividades de la vida diaria que se ejecutan sin presentar limitaciones. (García.F, 2022) Otra definición es la percepción de independencia para desenvolverse en un contexto determinado en busca siempre de situaciones complejas que mediante su físico pueden superarlo (Mimbela, 2022).
- **Rol Físico:** Contempla como las enfermedades afectan al empleo del paciente, así como sus AVD's (Barceló et al., 2021). Es decir, mide la independencia de persona y con ello indirectamente la calidad de la vida paciente que se traduce como el aumento o disminución del sedentarismo y actividad física (Caceres, 2021).
- **Dolor Corporal:** Es la percepción del dolor y como interfiere en sus actividades laborales y actividades de vida diaria (AVD) (Barceló et al., 2021). El dolor tiene varias clasificaciones, uno de los más empleados es el dolor agudo y crónico; el primero es una respuesta biológica de protección dimensionado al daño, mientras que la segunda está presente en un tiempo mayor a 3 meses considerado como una "fuente de discapacidad" y está asociada a múltiples factores que llegan afectar la calidad de vida del paciente (Bilbeny, 2019).
- **Salud general:** Es la percepción del paciente de su estado de salud en general y como la aborda para cuidarla a través de la prevención o empleo de tratamientos. (García.F, 2022). Es la esperanza de vida que presentan

las personas y sus expectativas corporales, funcionales y anímicas para sobrellevar o afrontar una enfermedad (Caceres, 2021).

- **Vitalidad:** Es la sensación de los pacientes al sentirse en buena física, hábitos saludables de alimentación a través de sus actividades del día al día, accesibilidad a la orientación de ayuda técnica y alimenticia. (Morales, 2016). Esta dimensión también contempla el impacto de la percepción colectiva de la edad en la que se encuentran y sus características incapacitantes (Caceres, 2021).
- **Función social:** Contempla a las relaciones con la familia, pareja, amigos, hijos de forma gratificante y positiva en las relaciones interpersonales y la sexualidad. Al evaluar esta dimensión se consulta sobre la participación social, accesibilidad, integración en la sociedad y recepción de apoyos (Morales, 2016). En la actualidad se está promoviendo esta función con “altas expectativas” siendo a veces una amenaza pues genera una presión en la persona para encajar en los estándares de la sociedad (Caceres, 2021).
- **Rol emocional:** Refiere a la tranquilidad, seguridad y no agobio considerando la satisfacción, ausencia de estrés y autoconcepción personal adecuada. (Morales, 2016). Los estados emocionales referidos se hacen presente en momentos altamente traumático como un accidente, rodo, pérdida familiar, enterarse de una enfermedad incurables (Caceres, 2021).
- **Salud mental:** Las enfermedades osteoarticulares están relacionado con las dificultades del afrontamiento, la autoeficacia, la somatización, el dolor catastrófico, la impotencia y calidad del sueño. (Briani et al., 2019). Algunos autores indican que al evaluar a personas con dolor musculoesquelético deben considerar la derivación a servicios de fisioterapia y la información psicosocial y médica (Chester et al., 2019).

- **Cambios de la salud:** Esta dimensión puede ser inconstante y redundante, pero desarrolla la medición de la sensación de su estado de felicidad y percepción mental en un lapso de tiempo que analiza el individuo (García.F, 2022) y que desde el punto de vista de la investigación científica puede ser utilizada como variable de control.

- **La calidad de vida en las enfermedades más prevalentes:**

La calidad de vida asociada a la salud está relacionada con las enfermedades, a continuación, hablaremos de las más prevalentes y como impactan en la persona.

- **Calidad de vida en enfermedades reumáticas:** Se considera que las patologías más comunes reumáticas son el dolor lumbar crónico, dolor de hombro crónico, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, fibromialgia, síndromes miofasciales y dolor musculoesquelético crónico, los cuales pueden tener una carga de enfermedad de 2.4% a 13.2%, sobresaliendo el dolor musculoesquelético crónico (Kemp et al., 2020). Por otro lado, la enfermedad que más años de vida con discapacidad (AVD) es considerado el dolor lumbar con un 341.676 de años y la artrosis de rodilla con un 171.036 de años afectando considerablemente la calidad de vida (Bilbeny, 2019). La terapia física puede prevenir las caídas en las personas que viven en la comunidad en una tasa de -0.2 a 0.8 puntos. (Hopewell et al., 2020)
- **Calidad de vida en enfermedades traumáticas:** En el adulto mayor la fisioterapia permite promover la actividad y ejercicio físico para prevenir la fragilidad y prefragilidad (Argumé y Alvarez, 2017). Otro punto a prevenir son las caídas considerando que casi el 60% de los adultos han sufrido alguna caída que termina en una fractura y/o hospitalización, la labor de la terapia física va más allá del fortalecimiento, coordinación y equilibrio, también considera las recomendaciones para optimizar su entorno y hacerlo más seguro aportando a elevar en nivel de calidad de vida (Aliaga et al., 2016).
- **Calidad de vida en enfermedades neurológicas:** Los pacientes con el diagnóstico neurológicos como el Parkinson presentan dificultades para el

traslado, aseo, aprendizajes, comunicación, problemas emocionales, en un estudio muestra que la atención de terapia física optimizo los dominios de habilidades psicológicas y físicas en forma personal y grupal (Terrens et al., 2021). Otra patología constante en las parálisis faciales donde la seguridad y capacidad de afrontamiento del paciente se ve comprometido, pero a través de un tratamiento fisioterapéutico el tiempo de recuperación ha presentado una importante reducción que genera un bienestar en el paciente (Ulloa y Tipán, 2017).

- **Las variables de control - Características socioculturales de las poblaciones de Lima Metropolitana**

La caracterización de la calidad de vida se da en base a las particularidades de la población de Lima Metropolitana, estas son consideradas como variables de control (Medina et al., 2023). Las variables de control son importantes en los estudios pues no interfieren en los experimentos, pero si debe ayudan a ordenar la investigación, no son consideradas ni variables independientes ni dependientes, el no considerarla pueden “arribar a resultados espurios”, también se debe aclarar que una variable de control no es igual a un grupo de control. (Rodriguez et al., 2021)

Con respecto a estas variables se conoce que en el 2023 Lima Metropolitana contaba con más de 11 millones de pobladores representando así al 35% de la población peruana, de esta zona se estima que el distrito con más población es San Juan de Lurigancho con más de 1 millón de personas distribuidas en 298 mil hogares, seguido de San Martin de Porres y Ate Vitarte (INEI; OIM, 2015).

La población predominante es entre 25 – 39 años con el 25% del total, en menos porcentaje es la población menor a 5 años. (IINEI, 2022) Con respecto al género la distribución es equilibrada (Rosales, 2021) .Otro dato importante es el predominio del nivel socioeconómico C con un 46% (APEIM, 2021) seguido del nivel A, B y D con un 24% (CPI, 2023).

- **Impacto de las características sociodemográficas de los pacientes en la calidad de vida**

En la bibliografía revisada se hallaron que las variables de control tienen un comportamiento con la calidad de vida, el cual es nuestro interés de este estudio, por ello a continuación se explora cada variable:

- **Edad y calidad de vida:** Los grupos etarios que presentan menor calidad de vida son las personas adultas (Rosales, 2021), esto responde a la presencia de múltiples enfermedades cardiovasculares, lesiones musculoesqueléticas, además de su poca capacidad de recuperación (Cáceres et al., 2018).
- **Sexo y calidad de vida:** En varios estudios los hombres son identificados con mejor calidad de vida que las mujeres esto puede ser posible a la menor exigencia de expectativas de sus condiciones de vida, la sociedad les brinda mejores oportunidades porque su esfuerzo por la equidad culturalmente es menor a que las mujeres (Rosales, 2021), además de no llevar la responsabilidad del cuidado de la familia y casa ni tampoco logran llevar la maternidad que genera alteraciones físicas y mentales en las damas (Cáceres et al., 2018).
- **Enfermedades preexistentes y calidad de vida:** Las enfermedades reumatológicas no resueltas han demostrado que generan un impacto en la calidad de vida como es la artritis reumatoide y osteartrosis de cadera y rodillas (INEI, 2023); otras patologías a considera son la fibromialgia, osteoporosis ya que todas estas generan perdida muscular que ocasiona la alteración de la coordinación, equilibrio y resistencia en sus actividades de vida diaria. (Ambriz et al., 2015).

Otras enfermedades que afectan la calidad de vida son las traumatológicas como los problemas de fragilidad y osteoporosis relacionados con las caídas de los pacientes en especial los adultos mayores con fracturas que van a

generar falta de movilidad, pérdida de apetito, aumento de fatiga llevándolos a complicaciones respiratorias que pueden ser mortales (Fernández et al., 2020).

- **Nivel socioeconómico y calidad de vida:** Los niveles altos de calidad de vida están asociados en gran frecuencia a niveles socioeconómicos A y B en casi todas las dimensiones a excepción del funcionamiento físico, de forma contraria esta dimensión es la única que tienen valores altos en el nivel D (APEIM, 2021), pero el resto de dimensiones hacen mención a una mala calidad de vida, es decir el poder adquisitivo está muy relacionado con el acceso a los servicios de salud de calidad y con prontitud, por ello los niveles socioeconómicos bajos presentan malas condiciones de salud y vida (López et al., 2019).
- **Trabajo y calidad de vida:** La calidad de vida se ve impacta en los pacientes con diagnósticos reumatológicos como la artrosis ya que refieren que les impide realizar sus labores, en un estudio en España reportó que más del 50% de los diagnosticados dejaron de trabajar; esta realidad es similar en Latinoamérica generando una complicación en las condiciones de vida por la reducción de ingresos económicos, más aún si esta patología lo sufren los responsables de casa (Rodriguez et al., 2022).

En Sudáfrica en el caso de las fracturas de tibia después de 6 a 20 meses de evolución se ha encontrado que el 29% de los pacientes regresaron a trabajar en el momento previsto de recuperación, el 36,8% informó haber vendido posesiones para pagar sus gastos y el 42,1% utilizó iniciativas de bienestar social. Seguidamente, el 42% de los pacientes utilizó a amigos y familiares como fuente de ayuda financiera. Sin embargo, solo el 29,2% de los pacientes volvió a trabajar en un seguimiento medio de 11,8 meses. Los pacientes con mejores pronósticos suelen ser más jóvenes y tienen un mayor apoyo social. Pero muchos pacientes indicaron que tuvieron que adaptar sus funciones y horas de trabajo después de la lesión para seguir involucrado en el trabajo. (Singaram y Naidoo, 2019).

- **Carga familiar y calidad de vida:** La responsabilidad familiar representado principalmente por la remuneración económica que es percibida como más importante que los aspectos espirituales o psicológicos ya que él o las cabezas del hogar dependen las condiciones de vida del resto de personas (Tarrillo , 2023). Por esta razón algunos jefes de hogar jóvenes consideran estudiar para generar mayores ingresos logrando mejorar su calidad de vida, sin embargo, las personas mayores suelen ser limitados en su progreso profesional, ingresos y presentan mayor impacto en su calidad de vida por sentir que tienen menos recursos para resolver sus necesidades familiares presentando un nivel medio de CV (Chunga et al., 2022).
- **Nivel de instrucción y calidad de vida:** Estudios en Perú – Lima refieren mayor frecuencia de dolor en personas nivel educacional técnica o solo secundario, sin embargo no difieren tanto de las personas con educación superior: esto podría deberse que las personas con nivel técnico y secundario realizan mucha actividad física y sus trabajos suelen ser de largas horas donde predomina uso de fuerza; por otro lado los profesionales están sometidas a posturas mantenidas, menos movimientos y trabajo mental; en ambas situaciones la calidad de vida se ve afectada. (Guevara y Sánchez, 2022).

En este punto del análisis, se aprecia que está asociado a la alfabetización, como lo señala un estudio colombiano que indica que, se genera un gran impacto en la calidad de vida, debido a que mientras menor sea la alfabetización de los pacientes éstos presentarán una menor Calidad de Vida (CVRS) (Lemey et al., 2021).

- **Origen cultural y calidad de vida:** En la capital se puede encontrar mucha migración, la percepción de esta todos los migrantes es que en la capital hay “alta violencia política” por su condición de provinciano (INEI; OIM, 2015), lo cual merma su calidad de vida debido a la inseguridad económica, social, condiciones de hogar en hacinamiento y alimentación inadecuadas, pocas

oportunidades de progreso, tal es así que solo el 80% refiere tener un trabajo (Márquez et al., 2011).

- **Religión y calidad de vida:** Dentro de la religión católica los varones indican que predomina la precepción de calidad aceptable, al igual que los cristianos y testigos de Jehová sin embargo las personas ateas presentan percepciones deficiente o alta (DIRIS Lima Norte, 2022). Sin embargo, las mujeres de cristianas y testigos de Jehová indican tener una percepción de su calidad de vida deficiente. La religión es una característica que le ofrece a la persona un soporte emocional para afrontar las dificultades y les da una óptica de esperanza en su forma y nivel de vida (Flores et al., 2018).
- **Tiempo de diagnóstico y calidad de vida:** La existencia de un diagnóstico de enfermedad crónica y muchas exigencias del tratamiento dificultan a las personas adaptarse a su nuevo estado de salud, lo que conlleva posteriormente una disminución de su calidad de vida (Cosentino, 2024); estadísticamente estudios a enfermedades crónicas (mayor a tres meses de aparición) son significativas para la el componente de salud física ($p < 0,001$) y también para el componente de salud pública ($p < 0,001$), lo que confirma que la CVRS disminuye considerablemente (Guerrero et al., 2017).
- **Acceso al tratamiento de fisioterapia y calidad de vida:** En la atención temprana los pacientes en enfrenta a la dificultad de tener acceso a los servicios deseados (Pavo y Ramos, 2022), llegando a generar una sensación de frustración por los costos, listas de espera o no calificar para la atención (García et al., 2022). Las poblaciones con menos recurso son aquellos que no presentaran más “barreras de acceso” a los servicios de salud, esta situación perjudica su calidad de vida (Bran et al., 2020).
- **Importancia de la fisioterapia para la calidad de vida:** La calidad de vida se va a optimizar mediante muchos factores entre ellas la participación de actividades grupales donde no solo se desarrolla la actividad física si no se genera unos vínculos donde se dará el reconocimiento e integración de los

pacientes a la sociedad. (Argumé y Alvarez, 2017). Khan menciona que la fisioterapia ha reducido las posibilidades que los pacientes lleguen a una intervención quirúrgica, optimizando su calidad de vida y dando una herramienta de soluciones que está cada vez más al alcance de la población (Khan, 2009).

2.3. Definición de términos básicos

En este apartado se describe ciertas palabras que requieren ser aclaradas para el mejor entendimiento del estudio:

- **Actividades de la Vida Diaria:** son las tareas cotidianas que realiza una persona de forma constante sin requerir ayuda, se refiere a vestirse, alimentarse, asearse, trasladarse, entre otros (Aliaga et al., 2016).
- **Artritis Reumatoide:** es una enfermedad autoinmune que genera inflamación crónica de las articulaciones junto a dolor y rigidez (Ambriz et al., 2015).
- **Desempeño Emocional:** es la capacidad de una persona para gestionar sus emociones frente a situaciones cotidianas y otras condiciones que puedan impactar en su bienestar general (Briani et al., 2019).
- **Dimensiones:** Divisiones de una variable cuyo fin es ayudar a evaluar un fenómeno, que pueden ser físicas, psicológicas, sociales, etc. Referencia: Manual de Investigación en Salud Pública (Misrach y Espinoza, 2005).
- **Equilibrio Dinámico:** es la capacidad de no perder la estabilidad del cuerpo mientras se está ejecutando una actividad o movimiento (Comachio et al., 2018).
- **Funcionabilidad:** es la capacidad de un individuo para realizar AVD y tener una visa social empleando sus recursos físicos y mentales (Caycho et al., 2019).
- **Funcionamiento Físico:** es la capacidad de ejecutar actividades físicas en su día a día, realizar actividades recreativas y laborar sin dificultades (García.F, 2022).
- **Independencia:** es la capacidad que tiene una persona al ejecutar sus actividades de la vida diaria sin requerir asistencias, es considerado como un signo de buena salud (Walter et al., 2021).

- **Lumbago:** Dolor en la zona lumbar o baja de la espalda, según la instalación de tiempo puede ser agudo o crónico (Guevara y Sánchez, 2022).
- **Marcadores de la Salud:** son indicadores objetivos con los cuales se puede medir el estado de salud de forma individual o a la población (San José, 2015).
- **Movilidad:** es la capacidad de trasladarse sin dificultades empleando con libertad todas sus articulaciones (Castell et al., 2021).
- **Políticas de Salud Pública:** son estrategias y planes realizadas por gobiernos o instituciones con el fin de proteger la salud de toda su población (Salud Sin Limites Peru, 2012).
- **Potencia Muscular:** es la capacidad de los músculos para aplicar una fuerza rápidamente, está presente en actividades de alta intensidad (Kemp et al., 2020).
- **Respuesta Biológica:** es el accionar del cuerpo a los estímulos internos y/o externos, estas respuestas suelen ser cambios fisiológicos o psicológicos (Bilbeny, 2019).
- **Sarcopenia:** es la pérdida progresiva de masa muscular y esto compromete la fuerza muscular, funcionalidad y la calidad de vida; es contante en la vejez (Comachio et al., 2018)
- **Síntomas:** son manifestaciones físicas o mentales subjetivas de una enfermedad o condición especial que refiere el paciente (Barceló et al., 2021).
- **Tecnólogos de Terapia Física y Rehabilitación:** Profesionales peruanos que emplean múltiples herramientas y técnicas para recuperar la movilidad y funcionalidad adquirida por una enfermedad o lesión (Mimbela, 2022).
- **Velocidad de Marcha:** es el tiempo en recorrer una distancia al caminar, es empleado como un indicador de salud y funcionalidad (Kemp et al., 2020).

Capítulo III: Hipótesis y variables

3.1. Hipótesis

Luego de haber identificado los problemas de investigación y sus respectivos objetivos se procede a enunciar las hipótesis previstas para el presente trabajo:

3.1.1. Hipótesis general

La hipótesis general identificada es:

Que el nivel de calidad de vida varía de acuerdo con las características socioculturales de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

3.1.2. Hipótesis específicas

Las hipótesis específicas son:

- La calidad de vida varía cambia en cada etapa de vida de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de calidad de vida es diferente entre los pacientes mujeres y varones que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de la calidad de vida presenta diferencias notables en cada nivel de instrucción de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de la calidad de vida presenta importantes cambios dependiendo del nivel socioeconómico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

- El nivel la calidad de vida es mejor en los pacientes que presentan un trabajo dependiente estable que el resto de pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de la calidad de vida de los pacientes que comparten la carga familiar tiene mejores condiciones que el resto de pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- No existe una variación de la calidad de vida varía de acuerdo a la procedencia de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de la calidad de vida puede ser variable tomando en consideración la religión de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de la calidad de vida está en malas condiciones cuando hay presencia de enfermedades preexistentes de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de calidad de vida se modifica tomando en cuenta la cronicidad de las enfermedades de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.
- El nivel de calidad de vida es bajo cuando no se tiene acceso al tratamiento médico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

3.2. Operacionalización de variables

El presente apartado desarrolla las variables que serán analizadas

3.2.1. Variable 1: Características poblacionales

Entre las primeras variables se identifican las: Características poblacionales (sociodemográficas, culturales, educativas, laborales, clínicas) de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025. Las cuales son consideradas de control porque en base a estas se identificará la variación de la calidad de vida. (Romero et al., 2022)

- Sociodemográficas: edad, sexo
- Educativas: nivel de instrucción
- Laborales: nivel económico, pea, carga familiar
- Culturales: procedencia, religión
- Clínicas: enfermedades preexistentes, tiempo de enfermedad, acceso a tratamiento

3.2.2. Variable 2: Calidad de vida

Calidad de vida que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.

3.3. Matriz de operacionalización de variables

A continuación, se detalla las variables y sus características (Tabla 2):

Para la organización de variables se empleará la operacionalización de variables, con el fin de precisar los conceptos, dimensiones, indicadores e instrumentos que se emplearán por cada variable, el desarrollo de estos datos se basa en la metodología que se empleará para el presente proyecto (Álvarez, 2020)

Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición	instrumento
Variable 1 : Características de pacientes – Sociodemográfica - Edad	Tiempo que ha vivido una persona (RAE, 2024)	Edad de los pacientes que participarán en la investigación al momento del recojo de información	-----	- Jóvenes (18 – 29 años) - Adultos jóvenes (30 – 44 años) - Adultos (45 – 59 años) - Adultos mayores (60 a más)	Cualitativo ordinal	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes – Sociodemográfica - sexo	Identidad biológica del individuo (RAE, 2024)	Sexo de los pacientes que formara parte del estudio	-----	A) Masculino B) Femenino	Cualitativo nominal dicotómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes- Educativa - Nivel de instrucción	“Son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas” (MINEDU, 2024)	Nivel de instrucción de los pacientes que formara parte del estudio		- Sin educación - Educación básica inicial - Educación básica primaria - Educación básica secundaria - Educación superior	Cualitativa Ordinal	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes – Laborales - Nivel socioeconómico	“Es una medida total que combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas” (Vera y Vera, 2013)	Nivel socioeconómico de los pacientes que formara parte del estudio		A B C D E	Cualitativa ordinal	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes – Laborales – Trabajo PEA	“Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía” (OIT, 2024)	Trabajo de los pacientes que formara parte del estudio		- No cuenta - Trabajo independiente - Trabajo dependiente no estable - Trabajo dependiente estable	Cualitativa nominal politómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes – Laborales - Carga familiar	Es la o las personas que vive a expensas de un trabajador y que no dispone de una renta igual o superior a la mitad del ingreso mínimo mensual. (El Peruano, 2024)	Carga familiar de los pacientes que formara parte del estudio		- No cuenta - Único aporte de casa - No es el único aporte de casa	Cualitativa nominal politómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes- Culturales- Procedencia	“Conjunto de costumbres y obras intelectuales que caracterizaban una sociedad” (Etihc, 2024)	Procedencia de los pacientes que formara parte del estudio		- Sierra - Costa - Selva	Cualitativa nominal politómica	Cuestionario de características poblacionales

Variable 1 : Características de pacientes- Culturales- Religión	Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella. (RAE, 2024)	Religión de los pacientes que formara parte del estudio		• Católico • Sin religión • Evangélico • Otros cristianos • Otras religiones • No desea contestar	Cualitativa nominal politómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes - Clínicas - Enfermedades preexistentes	Cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado (El Peruano, 2024)	Enfermedades preexistentes de los pacientes que formara parte del estudio	Reumatológicas Traumatológicas	• Si presenta • No presenta • Si presenta • No presenta	Cualitativa nominal dicotómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes - Clínicas - Tiempo de enfermedad	Tiempo que pasa desde el diagnóstico de una enfermedad o el comienzo del tratamiento hasta el momento de la consulta. (MINSAA, 2019)	Tiempo de enfermedad de los pacientes que formara parte del estudio		Aguda Crónica	Cualitativa nominal dicotómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable 1 : Características de pacientes - Clínicas - Acceso al tratamiento	"Recepción de atención médica adecuada y oportuna, así como atención por emergencia sin exigirse antes documento o pago alguno" (SALUPOLD, 2024)	Acceso al tratamiento de los pacientes que formara parte del estudio		Si cuenta No cuenta	Cualitativa nominal dicotómica	Cuestionario de características poblacionales
Variable: Implementación del servicio de terapia	"Proceso de establecer y poner en práctica un plan de tratamiento terapéutico para ayudar a un paciente a superar problemas de salud mental, emocional o física." (SALUPOLD, 2024)	Como se enteró de la atención de terapia física		Derivación de otro servicio Información de familiares externos Cuanta propia	Cualitativa nominal politómica	Consentimiento informado
Variable 2 : Calidad de vida	Es el conjunto de factores como el bienestar físico, psíquico y social que posee la persona (Misrach y Espinoza, 2005)	Nivel de calidad de vida de los pacientes que formara parte del estudio	1. Función física 2. Rol Físico 3. Dolor Corporal 4. Salud general 5. Vitalidad 6. Función social 7. Rol emocional 8. Salud mental	Bajo 0-66 Regular 67-82 Bueno 83-100	Cualitativa Ordinal	Escala SF-36 Es un cuestionario que permite medir el estado de salud auto percibido por la persona, consta de 36 preguntas que valoran el estado físico, psíquico y social.

Nota: Fuente propia

Capítulo IV: Metodología del estudio

En el presente capítulo se desarrolla la metodología científica empleada en este estudio

4.1. Enfoque, tipo y alcance de investigación

En el presente apartado se desarrolla las características científicas de este estudio basados en la información de la comunidad científica, si bien existen muchas formas de clasificar las metodologías de investigación nos orientaremos por los autores Romero, Medina, Haro y Hernández, 2020.

4.1.1. Enfoque

El presente estudio según Romero es de enfoque cuantitativo debido a que los datos recolectados son medibles, los instrumentos y cuestionarios son estructurados, se alinean a objetivos e hipótesis de estudios que serán comprobados y descritos por un análisis estadístico descriptivo e inferencial lo cual permitirá la generalización de resultados, objetividad, replicación y precisión (Romero et al., 2022).

4.1.2. Tipo y alcance

La investigación según Romero es de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional (Bustamante et al., 2020). Esta combinación de tipos ya alcances se da porque el presente trabajo de investigación pasará por diversas etapas: (Romero et al., 2022)

Primera etapa: Exploratorio pretende acercarse al fenómeno estudiado en su frecuencia de las características de la población de Lima metropolitana que recibe un servicio y como interactúa con las dimensiones de la calidad de vida. (Medina et al., 2023)

Segunda etapa: Descriptiva porque luego de identificar las características socioculturales de los pacientes y en nivel de la calidad de vida, además de tratar

de establecer algún tipo de relación entre estas variables sin definir causalidad alguna. (Haro et al., 2024) (Hernández, 2018)

Tercera etapa: El alcance es correlacional porque busca entender como la calidad de vida está relacionada con las características de la población estudiada a modo de analizarlas con profundidad. (Romero et al., 2022).

4.2. Diseño de la investigación

Romero nos indica que nuestro estudio está estructurado siguiendo las orientaciones del diseño no experimental porque solo observará el comportamiento de las variables y su relación entre ellas sin intervenir para ello se usará el instrumento SF 36 y un cuestionario de datos, específicamente es un Transversal pues se hará solo una toma de datos en fechas específicas, Analítico porque se usará análisis inferencial. (Romero et al., 2022). **Anexo A.** Matriz de consistencia

4.3. Población y muestra

Con el fin de conocer con cuanta población se va a trabajar en el este apartado se describirá la población y las características de la muestra.

4.3.1. Población

La población serán los pacientes que asisten a los 12 centros de salud del primer nivel de atención que cuenten con el servicio de terapia física y rehabilitación de Lima – Metropolitana DIRIS Lima Centro. La información es inexacta por lo que se empleará la data del periodo comprendido entre noviembre y diciembre 2024 extraída de las páginas oficiales y publicas de estadística de la DIRIS, las ofertas de plazas no equivalentes de SERUMS 2024, entre otros, la cual se conoce que es un aproximado de 765 (tabla 3). (Ministerio de Salud del Perú, Informe de gestión anual 2024, 2024) (Ministerio de Salud del Perú, Panel de indicadores sanitarios interactivos 1 [Power BI]., s.f.) (DIRIS Lima Centro, Trazadores sanitarios: Estrategias sanitarias., s.f.) Esta información servirá para el muestreo del presente

estudio, se ha contemplado los siguientes criterios de inclusión y exclusión (Romero et al., 2022).

Criterios de inclusión

- Pacientes con diagnósticos reumatológicos y traumatológicos
- Pacientes mayores a 18 años
- Pacientes que se estén atendiendo más de 3 meses en los servicios de terapia física y rehabilitación
- Paciente que deseen participar voluntariamente (consentimiento informado)

Criterios de exclusión

- Pacientes que llevar paralelamente tratamiento en otro centro o servicio de terapia física.
- Pacientes que tengan diagnósticos de enfermedades mentales

La población con la cual se trabajará está distribuida en los centros de salud del primer nivel de atención (DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Centro, 2024).

Tabla 3. Centros de Salud donde se cuenta con el servicio de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención. Solo DIRIS Lima Centro

Centros de Primer Nivel de la DIRIS Lima- Centro
• Centro De Salud Breña • Centro De Salud San Miguel • Centro De Salud Villa Victoria Porvenir • Centro De Salud Max Arias Schreiber • Centro De Salud San Sebastián • Centro De Salud Campoy • Centro De Salud Medalla Milagrosa • Centro De Salud Chacarilla De Otero • Centro De Salud Jaime Zubieta Calderón • Centro De Salud José Carlos Mariátegui • Centro De Salud La Huayrona • Centro De Salud La Libertad

(DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Centro, 2024).

4.3.2. Muestra

Para este estudio se determinará la muestra por un muestreo probabilístico aleatorio simple (Hernández, 2018); la elección de este tipo de muestreo se da porque se busca delimitar una población conocida de 765 pacientes los cuales reciben el servicio de terapia física de los centros de salud de la DIRIS Lima Centro, esta data se obtiene en el apartado anterior; al aplicar la fórmula con el 95% de confianza nos indica que debería ser $n=233$ pobladores como mínimo para tener una muestra representativa (la duda es si de los centros de atención que, si se conoce el dato de la población, pero de las atenciones de terapia no se conoce, más si se tiene un aproximado de pacientes atendidos mensualmente) (Celis y Labrada, 2014). **Anexo B.** Población afiliada a SIS de Lima Metropolitana y los centros de salud. **Tabla 4.** Muestreo del estudio

En el caso de **DIRIS Lima Centro** se abordará a 12 centros con 223 participantes, se detalla en la tabla **Tabla 5.** Distribución de pacientes que serán entrevistados

Tabla 4. Muestreo del estudio

Indicadores	Centros de salud	Pacientes atendidos
N= tamaño de la población	12	765
z= nivel de confianza 95% p=Probabilidad a favor 50% q=Probabilidad en contra 50% e= margen de error 5%	$n = \frac{Nz^2pq}{(N-1)e^2 + z^2pq}$	$n = \frac{Nz^2pq}{(N-1)e^2 + z^2pq}$
n= tamaño de muestra	12	233

Nota: fuente propia empleando datos de (Celis y Labrada, 2014) (Freiberg et al., 2013)

Unidad de análisis: paciente que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación del primer nivel de atención de Lima Metropolitana DIRIS Lima Centro – 2025 (tabla 5) (Romero et al., 2022).

En la tabla 5 se puede observar la distribución numérica de los sujetos que serán parte de la muestra partiendo de la población de cada centro de salud (DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Centro, 2024)

Tabla 5. Distribución de pacientes que serán entrevistados

IPRESS	DIRIS	Atendidos de Tfyr promedio al mes	Pacientes que se entrevistará
DIRIS Lima Centro		TOTAL	n=223
	Ris 01 Lima		
6191	C.S. San Sebastian	70	20
	Ris 02 Lima		
6184	C.S. Breña	50	15
6198	C.S. San Miguel	120	35
	Ris 03 Lima		
6180	C.S. Villa Victoria Porvenir	60	17
	Ris 04 Lima		
6170	C.S. Max Arias Schreiber	50	15
	Ris 01 Sjl		
5848	C.S. Campoy	35	10
5841	C.S. Chacarilla De Otero	40	12
5834	C.S. La Libertad	40	12
5835	C.S. La Huayrona	40	12
	Ris 02 Sjl		
5620	P.S. Medalla Milagrosa	120	35
5624	C.S. Jaime Zubieta	120	35
	Ris 03 Sjl		
5628	C.S. Jose Carlos Mariategui	20	6
	12 Centros de salud	765	223

Nota: elaboración propia en base a datos del MINSA (DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Centro, 2024)

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El presente estudio empleará técnicas e instrumentos que servirán para recabar la información de la muestra como se explica a continuación:

4.4.1. Técnicas e instrumentos

Las técnicas e instrumentos son de vital importancia para ejecutar los objetivos de una investigación ya que permiten recabar información de la muestra, por ello en este apartado según los autores Hernández y Feria (Hernández, 2018) (Feria et al., 2020) orientaron la selección de las más adecuada y son los siguientes:

Técnicas:

La técnica que se empleará en el presente estudio es la encuesta, se considera a la encuesta como una entrevista donde hace uso del instrumento conocido como los cuestionarios (Feria et al., 2020), la aplicación será de forma personal donde el encuestador lee las preguntas al encuestado y este responde según las opciones propuestas, los instrumentos utilizados son una ficha de recolección de datos y de un cuestionario (Hernández, 2018).

Instrumentos:

Para la variable de Características de los pacientes se empleará una ficha de recolección de datos

Este instrumento será validado con el asesor a cargo y tendrá los siguientes datos:

- Sociodemográficas: edad, sexo
 - Edad: las edades son diferenciadas en cuartiles o en grupos de edades según el INEI (tabla 6) (IINEI, 2022).

Tabla 6.Clasificación de las edades en Perú

Edades peruanas en Quartiles	Grupos de edad
18-24	Jóvenes (18 – 29 años)
25-29	
30-34	
35-39	Adultos jóvenes (30 – 44 años)
40-44	
45-49	
50-54	Adultos (45 – 59 años)
55-59	
60-64	
65-69	Adultos mayores (60 a más)
70-74	
75-79	
80-84	
85-89	
90 a más	

Nota: clasificación adaptada del (IINEI, 2022)

- Sexo: en cuanto al género en el estado peruano está identificado como hombres y mujeres (se rige al origen biológico). (IINEI, 2022)
- Educativas: es el nivel de instrucción que según el MINEDU se divide en Sin educación, Educación básica inicial, Educación básica primaria, Educación básica secundaria y Educación superior. (MINEDU, 2024)
- Laborales: nivel económico, PEA, carga familiar

- El nivel económico: la clasificación en Perú va desde la “A” hasta la “E”, siendo esta última la que menos recurso tiene (APEIM, 2021)
- PEA: es la población económicamente activa se ha clasificado como que No cuenta con trabajo, tiene Trabajo independiente, tiene Trabajo dependiente no estable y el que tiene Trabajo dependiente estable (INEI, 2024)
- Carga familiar: es considerara la responsabilidad de las personas que dependen económicamente del entrevistado y se divide en los que No cuentan con carga familiar, es el Único aporte de casa y el que No es el único aporte de casa. (Tarrillo , 2023)
- Culturales: procedencia, religión
 - Procedencia: es el lugar de origen como es la costa, sierra o selva (INEI; OIM, 2015)
 - Religión: este punto se divide en los identificados en estudios previos como son Sin religión, Evangélico, Otros cristianos, Otras religiones o los que No desean contestar (DIRIS Lima Norte, 2022)
- Clínicas: enfermedades preexistentes, tiempo de enfermedad, acceso a tratamiento
 - Enfermedades preexistentes: se divide en las que tienen y no tienen (INEI, 2023)
 - Tiempo de enfermedad: se divide en las son agudas (menores a 3 meses) y crónicas (mayores a 3 meses) (Cosentino, 2024)
 - Acceso a tratamiento: se divide en las que tienen y no tiene (Pavo y Ramos, 2022)

Para la variable de Calidad de Vida se empleará el cuestionario SF-36

Este cuestionario fue creado a inicios de la década de los 90, actualmente es considerado uno de los cuestionarios más fiables para evaluar la calidad de vida con respecto a la salud ya que es respaldado por su uso y aplicación en más de 400 artículos (Lopez et al., 2019). El SF-36 es un cuestionario que evalúa la CVRS, está la evalúa mediante 36 preguntas, estas están agrupadas en 8 categorías y/o dimensiones, estas son: para el componente resumen físico la función física, su

desempeño físico, dolor físico que presenta y cómo está su salud general y para el componente mental está la vitalidad, asimismo se considera la función social, el desempeño emocional y en la persona su salud mental (Lins et al., 2015)

Para sacar los resultados en las 8 dimensiones del instrumento, se individualizará cada una con sus respectivas preguntas, posteriormente se hará la sumatoria de cada ítem en la dimensión y/o escala y el promedio de total cada ítem dentro de esta entregará el resultado final de cada dimensión como se muestra en la tabla 7 a continuación (Argumé y Alvarez, 2017).

Tabla 7. Subescalas o dimensiones de la calidad de vida

Sub-Escala	Numero de Ítems	Ítems por subescala
<i>Función Física</i>	10	3,5,6,7,8,9,10,11,12
<i>Rol Físico</i>	4	13,14,15,16
<i>Dolor Corporal</i>	3*	21,22,33*
<i>Salud General</i>	5	1,34,35,36
<i>Vitalidad</i>	4	23,27,29,31
<i>Función Social</i>	3*	20,32,4*
<i>Rol Emocional</i>	3	17,18,19
<i>Salud Mental</i>	5	24,25,26,28,30

Nota: adaptado de Argumé y Alvarez, 2017. (*) Preguntas adaptadas a la dimensión.

A fin de cumplir con la confiabilidad del instrumento se ha reasignado las preguntas para que cada dimensión cuente con 3 preguntas como mínimo. Es así que la pregunta 33 pasa a la dimensión de Dolor Corporal y la pregunta 4 pasa a la dimensión Función Social (Izquierdo et al., 2014), lo que permite utilizar todas las preguntas del instrumento y conforma los factores adecuados del constructo en su totalidad.

Administración y puntuación: Los puntajes van del 0 al 100, considerándose 0 la puntuación más baja y 100 la más alta (tabla 8).

Tabla 8.Escala la calidad de vida según el SF-36

<i>Baja Calidad de vida</i>	<i>0-66</i>
<i>Regular Calidad de vida</i>	<i>67-82</i>
<i>Buena Calidad de vida</i>	<i>83-100</i>

Nota: adaptado de (Izquierdo et al., 2014)

El procedimiento de aplicación de este instrumento se da en dos pasos iniciando con la toma de datos e identificación de la puntuación según la pregunta, luego continua con el promedio de lo hallado para determinar el nivel en cada dimensión y de forma general (tabla 9) (Wada et al., 2007).

La escala inicial se presenta diversas cuantificaciones de forma ascendentes como descendentes según Hays, presenta valores de 0 a 100 y dependiendo de la cantidad de cada respuesta la puntuación varía (Hays et al., 1993). En el presenta trabajo se ordenó las respuestas todas de forma ascendente unidireccional, pues es necesario a fin de evaluar adecuadamente el test de Likert, además, permite que sea más fácil la aplicación de las preguntas Y EL tratamiento de los datos mejorando la validez y confiabilidad del estudio (Lopera, 2020) **Anexo D.** *Tabulación de las preguntas del SF-36.*

Tabla 9. Administración de las preguntas y sus puntajes del SF-36

Número de pregunta	El orden de la categoría de respuesta original	El valor real que se registra para el resultado final
1,2,20,22,34,36	1	0
	2	25
	3	50
	4	75
	5	100
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1	0
	2	50
	3	100
13,14,15,16,17,18,19	1	0
	2	100
21,23,26,27,30	1	0
	2	20
	3	40
	4	60
	5	80
	6	100
24,25,28,29,31	1	0
	2	20
	3	40
	4	60
	5	80
32,33,35	6	100
	1	0
	2	25
	3	50
	4	75
	5	100

Nota: cuadro adaptado de (Hays et al., 1993)

4.4.2. Validez y confiabilidad

La validez de un instrumento (Haro et al., 2024) en una investigación se refiere a lo que “es verdadero o se acerca a la verdad” busca la eliminación de errores o sesgos, se conoce como una seguridad interna. Mientras que la confiabilidad es “un alto grado de validez” indica que no hay sesgos, además es reproducible y consistente por lo que puede ser aplicable sin problemas. (Villasís et al., 2018)

A continuación, se presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos a emplear en esta tesis

Ficha de recolección de datos

El instrumento donde se recogen datos será revisado por el docente asesor y dará las indicaciones para su validación de contenido, la ficha propuesta se encuentra

en el **Anexo E**. Cuestionario de características poblacionales, al ser una recolección de datos de los participantes no requiere que cuente con una validez y confiabilidad. (Medina et al., 2023)

Cuestionario SF-36

El presente cuestionario es ampliamente usado en el medio científico, se ha empleado en poblaciones relativamente parecidas al del presente estudio, si las autoridades éticas de la universidad y el asesor creen conveniente su nueva validación, se procederá a realizarla mediante juicio de expertos, no se hará ninguna modificación en las preguntas y se puede visualizar en el **Anexo C**. Cuestionario de calidad de vida SF – 36. Sin embargo, a continuación, se detalla una validez y confiabilidad del estudio de León pues se hizo en Lima metropolitana denominado “Calidad de vida del anciano que asiste a un taller de adulto mayor de una institución de salud privada del Rímac”:

Validez: Este método de recopilación de información se ajustó para su uso en el idioma español y se sometió a validación en varios países, siendo el estudio más cercano a Ecuador llevado a cabo en Medellín, Colombia (Cáceres et al., 2018), en Perú se realizó la validación el 2012 acompañada de una confiabilidad medida por Alfa de Cronbach de 0.82 (Argumé y Alvarez, 2017). Las puntuaciones de cada dimensión se expresan en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la calificación más alta posible, indicando así una mejor calidad de vida relacionada con la salud, lo que lo convierte en uno de los enfoques más efectivos para evaluar este aspecto (León, 2019).

Sumado a la validez presentada se procedió a realizar una validez de contenido mediante la participación de 9 expertos (Torres et al., 2022). Se debe recordar que la validez es una de las estrategias más empleadas para comprobar el las preguntas de los instrumentos recurriendo a un “juicio de expertos”, estas personas analizan el contenido de los ítems buscando que contengan “claridad, coherencia, relevancia, entre otras características” (Escobar J. , 2008). La claridad contempla la sintáctica y semántica de cada pregunta con sus respuestas. La coherencia contempla si las preguntas tienen “relación lógica con el indicador o dimensión que

está midiendo”. La relevancia determina si la pregunta es “esencial” para medir el indicador o la dimensión (Boluarte y Tamari, 2017). A continuación, se adjunta las recomendaciones de los expertos.

Tabla 10. Recomendaciones de los expertos - validación de contenido

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NIVEL EDUCATIVO	COMENTARIO DEL INSTRUMENTO
Beatriz Horna Zevallos	Fisioterapeuta CTMP: 8345	Magister	Las preguntas son coherentes
Aníbal Gustavo Yllesca Ramos	Fisioterapeuta CTMP: 11161	Doctor	-Con respecto a esta hoja de validación, en el ítem 3, lo califico con 3 porque no entiendo el concepto de universo, materia de estudio. -Con respecto al ítem 8, lo califico con 4 porque no se conoce el nivel socio cultural de cada uno de los usuarios. -Finalmente, debo sugerir que, si esta investigación se piensa desarrollar en un nivel RELACIONAL, debería formularse bien el enunciado del título de investigación y mejorar el dimensionamiento de las variables a estudiar.
Tania Maribel Llanto Herrera	Enfermera CE: 032865	Magister	Se sugiere quizás menos preguntar ya que va dirigido a pacientes, que no están acostumbrados a entrevistas extensas
Yiset La Rosa Gonzales	Fisioterapeuta CTMP: 10593	Licenciada Bachiller	Ninguna, Todo está dentro el parámetro de tu tema de investigación, sugiero que, para una mejor praxis tu cuestionario adecuarlo al Google Forms y se más viable para poder levantar la información con una mejor claridad.
Elsa Melgarejo Castro	Ama De Casa	Secundario	Ninguno
Diana Gamarra Oblitas	Comerciante	Secundario	Ninguno
Maritza Gálvez Barrantes	Ama De Casa	Secundario	Me parece correcto, pero sería bueno colocar una pregunta que evidencias si se realiza actividad física o no
Juan Francisco Llanos Avalos	Obrero	Secundario	Algunas preguntas se repiten
Miguel Alejandro Bustamante Ubilla	Ing. Comercial, Docente Universitario https://orcid.org/0000-0002-5079-9856	Doctor	Ninguno

Nota: fuente propia

Según lo revisado no se realizó cambios al instrumento debido a que se esta cumpliendo con la cantidad de ítems según las dimensiones consideradas (Freiberg et al., 2013). **Anexo H.** Comentarios de Juicios de expertos

Confiabilidad: Se han realizado múltiples estudios a nivel mundial, donde se determinó su viabilidad como instrumento con un alfa de Cronbach mayor a 0,7 en su puntaje general (Cáceres et al., 2018), con respecto a cada ítem las escalas como Rol, emocional, físico y función física superan por mucho el alfa de Cronbach con una puntuación mayor a 0.9 (Argumé y Alvarez, 2017) mientras que las otras 5 escalas superan el 0,7, por lo tanto, se concluye que el instrumento si tiene estabilidad y consistencia (León, 2019).

*La “confiabilidad o fiabilidad” es una herramienta metodológica que reduce muestra el error de medición de un instrumento sobre todos sus indicadores apelando a la varianza sistemática y/o varianza por azar cuan más cerca se encuentre de valor 1 indica que más confiable su aplicación (Quero, 2010). Los estimadores más conocidos para comprobar la fiabilidad son: Alfa ordinal, Coeficiente H, Coeficiente β , coeficiente GLB, Theta de armor, coeficiente alfa de Cronbach, siendo este último el más empleado en los estudios (Ventura, 2019). A continuación, se muestra el resultado de confiabilidad en la tabla 11, este resultado se basó en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.***

Tabla 11. Confiabilidad del instrumento – valor del coeficiente alfa de Cronbach

Fórmula	Elementos hallados
$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right]$	k: Número de ítems del instrumento $\sum_{i=1}^k S_i^2$: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 36 S_T^2: Varianza total del instrumento. 31.566 313.924
α : Coeficiente de confiabilidad del cuestionario = 0.93 - Excelente confiabilidad (0.72 a 0.99)	

Nota: extraído del programa SPSS29

4.4.3. Procedimiento de recolección de datos

El presente estudio se iniciará con la toma de contacto con las respectivas Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) para recibir el permiso para la aplicación de las encuestas mediante una carta de presentación que emitirá la Universidad Continental desde la dirección académica de post grado - doctorado, una vez recibida la venia se procederá a acercarse personalmente a cada centro de salud para coordinar la fecha de la encuesta, se le presentará la carta de autorización de la respectiva DIRIS, plan de trabajo, la muestra que se va a requerir en cada centro de salud según el cuadro de distribución presentado en el apartado de 4.3.2 muestra. (DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Centro, 2024)

Se coordinará el inicio de las entrevistas de los pacientes según el plan de trabajo entre los meses de setiembre y octubre del 2025. Cuando se tenga el contacto con el paciente primero se hará una presentación del estudio, se le pedirá su permiso para iniciar la entrevista, se le invitará a leer el consentimiento informado y detalles de los cuestionarios, luego de la toma de datos según el instrumento. (Medina et al., 2023)

La información recibida será codificada e ingresada a un libro de Excel según las opciones en un cuadro de doble entrada donde las columnas serán las respuestas de cada pregunta y las filas son toda la data de cada participante (quien recibirá un número para mantener su anonimato y solo el investigador conocerá a quien le pertenece) (Zabaleta et al., 2020). Se adjuntará observaciones si en el caso se presentase. Los datos serán ingresados al programa SPSS 29 según el orden preparado. Solo serán ingresados aquellos que cuentan con la información completa para evitar sesgos. (Celis y Labrada, 2014)

El instrumento será trabajado en una escala de respuesta tipo escala Likert de 6 puntos (1 a 6), los cuales van desde totalmente en características negativas de la calidad de vida (1) a características positivas (5 o 6) esto puede tener una consistencia interna de Alfa de Cronbach situada en 0,88 (Román, et al. 2016)

Aspectos éticos: En esta investigación se respetará las consideraciones éticas que establece Belmont, tales como el principio de “No maleficencia y Beneficencia”, “Justicia y Respeto” y “Autonomía”, todos los participantes podrán participar con confiabilidad, sin ningún pago o cobro de por medio; por ello se hará el empleo del Consentimiento Informado donde se explica el propósito, objetivo, requisito, procedimientos y riesgo del presente estudio, así como las personas responsables; también se les indicará que se mantendrán en anonimato sus respuestas (Medina M. , 2021).(**Anexo F.** Consentimiento informado)

Los principios bioéticos que se garantizaron en este estudio son:

- No maleficencia: No se realizará ningún procedimiento que pueda hacerles daño a los participantes en este estudio.
- Justicia: La muestra se seleccionará sin ningún tipo de discriminación, tratando a los participantes del estudio con igual consideración y respeto.
- Beneficencia: Se aplicará los instrumentos sin costo alguno en aras de la mejora de las condiciones de la calidad de vida de los participantes.
- Autonomía: en el estudio, solo se incluirán los pacientes que acepten voluntariamente participar y se respetara la decisión de querer permanecer dentro del mismo.

4.5. Técnicas de análisis de datos

Luego de la recogida de los datos, estos serán analizado mediante la estadística descriptiva e inferencial en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 29 donde previamente los datos fueron ingresados (la explicación está en el apartado 4.4.3. Se hará uso de análisis descriptivo de variables como frecuencia, medias y modas sé si requiere (Celis y Labrada, 2014). Estos estadísticos serán para describir a la muestra, las variables y a cada pregunta por qué nos permitirá recopilar y organizar esta información (Ponce et al., 2020) **Anexo G.** Análisis estadístico

La **primera fase es la descriptiva** de las variables:

- Perfil de la muestra (variables cualitativas/ordinales): frecuencias absolutas y relativas (%), tablas y gráficos de barras/apilados.
- SF-36 categorizado (niveles): frecuencias/% por grupo.
- Calidad métrica del instrumento: Consistencia interna: α de Cronbach (Martínez A. , 2018).

La **segunda etapa se procede a realizar el análisis del instrumento** en función de los datos recabados.

- Se emplea en un primer momento el “Modelamiento factorial exploratorio” (AFE), en el cual mediante las cargas factoriales permitirán establecer la correlación entre las variables con sus respectivos factores empleando matrices. (Garson, 2013).
- El AFE permite validar constructos con una significancia usual de $p < 0.05$ (Verenzuela et al., 2024), lo recomendable es emplear el Alfa de Cronbach (Jimenez y Bustamante, 2020), previo a esto se corroborará las unidireccionales de las preguntas de las escalas aplicadas, a fin de asegurar la simpleza de la manipulación de variables y datos (Lapo y Bustamante, 2018). Las preguntas que no presenten una confiabilidad no pasarán a la siguiente etapa (Jimenez y Bustamante, 2020).
- El AFE, como herramienta de análisis, aparte de validar el constructo (concepto teórico que se pretende evaluar) (Martínez J. , 2019), tiene la utilidad de estandarizar las puntuaciones sobre la base de las percepciones de los participantes, incluso los factores analizados pueden generar factores más específicos (Cancino et al., 2016). El AFE requiere que se de soporte usualmente con la rotación Oblimin para los valores sean aceptables (Arita, Percepción de la calidad de vida: modelo factorial confirmatorio, 2007).
- La rotación menciona permite ordenar de una forma simplificada la estructura de los constructos (Lóopez y Gutiérrez, 2019). También emplea las correlaciones Policórica (debido a que se está analizando datos dicotómicas y ordinales) (Freiberg et al., 2013) empleando el criterio de Kaiser (indica que solo se mantienen las preguntas o factores superiores a

- 1) (Pizarro y Martinez, 2020), análisis del gráfico de sedimentación de autovalores (determina el número de factores que son significativos, además que determinar cuáles pueden ser descartados sin afectar la significancia) (Moliner et al., 2017) y porcentajes de varianza (Valderrama, 2023).
- El Modelamiento Factorial Exploratorio (MFE) (Martínez J. , 2019) es una técnica estadística que se utiliza para identificar patrones subyacentes en los datos, con el objetivo de reducir la dimensionalidad y descubrir las estructuras latentes o factores que explican la correlación entre las variables observadas (Pizarro y Martinez, 2020).
 - Se resalta que las ventajas de AFE es la reducción de la complejidad de los instrumentos, identificar relaciones y patrones entre variables no tan obvios, mejora de la interpretación, optimización en la toma de decisiones del uso del instrumento, genera un análisis multivariado más eficaz, mejora la evaluación de constructos teóricos, permite una preparación para análisis posteriores (Custodio et al., 2017)
 - Para comprobar la adecuación de las preguntas verificadas se da la segunda etapa, se realizó el planteamiento de un “Modelamiento estructural confirmatorio” debidamente soportado (Izquierdo et al., 2014) considerando el análisis de los ítems originales del constructo a fin de verificar la consistencia de las variables del modelo.
 - Para ello se aplicaron los pasos previos del análisis confirmatorio (Forero y Gómez, 2017) a fin de ratificar las variables latentes del modelo. En este contexto, se optó por sensibilizar los estimadores estandarizados e índices de significación (Marsh et al., 2014) que resultan del modelamiento estructural Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM) y que se ratifican mediante los índices de bondad de ajuste pertinentes. (Zabaleta et al., 2020).
 - Este procedimiento se aplicará a las preguntas del SF-36 y las demás variables.

Tercera fase de la estadística inferencial - Asociaciones/contrastaciones bivariadas

- Cualitativas (sexo, religión, procedencia, acceso, empleo, preexistencias, etc.) vs. nivel de CV: Chi - cuadrado de asociación.
- Edad por grupos, Tiempo de enfermedad vs. nivel de CV: Chi - cuadrado de asociación.

En conclusión, para esta etapa la búsqueda de relación entre las variables en esta fase se dará mediante prueba de Chi cuadrado de Pearson (Lapo y Bustamante, 2018) y Regresión Multinomial, nivel de significancia 0.05 en todos los objetivos específicos y en el objetivo general (Celis y Labrada, 2014) (Lloret et al., 2014) (Aguilar, 2017). (Valderrama, 2023).

Como soporte de estas relaciones y variaciones se emplea el Análisis de Covarianza (ANCOVA) como medio de relación entre variables, pero se enfoca principalmente en la comparación de medias de una variable dependiente e independientes (covariables) (Nolasco, 2021). Se aplica a variables continuas, variable categórica y la variable dependiente. De esta forma, se puede observar si las diferencias en la variable dependiente entre grupos permanecen después de controlar las covariables, usa la comparación de medias (Barrera et al., 2020) (Ortiz y Fernández, 2018) El ANOVA permite establecer la incidencia o efecto de los factores, comprueba hipótesis. Existen ANOVA de un factor o de dos factores (Mayorga et al., 2022)

Capítulo V: Aspectos administrativos

Los aspectos administrativos del presente proyecto se conforman por el presupuesto y cronograma de trabajo.

5.1. Presupuesto (Recursos humanos, logísticos, tecnológicos y otros)

El presupuesto del presente proyecto se detalla a continuación (tabla 10):

Tabla 12. Presupuesto del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO (DOL)
A. Recursos humanos		
Investigador principal	Persona que diseña la investigación y dirige las actividades	-
Encuestadores	Persona que aplica los cuestionarios	\$550
Estadístico	Persona que analiza los datos y brinda resultados al investigador principales	\$550
B. Recursos materiales		
Materiales de oficina	Necesario para los tramites documentarios, permiso y aplicación de los cuestionarios.	\$180
C. Recursos tecnológicos		
1 Computador	Equipo donde se diseña la investigación	\$700
1 Tablet	Equipo que puede digitalizar los cuestionarios	\$500
D. Otros		
Movilidad	Traslado a todo Lima metropolitana	\$180

Nota: Elaboración propia

5.2. Cronograma de actividades

Las actividades programadas para el presente proyecto son (tabla 11):

Tabla 13. Cronograma del proyecto

Capítulo	Actividades	2024			2025											
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Capítulo I: Planteamiento del problema	Redacción del planteamiento del problema	X														
Capítulo II: Marco teórico	Revisión de literatura	X														
	Redacción del marco teórico	X														
Capítulo III: Hipótesis y variables/ Supuestos y categorías	Definición de variables y categorías		X													
	Redacción de la hipótesis y categorías			X												
Capítulo IV: Metodología	Diseño del método de investigación				X											
	Redacción de la metodología					X										
	Aprobación de la tesis							X								
Capítulo V: Resultados de investigación	Ejecución de la tesis y recolección de datos												X	X	X	X
	Tratamiento de resultados												X	X	X	X
	Desarrollo de discusión, resultados y conclusiones															X
Revisión y ajustes finales	Revisión y ajustes finales															X
Entrega final	Entrega de tesis															X

Nota: Elaboración propia

Referencias

- Agüero, B. (2019). *Calidad de vida y satisfacción laboral en los trabajadores de la sede administrativa de la DIRIS Lima Norte - 2018*. Universidad Cesar Vallejo.
- Bautista, L. (2017). La calidad de vida como concepto. *Revista Ciencia y Cuidado*, 14(1), 5-8.
- Jimenez, A., & Bustamante, M. (2020). Apoyo directivo y consecuencia de carrera en la conciliación trabajo-familia, en el sector de ventas al por menor (retail) en Chile. *Información Tecnológica*, 31(2), 63-72.
- Singaram, S., & Naidoo, M. (2019). The physical, psychological and social impact of long bone fractures on adults: A review. *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine* , 11(1), 1-9.
- Aguilar, T. (2017). *“Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Salud SF – 36 en pacientes on enfermedades crónicas de Chimbote”*. Universidad Cesar Vallejo (tesis de grado).
- Aliaga, E., Cuba, S., & Mar, M. (2016). Promoción de la salud y prevención de las enfermedades para un envejecimiento activo y con calidad de vida. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33, 311-320.
- Álvarez, A. (2020). *Matriz de consistencia y Matriz de operacionalización de variables*. Universidad de Lima.
- Ambriz , Y., Menor , R., Campos, I., & Cardiel, M. (2015). Calidad de vida relacionada con la salud en artritis reumatoide, osteoartritis, diabetes mellitus, insuficiencia renal terminal y población geriátrica. Experiencia de un Hospital General en México. *Reumatología Clínica*, 11(2), 68-72.
- Anand, P., Hunter, G., & Smith, R. (2005). Capabilities and well-being: evidence based on the Sen–Nussbaum approach to welfare. *Social Indicators Research*, 74, 9-55.

- APEIM. (2021). Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. Presentación del Comité de Niveles Socioeconómicos (NSE). Lima, Lima, Perú. https://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2022/08/2021-APEIM-NSE-Presentacion_Comite-Vfinal2.pdf
- Argumé, L., & Alvarez, D. (2017). Calidad de vida en el adulto mayor que presenta dolor lumbar crónico con un programa de ejercicios acuáticos. *Testis para optar el título profesional*. Lima, Lima, Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Arita, B. (2005). Satisfacción por la vida y teoría homeostática del bienestar. *Psicología y Salud*, 15(1), 121-126.
- Arita, B. (2007). Percepción de la calidad de vida: modelo factorial confirmatorio. *Psicología y Salud*, 12(1), 191-198.
- Arque, R. (2021). Clima organizacional y estrés laboral del personal Centro de Salud Jaime Zubieta del distrito San Juan de Lurigancho-2018. *Tesis para optar el título profesional*. Lima, Lima, Peru: Universidad Cesar Vallejo.
- Ausín, B., Zamorano, A., & Muñoz, M. (2020). Relationship between Quality of Life and Sociodemographic, Physical and Mental Health Variables in People over 65 in the Community of Madrid. *Revista internacional de investigación medioambiental y salud pública*, 17(22), 8528.
- Barceló, R., Ornelas, M., & Blanco, H. (2021). Utilización del Cuestionario de Salud SF-36 en personas mayores. Revisión sistemática. *Ansiedad estrés*, 27, 95-102.
- Barrera, J., Narváez, J., & Caiza, F. (2020). Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. *Cambios rev. méd*, 19(2), 25-31.
- Bilbeny, N. (2019). Dolor crónico en Chile. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 30(6), 397-406.
- Bispo, J. (2022). La fisioterapia en los sistemas de salud: marco teórico y fundamentos para una práctica integral. *Salud colectiva*, 17, 3709.

- Boluarte, A., & Tamari, K. (2017). Validez de contenido y conabilidad inter-observadores de Escala Integral Calidad de Vida. *Revista de Psicología (PUCP)*, 35(2), 641-666.
- Borda, M., Acevedo, J. C., Gabriel, D., Morros, E., & Cano, C. A. (2016). Dolor en el anciano: calidad de vida, funcionalidad y factores asociados. Estudio SABE, Bogotá, Colombia. *Revista Española de Geriátría y Gerontología*, 51(3), 140-145.
- Bran, L., Valencia, A., Palacios, L., Gómez, S., Acevedo, Y., & Arias, C. (2020). Barreras de acceso del sistema de salud colombiano en zonas rurales: percepciones de usuarios del régimen subsidiado. *Hacia la promoción de la Salud*, 25(2), 29-38.
- Briani, R., Ferreira, A., Pazzinatto, M., Pappas, E., De Oliveira, D., & de Azevedo, F. (2019). What interventions can improve quality of life or psychosocial factors of individuals with knee osteoarthritis? A systematic review with metaanalysis of primary outcomes from randomised controlled trials. *British Journal of Sports Medicine*, 53(14), 901-902.
- Bustamante, M., Alvarez, A., Villalobos, M., & Lucero, M. (2020). Percepción de la calidad de vida laboral de los trabajadores de los centros de salud familiar de la zona central de Chile. *Información tecnológica*, 3, 65-74. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642020000300065&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0764. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642020000300065>.
- Caballero, J. (2019). Dolor de hombro y actividades de la vida diaria en adultos mayores del Hospital San Juan De Lurigancho-2018. *Tesis para optar el título profesional*. Lima, Lima, Perú: Universidad Federico Villarreal.
- Caceres, E. (2021). Calidad de vida de los adultos mayores en el Centro de Salud San Jerónimo, Cusco 2020 . *Tesis de Magister*. Lima, Lima, Peru: Universidad César Vallejo.

- Cáceres, F., Parra, L., & Pico, O. (2018). Calidad de vida relacionada con la salud en población general de Bucaramanga, Colombia. *Revista de Salud Pública*, 20, 147-154.
- Cáceres, F., Parra, L., & Pico, O. (2018). Calidad de vida relacionada con la salud en población general de Bucaramanga, Colombia. *Rev. salud pública*, 20(2), 147-154.
- Campbell, A., Converse, P., & Rodgers, E. (1976). *The Quality of american life: Perceptions, Evaluatións and Satisfactiósns* New York: Russel Sage Foundati6n.
- Cancino, N., González, C., Gallardo, I., & Estrada, C. (2016). Evaluaci6n de un modelo de calidad de vida construido desde los datos. *Acta Colombiana de Psicología*, 19(1), 297-309.
- Carbone, F. (abril de 2023). Matriz de consistencia II. Principios y fundamentos de la Atenci6n Primaria de la Salud (APS) y su presencia en la PNMS, MCI Y RIS. *Biblioteca respons6vel*, 9.
- Cardona, D., & Agudelo, H. (2005). Construcci6n cultural del concepto calidad de vida. *Revista Facultad Nacional de Salud P6blica*, 23(1), 79-90.
- Casas, P., Apaza, R., Del Canto, J., & Ch6vez, H. (2016). Atenci6n sociosanitaria de los adultos mayores en el Per6. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud P6blica*, 33, 351-356.
- Castell, M., Prieto, M., Guti6rrez, A., Vi6nals, J., Schwarz, C., G6lvez, M., . . . Polentinos, E. (2021). Calidad de vida y actividad f6sica en individuos prefr6giles mayores de 70 a6os en atenci6n primaria. *Revista espa6ola de salud p6blica*(95), 87.
- Castro, A. (2009). El bienestar psicol6gico: cuatro d6cadas de progreso. *Revista Interuniversitaria de Formaci6n del Profesorado*, 23(3), 43-72.
- Caycho, T., Dominguez, J., & Barboza, M. (2019). Funcionamiento cognitivo y comportamental, y calidad de vida en adultos mayores. *Enfermer6a Cl6nica*, 57-58.

- Celis, A., & Labrada, V. (2014). *Bioestadística* (3ra ed.). Manual Moderno.
- Cevallos, D. (2016). Centro de medicina física y rehabilitación en San Juan de Lurigancho. *Tesis para optar el título profesional*. Lima, Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Chester, R., Jerosch, C., Lewis, J., & Shepstone, L. (2019). Psychological factors are associated with the outcome of physiotherapy for people with shoulder pain: a multicentre longitudinal cohort study. *British journal of sports medicine*, 52(4), 269-275.
- Chunga, R., Arteaga, C., & Delgado, E. (2022). Remuneración Salarial y su Incidencia en la Calidad de Vida de la Zona Urbana del Cantón Jipijapa. *Dominio de las Ciencias*, 8(1), 384-402.
- Comachio, J., Oliveira, M., De Moura, A., & Pasqual, A. (2018). A cross-sectional study of associations between kinesiophobia, pain, disability, and quality of life in patients with chronic low back pain. *Advances in Rheumatology*, 58, 8.
- Condezo, Y., & Quispe, P. (2022). Relación entre funcionalidad familiar y calidad de vida en el adulto mayor del Centro de Salud de Chilca - 2022. *Tesis de Grado*. Huancayo, Huancayo, Perú: Universidad Continental.
- Congreso de la República. (29 de julio de 2003). Ley General de Educación. *Ley N.º 28044*. Lima, Lima, Peru: Gob.pe. <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118378-28044>
- Coronel, G., Sánchez, Y., & Asenjo, J. (2023). Calidad de vida según características demográficas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Revista Finlay*, 13(3), 265-272.
- Cosentino, V. (2024). CAPÍTULO 4: Manifestaciones extra musculoesqueléticas en espondiloartritis axial 1: uveítis y psoriasis. *Revista Argentina de Reumatología*, 35(1), 31-38.
- CPI. (2023). Centro de Población Internacional. Estadísticas poblacionales 2023. Lima, Lima, Perú. <https://cpi.pe/banco/estadisticas-poblacionales.html>

- Cuba, M., Jurado, A., Romero, Z., & Cuba, M. (2013). Características familiares asociadas a la percepción de la calidad de vida en pobladores de un área urbano-marginal en el Distrito de Los Olivos, Lima. *Revista Médica Hered.*, 24, 12-16.
- Custodio, J., Murawski, B., Elizathe, L., & Rutsztein, G. (2017). Calidad de vida relacionada con la salud: análisis factorial exploratorio del RAND-26 en mujeres de Buenos Aires. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 9(2), 34-49.
- Daubermann, D., Stover, j., de la Iglesia, G., & Fernández, L. (2013). Polychoric And Tetrachoric Correlations In Exploratory And Confirmatory Factorial Studies. *Prensa Médica Latinoamericana. Ciencias Psicológicas*, 7(2), 151-164.
- DIRIS Lima Centro. (09 de 2024). *DIRIS Lima Centro*. Establecimientos de salud DIRIS LC: <https://dirislimacentro.gob.pe/wp-content/uploads/ESTABLECIMIENTOS-DE-SALUD-DIRIS-LC-v1.pdf>
- DIRIS Lima Centro. (s.f.). *Trazadores sanitarios: Estrategias sanitarias*. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro: <https://dirislimacentro.gob.pe/trazadores-sanitarios/estrategias/>
- DIRIS Lima Norte. (2022). *Análisis de situación de Salud*. MINSA.
- El Peruano. (15 de 09 de 2024). *gob.pe*. Decreto Supremo N.º 008-2012-SA: <https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29561.pdf>
- El Peruano. (15 de 09 de 2024). *Normas Legales*. El Peruano: <https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/L-31600.pdf>
- Escobar, A., & Osuna, F. (2013). Revisión teórica y medida del concepto de calidad de vida. *ACE: architecture, city and environment*, 8(22), 99-122.
- Escobar, J. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. . *Avances en Medición*, 6(1), 27-36.
- Etihc. (15 de 09 de 2024). *Ethic*. <https://ethic.es/2024/03/el-origen-de-la-cultura/>

- Feria, H., Mantilla, M., & Mantecón, S. (2020). La entrevista y la encuesta ¿Método o técnica de indagación empírica? *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 11(3), 62-79.
- Fernández, I., Trinidad, M., & Tomas, J. (2020). Impacto del estatus de fragilidad sobre la salud y calidad de vida en personas mayores españolas. *Atención Primaria*, 52(10), 731-737.
- Flores, B., Castillo, Y., Ponce, D., Miranda, C., Peralta, E., & Durán, T. (2018). Percepción de los adultos mayores acerca de su calidad de vida. Una perspectiva desde el contexto familiar. *Revista de enfermería del instituto mexicano del seguro social*, 26(2), 83-88.
- Forero, D., & Gómez, A. (2017). Comparison of measurement models based on expectations and perceived performance for the satisfaction study in health services. *Suma Psicológica*, 24(2), 87-96. <https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2017.06.002>
- Freiberg , H., Stover, J., De la Iglesia , G., & Fernández, L. (2013). Polychoric and Tetrachoric Correlations in Exploratory and Confirmatory Factorial Studies. *Prensa Médica Latinoamericana, Ciencias Psicológicas*, 7(2), 151-154.
- Gálvez, I., Cáceres, M., Guerrero, J., López , C., & Durán, N. (2021). Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diabetes mellitus en una zona básica de salud. *Enfermería Clínica*, 31(5), 313 - 322.
- García, R., Irarrázaval, M., López, I., Riesle, S., Cabezas, M., Moyano, A., . . . Rattazzi, A. (2022). Encuesta para Cuidadores de Personas del Espectro Autista en Chile. Acceso a Servicios de Salud y Educación, Satisfacción, Calidad de Vida y Estigma. *Andes Pedriátrica*, 93(3), 351-360.
- García.F, F. (2022). Percepcion de la fisioterapia y su relacion con la calidad de vida en pacientes del centro medico especializado en terapia fisica y rehabilitacion activa. *Tesis para obtener título profesional*. Lima, Lima, Perú: Universidad Norbert Wiener.
- Garson, D. (2013). Factor Analysis. Asheboro: North Caroline State University Press. Blue Books Serie.

- Gobbens, R., & Van, M. (2018). Associations of Environmental Factors With Quality of Life in Older Adults. *The Gerontological Society of America*, 58(1), 101-110.
- Gobbenss, R., & Remmen, R. (2019). The effects of sociodemographic factors on quality of life among people aged 50 years or older are not unequivocal: comparing sF-12, WhOQOL-BreF, and WhOQOL-OLD. *Clinical Interventions in Aging*, 14, 231 - 239.
- González , C., Hernández, F., Muñoz, R., Ruíz, P., Medrano, L., & Cano, A. (2018). La asociación entre diferentes dominios de la calidad de vida y Síntomas en pacientes de atención primaria con trastornos emocionales. *Scientific Reports*, 8(1), 11180.
- González, C. (2014). *Calidad de atención percibida y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes participantes de estudios clínicos de la IPS IDEARG SAS*. Universidad del Rosario.
- Gribble, P., Kleis, R., Simon, J., Vela, L., & Thomas, A. (2022). Dierences in health-related quality of life among patients after ankle injury. *Frontiers in Sports and Active Living*, 4, 909 - 921.
- Guerrero, R., Galán, S., & Armáss, O. (2017). actores sociodemográficos y psicológicos asociados al autocuidado y la calidad de vida en adultos mexicanos con Diabetes Mellitus tipo 2. *Acta Colombiana de Psicología*, 20(2), 168-177.
- Guevara, A., & Sánchez, J. (2022). Grado de dolor, trastornos musculoesqueléticos más frecuentes y características sociodemográficas de pacientes atendidos en el Área de Terapia Física y Rehabilitación de un centro médico de Villa El Salvador, Lima, Perú. *Horizonte Médico*, 22(3), e1959.
- Haro, A., Chisag, E., Ruiz , j., & Caicedo, j. (2024). Tipos y clasificación de las investigaciones . *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 956.
- Hays, R., Sherbourne, C., & Mazel, R. (1993). Encuesta de salud RAND de 36 ítems 1.0. *Economía de la salud*, 2(3), 217-227.

- Hernandez, J., Chavez, S., & Yhuri, N. (2016). Salud y calidad de vida en adultos mayores de un área rural y urbana del Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33, 680-688.
- Hernández, R. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas*. Mc Graw Hill Education .
- Hopewell, S., Copsey, B., Nicolson, P., Adedire, B., Bonifacio, G., & Cordero, S. (2020). Multifactorial interventions for preventing falls in older people living in the community: a systematic review and meta- analysis of 41 trials and almost 20 000 participants. *British journal of sports medicine*, 54(22), 1340 - 1350.
- IINEI. (2022). “*Perú: Estado de la Población en el año del Bicentenario, 2021*”. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
- INEI. (2023). *Perú: Enfermedades no transmisibles y transmisibles 2022*. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- INEI; OIM. (2015). *Migraciones Internas en el Perú a nivel departamental*. Lima: a Organización Internacional para las Migraciones (OIM). https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbd1951/files/Documentos/20-03-2017_Publicaci%C3%B3n%20Migracion%20Interna%20por%20Departamentos%202015_OIM.pdf
- INEI. (2024). *Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, Informe técnico 01 Enero 2024*. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_empleo_oct_nov_dic2023.pdf
- Izquierdo, I., Olea, J., & Abad, F. (2014). Exploratory factor analysis in validation studies: Uses and recommendations. *Psicothema*, 26(3), 395-400. <https://doi.org/10.7334/psicothema2013.349>
- Jáuregui, A. I. (2019). Calidad de Vida de la persona adulta mayor perteneciente al Programa Gerontológico Social de dos provincias de Ica, Perú 2017. *Población y Salud en Mesoamérica*, 16(2), 28-17.

- Jemes , I. (2022). Calidad de Servicio en Atención Temprana: Influencia sobre la calidad de vida familiar y percepción de los profesionales. *Tesis doctoral*. Málaga, Málaga, España: Universidad de Málaga.
- Kaplan, R., & Hays, R. (2022). Health-Related Quality of Life Measurement in Public Health. *Annual Reviews Public Health*, 43(1), 355-373.
- Kemp, J., Mosler, A., Hart, H., Bizzini, M., Chang, S., Scholes, M., . . . Crossley, K. (2020). Improving function in people with hip- related pain: a systematic review and meta- analysis of physiotherapist- led interventions for hip-related pain. *Revista británica de medicina deportiva*, 54(23), 1382-1394.
- Kenny , M. (2017). *Historia de la fisioterapia en Ecuador* (Primera edición ed.). Quito, Quito, Ecuador: Udla.
- Khan, K. (2009). Another major win for physiotherapy curing patellofemoral pain. *British journal of sports medicine*, 43(3), 157-158.
- Lapo, M., & Bustamante, M. (2018). Incidencia del Clima Organizacional y de las Actitudes Laborales en el Comportamiento Prosocial de los Profesionales de la Salud del Guayas Ecuador. *Información Tecnológica*, 29(5), 245-258.
- Lemey, S., Castro, S., Cubillos, L., Suarez, F., Torrey, W., Uribe, J., . . . Gómez, C. (2021). Calidad de vida relacionada a salud y alfabetización en salud en pacientes adultos en centros de atención primaria con afiliación al régimen subsidiado o contributivo en Colombia . *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 50(1), 23-31.
- León, G. (2019). Calidad de vida del anciano que asiste a un taller de adulto mayor de una institucion de salud privada del Rimac". *Tesis para optar el título profesional*. Lima, Lima, Perú: Universidad Norbert Wiener.
- Leva, G. (2005). *Indicadores de calidad de vida urbana. Teoría y metodología*. Habitat. Metropolis.
- Lima, P. W. (2021). *Calidad de vida de los usuarios en tiempo de Covid-19 del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Corvel-Chosica, Carapongo 2020*. Universidad César Vallejo.

- Lins, L., Carvalho, F., Menezes, M., Porto, L., & Damasceno, H. (2015). Health-related quality of life of students from a private medical school in Brazil. *Revista internacional de educación médica*, 6, 149.
- Lista, A., Gonzáles, L., & Souto, S. (2020). ¿Qué papel desempeña la Fisioterapia en la pandemia mundial por Covid-19? *Fisioterapia*, 42(4), 167-169.
- Lloret, S., Ferreres, A., Hernández, A., & Tomás, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de psicología*, 30(3), 1151-1169.
- Lodhi, F., Montazeri, A., Nedjat, S., Mahmoodi, M., Farooq, U., Yaseri, M., . . . Holakouie-Naieni, K. (2019). Assessing the quality of life among Pakistani general population and their associated factors by using the World Health Organization's quality of life instrument (WHOQOL-BREF): a population based cross-sectional study. *Health and Quality of Life Outcomes*, 17, 1-17.
- López, M., & Gutiérrez, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un análisis factorial exploratorio utilizando SPSS. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 1-14.
- Lopera, J. (2020). Calidad de vida relacionada con la salud: exclusión de la subjetividad. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(2), 693-702.
- Lopez, M., Quesada, J., & Lopez, O. (2019). Relación entre calidad de vida relacionada con la salud y determinantes sociodemográficos en adultos de Cuenca, Ecuador. *Revista Económica y Política*(29), 67-86.
- López, M., Quesada, J., & López, Ó. (2019). Relación entre calidad de vida relacionada con la salud y determinantes sociodemográficos en adultos de Cuenca, Ecuador. *Revista Economía y Política* (29), 67-86.
- López, J. J. (2020). Importancia de la inclusión de la fisioterapia en la atención primaria en salud, a la luz de los principios éticos de la atención primaria en salud y el enfoque de las capacidades. *Tesis para optar el título profesional*. Bogotá, Bogotá, Colombia: Universidad El Bosque.

- Lorenzo, J. (diciembre de 2022). Prevalencia de sarcopenia en pacientes con fibromialgia y su asociación con la calidad de vida. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentino.
<https://trovare.hospitalitaliano.org.ar/greenstone/collect/tesisyr/index/assoc/D1991.dir/tesis-lorenzo-jessica.pdf>
- Márquez, G., Loret, C., Bernabé, A., Smeeth, L., Gilman, R., & Miranda, J. (2011). Calidad de vida vinculada a salud en población migrante rural-urbana y población urbana en Lima - Perú. *Revista Peruana de medicina experimental y salud pública*, 28, 35-41.
- Marsh, H., Morin, A., Parker, P., & Kaur, G. (2014). Exploratory structural equation modeling: An integration of the best features of exploratory and confirmatory factor analysis. *Annual Review of Clinical Psychology*(2014), 85-110.
<https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153700>.
- Martinez, A. (2018). *Calidad de vida en personas con enfermedades de parkinson y su relación con la edad, el tiempo de evolucion y el estadio de progresión*. Universidad de Talca - Grado de maestría.
- Martínez, J. (2019). El proceso de elaboración y validación de un instrumento de medición documental. *Acción y Reflexión Educativa*(44), 50-63.
- Martínez, J., Perez, N., & Rivas, H. (2022). El rol del fisioterapeuta dentro de la atención temprana para pacientes con lesion medular traumática en países de latinoamérica y Europa. *Tesis de Grado*. El salvador, El salvador, El salvador: Universodad de El salvador.
- Martinez, O. (2015). Calidad de vida en pacientes con lumbalgia. *Tesis para obtener grado de magister*. Veracruz, Veracruz, México: Universidad Veracruzana.
- Mayorga, J., García D, & Barrena, R. (2019). Cálculo de un indicador de calidad de vida básico para Bogotá por secciones censales mediante análisis factorial. *Revista Perspectiva Geográfica*, 24(1), 53-73.
- Mayorga, R., Graciano, D., Hernández, A., Moctezuma, P., Pérez, B., & Roldan, A. (2022). Cuadro comparativo de Análisis Paramétrico y No Paramétrico.

*Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 10(20), 90-93.*

Medina, M. (2021). *Manual de bioética y bioderecho*. México: Fondo de Cultura Económica.

Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., & Castillo, R. (2023). *Metodología de la investigación*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú.

MIINSA. (2008). *Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú*. Lima: Ministerio de Salud.
https://bvs.minsa.gob.pe/local/promocion/203_prom30.pdf

Mimbela, N. (2022). Relación calidad del servicio de fisioterapia física respiratoria y calidad de vida en paciente post-COVID-19. Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo. *Tesis de grado*. Trujillo, Trujillo, Perú: Universidad César Vallejo.

MINEDU. (2024). *Ministerio de Educación*.
https://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf

Ministerio de Salud del Perú. (2024). *Informe de gestión anual 2024*. Ministerio de Salud del Perú: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/7103969>

Ministerio de Salud del Perú. (s.f.). *Panel de indicadores sanitarios interactivos 1 [Power BI]*.
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMDgzMGYwNWYtZjU4ZC00OTY4LWE2MjgtZDYxY2IzNjk1YTdhliwidCI6IjE1ZWUxLWZmYTAtNDI0My05N2YyLTZjNjJhNmlyYmM3ZSIsImMiOiR9>

Ministerio de Salud;. (28 de 09 de 2024). *OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN*.
<https://www.minsa.gob.pe/presupuestales/?pg=8#contact>

MINSA. (2024). Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico, enero 2024. Lima, Perú.

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5864193/5196462-boletin-epidemiologico-enero-2024.pdf>

- MINSAA. (2019). Carga de enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida Saludables perdidos. Lima: Ministerio de Salud.
- Misrach, C., & Espinoza, I. (2005). Utilidad de las Mediciones de la Calidad de vida relacionada con la salud. *Revista Dental de Chile*, 96(2), 28-35.
- Moliner , L., Aguirre, A., Domenech, A., Vallet, T., Vallet, I., & Alegre, F. (2017). Diseño, validación y análisis factorial exploratorio y confirmatorio de la escala de actitud Cohesiona para la evaluación de la eficacia de los talleres de habilidades cooperativas. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 43(1), 213-234.
- Morales, F. (2016). Servicios de rehabilitación y calidad de vida de las personas con discapacidad física de la ciudad de Tacna, Tacna - 2015. *Tesis de grado*. Lima, Lima, Perú: Universidad Alas Peruanas.
- Mroczek, B., Łubkowska, W., Jarno, W., Jaraczewska, E., & Mierzecki, A. (2020). Occurrence and impact of back pain on the quality of life of healthcare workers. *Anales de medicina agrícola y ambiental*, 27(1), 36-42.
- Nava, G. (2012). La calidad de vida: Análisis multidimensional. *Enfermería Neurológica*, 11(3), 129-137.
- Nolasco, A. (2021). *Análisis de datos continuos. Modelos de Análisis de la Varianza y de la Covarianza*. Métodos Estadísticos Avanzados en Salud Pública.
- OIT. (15 de 09 de 2024). *Organización Internacional del trabajo*. Trabajo y empleo: <https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3315?page=1#:~:text=Conjunto%20de%20actividades%20humanas%2C%20remuneradas,sustento%20necesarios%20para%20los%20individuos>.
- Ortigosa, M. (2024). La teoría homeostática presente en la medición de la satisfacción con la vida en México a través de un sistema de inferencia difuso. *Contaduría y Administración*, 69(3), 24-48.

- Ortiz, M., & Fernández, M. (2018). Modelo de Ecuaciones Estructurales: Una guía para ciencias médicas y ciencias de la salud. *Terapia Psicológica*, 36(1), 47-53.
- Otaegui, A. (2020). Efectividad de un programa de fisioterapia multimodal en la capacidad funcional y emocional de adultos mayores con discapacidad intelectual severa. . *Revista de investigación en actividades acuáticas*, 4(7), 42-50.
- Owoeye , O., Paz, J., & Emery, C. (2023). Injury severity at the time of sport-related ankle sprain is associated with symptoms and quality of life in young adults after 3–15 years. *Annals of Medicine*, 55(2), 2292777.
- Pajares, V. (2015). Calidad de vida, Ley Natural y discernimiento moral. *SCRIPTA FULGENTINA: revista de teología y humanidades*, 25(49), 119-132.
- Palacios, E. (2021). Impacto de la salud bucal en la calidad de vida de los adultos mayores de la Clínica Estomatológica de la Universidad Inca Garcilaso de la vega, año 2018-II. *Tesis de grad.* Lima, Lima, Perú: Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
- Pavo, P., & Ramos, F. (2022). El papel de la fisioterapia ante las necesidades actuales de rehabilitación a nivel mundial. *Fisioterapia*, 44, 261-263.
- Peña, E., Avila, L. R., Pérez, R., Onofre, D. A., Cruz, I. A., Silvestre, D. A., & Bernal, L. I. (2019). Calidad de vida en adultos mayores de Guerrero, México. *Universidad y salud*, 21(2), 113-118.
- Pereira , J. (2022). Fisioterapia una ayuda hacia una muerte digna en los cuidados paliativos. *Enfermería Oncológica*, 24(1).
- Pizarro, K., & Martinez, O. (2020). Análisis factorial exploratorio mediante el uso de las medidas de adecuación muestral kmo y esfericidad de bartlett para determinar factores principales. *Journal of science and research*, 5(1), 903-924.
- Ponce, R., Palma , K., Alamilla, A., Valdez, D., & Velázquez, U. (2020). Cuadro comparativo "Estadística inferencial y descriptiva". *Educación y Salud*

Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 8(16), 93-95.

Quero, M. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cronbach. *Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 12(2), 248-252.

Rada, I., Ortiz, M., & Cabieses, B. (2023). Calidad de vida relacionada con la salud en chilenos de. *Gaceta Sanitaria*, 37, 102 - 328.

RAE. (15 de 09 de 2024). *Real Academia Española*. DEL: <https://dle.rae.es/>

Ramírez, A., Malo, A., Martínez, P., Montánchez, M., Torracchi, E., & González, F. (2020). Origen, evolución e investigaciones sobre la Calidad de Vida: Revisión Sistemática. *Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica*, 39(8), 954-959.

Reyes, P., & Barría, M. (2019). Imagen social del kinesiólogo en atención primaria de salud: una experiencia chilena. *Revista de Salud Pública*, 21(2), 236-242.

Rodriguez, B., Sanz, D., Sanz, B., Llisterri, J., & Herero, M. (2022). Dolor, calidad de vida y salud mental en pacientes con gonalgia por gonartrosis: estudio de casos y controles. *Medicina de Familia SEMERGEN*, 48(1), 45-53.

Rodriguez, C., Breña, J., & Esenarro, D. (2021). *Las Variables en la investigación de la investigación científica*. Editorial Área de Innovación y Desarrollo,S.L.

Romero , H., Real , J., Ordoñez, J., Gavino, G., & Saldarriaga, G. (2022). *Metodología de la Investigación*. ACVENISPROH Académico.

Rosales, M. (2021). Enfermedades frecuentes del adulto mayor en el servicio de medicina física “Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo” EsSalud-Arequipa 2019. *Tesis de Grado*. Arequipa, Arequipa, Perú: Universidad Continental.

Rosero, E. (2022). Por la construcción de una fisioterapia social: Reflexiones para construir desde el movimiento. *Movimiento científico*, 16(1), 1 - 4.

Ruidíaz, K., & Cacante, J. (2021). Desarrollo histórico del concepto Calidad de Vida: una revisión de la literatura. *Revista Ciencia y Cuidado*, 18(3), 86-89.

- Salaffi, F., Di Carlo, M., Carotti, M., Farah, S., Ciapetti, A., & Gutierrez, M. (2018). The impact of different rheumatic diseases on healthrelated quality of life: a comparison with a selected sample of healthy individuals using SF-36 questionnaire, EQ-5D and SF-6D utility values. *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*, 89(4), 541.
- Salas, C., & Garzón, M. (2013). La noción de calidad de vida y su medición. *CES Salud Pública*, 4, 36-46.
- Salas, C., Osley, M., & Duque, G. (2013). La noción de calidad de vida y su medición. *CES Salud Pública*, 4(1), 36-46.
- SalasC, Osley, M., & Duque, G. (2013). La noción de calidad de vida y su medición. *CES Salud Pública*, 4(1), 36-46.
- Salud Sin Limites Peru. (2012). *Aportes para la operativización del MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, basado en familia y comunidad en el primer nivel*. Lima: Medicus Mundi Navarra Delegación Perú.
- SALUPOLD. (15 de 09 de 2024). *gob.pe*. <https://www.gob.pe/10423-derechos-de-las-personas-usuarias-de-los-servicios-de-salud>
- San José, R. (2015). Dolor lumbar: calidad de vida. *Tesis de grado*. Valladolid, Valladolid, España: Universidad de Valladolid.
- Sen, A., & Nussbaum, M. (1993). *The quality of life* 73. Clarendon Press .
- Shalok, R., & Verdugo, M. (2003). *Calidad de vida : manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales*. Barcelona: Alianza Editorial .
- Simon, J., & Docherty, C. (2018). Health-related quality of life is decreased in middle-aged adults with chronic ankle instability. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 21(12), 1206-1209.
- Suarez, L. (2021). *Calidad de vida en estudiantes de una institucion educativa del centro poblado de Casa Blanca - Cajamarca, 2020*. Universidad Catolica de los Ángeles de Chimbote.
- Svedbom, A., Borgstöm, F., Hernlund, E., Ström, O., Alekna, V., Bianchi, M., . . . Tosteson, A. (2018). Quality of life for up to 18 months after low-energy hip,

- vertebral, and distal forearm fractures—results from the ICUROS. *Osteoporosis International*, 29, 557-566.
- Tarrillo , I. (2023). Calidad de vida y funcionalidad familiar de los adultos mayores del centro de salud Magllanal - Jaén 2022. *Tesis de grado*. Jaen, Cajamarca, Perú: Universidad Nacional de Cajamarca.
- Terrens, A. F., Soh, S.-E., & Morgan, P. (2021). Perceptions of aquatic physiotherapy and health-related. *Health Expectations*, 24(2), 566-577.
- Tonon G, G., & Castro, A. (2012). Calidad de vida en Argentina: percepciones macro y micro sociales. *Estudios Políticos*, 9(27), 157-171.
- Tonon, G. (2009). *Comunidad, participación y socialización política Buenos Aires*. Espacio Editorial.
- Torres, J., Vera, V., Zuzunaga, F., Talavera, J., & De La Cruz, J. (2022). VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CONSUMO DE SAL EN LA POBLACIÓN PERUANA. *Rev. Fac. Med. Hum.*, 22(2), 273-279.
- Ulloa, M. B., & Tipán, L. A. (2017). *La fisioterapia en la parálisis facial y su incidencia en la calidad de vida de los pacientes atendidos en el centro de rehabilitación Física Terapias & Terapias, en el distrito metropolitano de Quito, sector el condado en el período 2015-2017*. Universidad Tecnológica Indoamérica.
- Unquijo, M. (2014). La teoría de las capacidades en Amartya Sen. *EDETANIA*(46), 63-80.
- Urzúa, A., & Caqueo, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Terapia Psicológica*, 30(1), 61-71.
- Urzúa, A., & Caqueo, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Terapia Psicológica*, 30(1), 61-71.
- Valderrama, M. (2023). *Validación de la escala Kidney Disease Quality of Life Short Form 36 (KDQOL-36) para la evaluación de la alidad de vida en pacientes*

colombianos con enfermedad renal crónica. Universidad Nacional de Colombia (Grado de Magister).

Valdivia , A., Peña, L., & Huaco, M. (2020). Instrumento de medición del Índice de Calidad de Vida Urbana: Barrios Urbano Marginales, Perú. *Revista de Ciencias Sociales* , 26(2), 355-375.

Vargas, K., & Lázaro, K. (2020). *Calidad de vida en adultos mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, Lima - 2019*. Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Veenhoven, R. (2001). *Calidad de vida y felicidad: no es exactamente los mismo*.

Ventura, J. (2019). ¿Es el final del alfa de Cronbach? *Adicciones*, 30(1), 80-81.

Vera, M. (2007). Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y para su familia. *Anales de la Facultad de Medicina*, 68(3), 284-290.

Vera, O., & Vera, F. (2013). Evaluación del nivel socioeconómico: presentación de una escala adaptada en una población de Lambayeque. *Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo*, 6(1), 41-45.

Verdugo, M., Schalock, B., Gómez, L., & Arias, B. (2013). *Calidad de Vida*. Salamanca : Amaru.

Verenzuela, D., Salas, A., & Araque, M. (2024). Diseño y validación psicométrica de una escala de medición del clima organizacional en pequeñas y medianas empresas. *Estudios Gerenciales*, 40(172), 297-313.

Vidyaniati, P., Wachjudi, R., Tjandrawati, A., & Hamijoyo, L. (2018). The Correlation Between Disease Activity Assessedby DAS28-ESR and Quality of Life Assessed by SF-36 in Rheumatoid Arthritis Patients. *Indonesian Journal of Rheumatology*, 10(2), 11-16.

Villasís, M., Márquez, H., Zurita, J., Miranda, G., & Escamilla, A. (2018). El protocolo de investigación VII. Validez y confiabilidad de las mediciones. *Revista Alergia México*, 65(4), 414-421.

Wada, T., Kawai, A., Ihara , K., Sasaki, M., Sonoda, T., & Imaeda, T. (2007). Validez de constructo de la puntuación de Enneking para medir la función en

pacientes con tumores malignos o benignos agresivos de la extremidad superior. *J Bone Joint Surg Br*, 89-B(5), 659-663.

Walter, N., Rupp, M., Hierl, K., Pfeifer, C., Kerschbaum, M., Hinterberger, T., & Alt, V. (2021). Long- term patient- related quality of life after fracture- related infections of the long bones. *Bone & Joint Research*, 10(5), 321-327.

WHOQOL. (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. *Social Science and Medicine*, 41(10), 1403-1409.

Zabaleta , M., Brito C., L., & Garzón , M. (2020). Methodology to estimate and evaluate a knowledge management model using structural equations. *Orinoquia*, 24(1), 94-110. <http://doi.org/10.22579/20112629.595>

Zambrano, J. (2021). Fisioterapia en la calidad de vida y discapacidad de pacientes con prótesis por amputación de miembro inferior. *Tesis de master*. Coruña, Coruña, España: Universidad de la Coruña.

Anexos

Anexo A. Matriz de consistencia

Pregunta general	Preguntas específicas	Objetivo general	Objetivos específicos	Variables / Categorías	Dimensiones / Subcategorías	Enfoque, tipo y diseño	Población y muestra	Técnicas e instrumentos
PG: ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo a las características socioculturales de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?	PE1: ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo a la edad de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?	OG Determinar la variación del nivel de calidad de vida de acuerdo con las características socioculturales de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025	OE1: Examinar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a la edad de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025..	Variable 1: Características poblacionales •Sociodemográficas: edad, sexo •Educativas: nivel de instrucción •Laborales: nivel económico, pea, carga familiar •Culturales: procedencia, religión •Clínicas: enfermedades preexistentes, tiempo de enfermedad, acceso a tratamiento	No presenta	Enfoque: cuantitativo Tipo: básica Alcance: exploratoria, descriptiva, correlacional Diseño: no experimental	Población: Pacientes que reciben atenciones de terapia física en centros de salud de la Lima N: 1375 Metropolitana 'Muestra: n: 400 Pacientes 22 centros de Salud Muestreo: muestreo probabilístico aleatorio simple DIRIS Lima Centro n=223	Técnicas: Encuesta Instrumentos: Cuestionario de las características de la población, SF -36 Técnicas de procesamiento de datos: Programa SPSS 29
	PE2: 2. ¿Es diferente el nivel de calidad de vida de acuerdo al sexo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE2: Determinar las diferencias en el nivel de la calidad de vida de acuerdo al sexo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					
	PE3: ¿El nivel de calidad de vida cambia de acuerdo con el nivel de instrucción de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE3: Comparar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al nivel de instrucción de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.	Variable 2: •Calidad de vida	Función física Rol Físico Dolor Corporal Salud general Vitalidad Función social Rol emocional Salud mental			

	PE4: ¿El nivel de calidad de vida se modifica de acuerdo con el nivel socioeconómico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE4: Evaluar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al nivel socioeconómico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					
	PE5: ¿El nivel de calidad de vida difiere de acuerdo con el estado de trabajo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE5: Examinar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al estado de trabajo de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					
	PE6: ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo con la carga familiar de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE6: Explicar la relación entre la carga familiar y el nivel de calidad de vida de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					
	PE7: ¿El nivel de calidad de vida fluctúa de acuerdo con la procedencia de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE7: Identificar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a la procedencia de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.	Variable intervinientes: Implementación del servicio de terapia				

	PE8: ¿El nivel de calidad de vida cambia de acuerdo con la religión de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE8: Diferenciar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a la religión de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025..					
	PE9: ¿Varía el nivel de calidad de vida de acuerdo con las enfermedades preexistentes de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE9: Interpretar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo a las enfermedades preexistentes de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					
	PE10: ¿El nivel de calidad de vida es diferente de acuerdo con el tiempo de enfermedades de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE10: Analizar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al tiempo de enfermedades de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					
	PE11: ¿Es diferente el nivel de calidad de vida de acuerdo con el acceso al tratamiento médico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025?		OE11: Comparar la variación del nivel de la calidad de vida de acuerdo al acceso al tratamiento médico de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025.					



Anexo B. Población afiliada a SIS de Lima Metropolitana y los centros de salud

IPRESS	DIRIS	Población afiliada al SIS	Atendidos de Tfy promedio al mes
DIRIS Lima Centro			
	Ris 01 Lima		
6191	C.S. San Sebastian	29,167	70
	Ris 02 Lima	401,104	
6184	C.S. Breña	55,911	50
6198	C.S. San Miguel	154,526	120
	Ris 03 Lima	367,162	
6180	C.S. Villa Victoria Porvenir	62,035	60
	Ris 04 Lima	314,195	
6170	C.S. Max Arias Schreiber	53,187	50
	Ris 01 Sjl	427,616	
5848	C.S. Campoy	34,520	35
5841	C.S. Chacarilla De Otero	35,197	40
5834	C.S. La Libertad	49,035	40
5835	C.S. La Huayrona	45,526	40
	Ris 02 Sjl	387,865	
5620	P.S. Medalla Milagrosa	53,581	120
5624	C.S. Jaime Zubieta	67,454	120
	Ris 03 Sjl	340,296	
5628	C.S. Jose Carlos Mariategui	47,692	20
	22 Centros de salud	TOTAL	223

Nota: elaboración propia en base a datos del MINSA (DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Centro, 2024)



Anexo C. Cuestionario de calidad de vida SF – 36

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF -36

Nombre completo: DNI:

Indicaciones: Marque una sola respuesta:

1. En general, usted diría que su salud es:

- Excelente
- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?

- Mucho mejor ahora que hace un año
- Algo mejor ahora que hace un año
- Más o menos igual que hace un año
- Algo peor ahora que hace un año
- Mucho peor ahora que hace un año

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?

- Sí, me limita mucho
- Sí, me limita un poco
- No, no me limita nada

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades diarias

13. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de su salud física?

- Sí
- No

14. Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física?

- Sí
- No

15. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?

- Sí
- No

16. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física?



- Sí
- No

17. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

- Sí
- No

18. Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

- Sí
- No

19. Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

- Sí
- No

20. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

- Nada
- Un poco
- Regular
- Bastante
- Mucho

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

- No, ninguno
- Sí, muy poco
- Sí, un poco
- Sí, moderado
- Sí, mucho
- Sí, muchísimo

22. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (¿incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

- Nada
- Un poco
- Regular
- Bastante
- Mucho

Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido y como le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta, responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted.

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces



- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)?

- Siempre
- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez
- Nunca

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas

- Totalmente cierta
- Bastante cierta
- No lo sé
- Bastante falsa
- Totalmente falsa

34. Estoy tan sano como cualquiera

- Totalmente falsa
- Bastante falsa
- No lo sé
- Bastante cierta
- Totalmente cierta

35. Creo que mi salud va a empeorar

- Totalmente cierta
- Bastante cierta
- No lo sé
- Bastante falsa
- Totalmente falsa

36. Mi salud es excelente

- Totalmente falsa
- Bastante falsa
- No lo sé
- Bastante cierta
- Totalmente cierta

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases

El cuestionario de salud SF-36 está compuesto por 36 ítems que pretenden recoger todos los aspectos relevantes para caracterizar la salud de un individuo. Con estas preguntas se trata de cubrir, al menos, 8 aspectos o dimensiones: Función Física, Rol Físico; Dolor Corporal; Salud General; Vitalidad; Función Social; Rol Emocional y Salud Mental. Para cada una de estas dimensiones se pueden computar escalas de puntuación, fácilmente interpretables, caracterizadas todas ellas por encontrarse ordenadas, de tal suerte que cuanto mayor es el valor obtenido mejor es el estado de salud.



Anexo D. Tabulación de las preguntas del SF-36

Pregunta	Puntaje SF-36	Puntaje Likert	Pregunta	Puntaje SF-36	Puntaje Likert
1. En general, usted diría que su salud es: - Mala - Regular - Buena - Muy buena - Excelente	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5	9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? - Mucho peor ahora que hace un año - Algo peor ahora que hace un año - Más o menos igual que hace un año - Algo mejor ahora que hace un año - Mucho mejor ahora que hace un año	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5	10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3
3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3	11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3	12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3	13. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de su salud física? - Sí - No	0 100	1 2
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3	14. Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física? - Sí - No	0 100	1 2
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3	15. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? - Sí - No	0 100	1 2
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? - Sí, me limita mucho - Sí, me limita un poco - No, no me limita nada	0 50 100	1 2 3	16. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? - Sí - No	0 100	1 2



Pregunta	Puntaje SF-36	Puntaje Likert	Pregunta	Puntaje SF-36	Puntaje Likert
17. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? ▪ Sí ▪ No	0 100	1 2	23. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? ▪ Nunca ▪ Sólo alguna vez ▪ Algunas veces ▪ Muchas veces ▪ Casi siempre ▪ Siempre	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6
18. Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? ▪ Sí ▪ No	0 100	1 2	24. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso? ▪ Siempre ▪ Casi siempre ▪ Muchas veces ▪ Algunas veces ▪ Sólo alguna vez ▪ Nunca	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6
19. Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? ▪ Sí ▪ No	0 100	1 2	25. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? ▪ Siempre ▪ Casi siempre ▪ Muchas veces ▪ Algunas veces ▪ Sólo alguna vez ▪ Nunca	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6
20. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? ▪ Mucho ▪ Bastante ▪ Regular ▪ Un poco ▪ Nada	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5	26. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? ▪ Nunca ▪ Sólo alguna vez ▪ Algunas veces ▪ Muchas veces ▪ Casi siempre ▪ Siempre	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6
21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? ▪ Sí, muchísimo ▪ Sí, mucho ▪ Sí, moderado ▪ Sí, un poco ▪ Sí, muy poco ▪ No, ninguno	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6	27. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía? ▪ Nunca ▪ Sólo alguna vez ▪ Algunas veces ▪ Muchas veces ▪ Casi siempre ▪ Siempre	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6
22. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (¿incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? ▪ Mucho ▪ Bastante ▪ Regular ▪ Un poco ▪ Nada	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5	28. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? ▪ Siempre ▪ Casi siempre ▪ Muchas veces ▪ Algunas veces ▪ Sólo alguna vez ▪ Nunca	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6



Pregunta	Puntaje SF-36	Puntaje Likert	Pregunta	Puntaje SF-36	Puntaje Likert
29. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? - Siempre - Casi siempre - Muchas veces - Algunas veces - Sólo alguna vez - Nunca	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6	33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas - Totalmente cierta - Bastante cierta - No lo sé - Bastante falsa - Totalmente falsa	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5
30. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? - Nunca - Sólo alguna vez - Algunas veces - Muchas veces - Casi siempre - Siempre	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6	34. Estoy tan sano como cualquiera - Totalmente falsa - Bastante falsa - No lo sé - Bastante cierta - Totalmente cierta	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5
31. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? - Siempre - Casi siempre - Muchas veces - Algunas veces - Sólo alguna vez - Nunca	0 20 40 60 80 100	1 2 3 4 5 6	35. Creo que mi salud va a empeorar - Totalmente cierta - Bastante cierta - No lo sé - Bastante falsa - Totalmente falsa	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5
32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)? - Siempre - Casi siempre - Algunas veces - Sólo alguna vez - Nunca	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5	36. Mi salud es excelente - Totalmente falsa - Bastante falsa - No lo sé - Bastante cierta - Totalmente cierta	0 25 50 75 100	1 2 3 4 5



Anexo E. Cuestionario de características poblacionales

Cuestionario de Características poblacionales de los pacientes que reciben tratamiento en los servicios de terapia física y rehabilitación en el primer nivel de atención de Lima Metropolitana – 2025

Nombre completo: DNI:

Indicaciones: Conteste las siguientes preguntas

1. Características Sociodemográficas:

Edad:

Sexo: M F

2. Características Educativas - Nivel de instrucción:

- ☐ Sin educación
- ☐ Educación básica inicial
- ☐ Educación básica primaria
- ☐ Educación básica secundaria
- ☐ Educación superior

3. Características Laborales

- ☐ Nivel económico
 - ☐ Ingresos de S/. 12,660 (A)
 - ☐ Ingresos de S/. 7,020 (B)
 - ☐ Ingresos de S/. 3,970 (C)
 - ☐ Ingresos de S/. 2,480 (D)
 - ☐ Ingresos de S/. 1,300 (E)
- ☐ Trabajo – PEA
 - ☐ No cuenta
 - ☐ Trabajo independiente
 - ☐ Trabajo dependiente no estable
 - ☐ Trabajo dependiente estable
- ☐ Carga familiar
 - ☐ No cuenta
 - ☐ Único aporte de casa
 - ☐ No es el único aporte de casa

4. Características Culturales:

- ☐ Procedencia
 - ☐ Sierra
 - ☐ Costa
 - ☐ Selva
- ☐ Religión
 - ☐ Católico
 - ☐ Sin religión
 - ☐ Evangélico
 - ☐ Otros cristianos
 - ☐ Otras religiones
 - ☐ No desea contestar

5. Características Clínicas:

- ☐ Enfermedades preexistentes
 - ☐ Si presenta
 - ☐ Reumatológicas
 - ☐ Traumatológicas A
 - ☐ No presenta
- ☐ Tiempo de enfermedad
 - ☐ Aguda
 - ☐ Crónica
- ☐ Acceso a tratamiento
 - ☐ Si cuenta
 - ☐ No cuenta, detalle

Gracias por su participación



Anexo F. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto: “Caracterización de la calidad de vida en pacientes que reciben tratamiento en terapia física y rehabilitación en Lima Metropolitana – 2025”.

Investigador: Janet Carito Quispe Corilla

DNI: 70022459

Institución: Universidad Continental

Yo, he sido informado(a) que la investigadora Janet Carito Quispe Corilla del Doctorado en Salud Pública y Salud Global, de la escuela de post grado de la Universidad Continental, está realizando un estudio “CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN EN LIMA METROPOLITANA – 2025”

Yo he elegido libremente participar en el estudio:

- Entiendo que para esto debo responder dos cuestionarios que se encuentra al final de este documento.
- Entiendo que mi participación será enteramente voluntariamente y si no deseo contestar alguna de las preguntas, se respetará mi decisión, así como retirarme voluntariamente en cualquier momento del estudio sin que esto ocasiona algún tipo de sanción.
- Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo alguno, más aún, permitirá conocer características personales y de calidad de vida que presento.
- Entiendo que la información obtenida de los cuestionarios será tratada de manera confidencial.
- Entiendo que si firmo este papel confirma que leí o que me lo leyeron y decidido participar de este estudio. Además, que si decido retirarme lo puedo hacer con total libertad.

Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este momento. Sé que en un futuro tuviera alguna duda del mismo puedo acudir o contactar a la Mg Janet C. Quispe Corilla con número celular 987814975 o el correo 70022459@continental.edu.pe

.....

Nombre completo

Firma del participante

Fecha y hora



“Caracterización de la calidad de vida en pacientes que reciben tratamiento en terapia física y rehabilitación en Lima Metropolitana – 2025”

Investigadora: Janet Carito Quispe Corilla.

Justificación, Objetivos y propósito de la Investigación: La Universidad Continental realiza un estudio sobre las características y calidad de vida de la población que recibe la atención de terapia física y rehabilitación en los centros de salud del MINSA en Lima – Perú. En nuestra sociedad se desconoce la calidad de vida que presenta los pacientes con algún diagnóstico traumatológico o reumatológico. Al mismo tiempo se desconoce cuáles las condiciones con la que se asocia el nivel de la calidad de vida. Por lo que, para enfrentar las consecuencias o complicaciones de los pacientes, tanto de manera preventiva como asistencial en la salud pública es importante tener claro toda esta información.

Participación: Este estudio quiere identificar mis características personales y mi calidad de vida para debo contestar preguntas de mi edad, sexo, nivel de instrucción, nivel económico, trabajo, carga familiar, procedencia, religión, enfermedades preexistentes, tiempo de enfermedad, acceso a tratamiento y mi percepción sobre mi salud. Solo se hará en 1 entrevista.

Riesgo del estudio: Este estudio no presenta ningún riesgo. Para participar solo requiere sus respuestas.

Beneficios del estudio: Es muy importante mencionar que sus respuestas aportaran a mejora las propuestas de las intervenciones del MINSA en los centros de salud.

Costo de la participación: La participación en este estudio no tiene costo alguno para usted.

Confidencialidad: Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente los miembros de investigación conocerán los resultados.

Requisitos de participación: Los participantes deben estar recibiendo el tratamiento de terapia física. Al aceptar la participación en el estudio deberá firmar este documento llamado consentimiento informado, con lo cual autoriza y acepta su participación en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted no desea participar en el estudio por cualquier razón, puede retirarse libremente sin costo alguno a consecuencia de su negatividad.

Donde conseguir información: Para cualquier consulta, queja o comentario comunicarse con la Mg. Janet C. Quispe Corilla con número celular 987814975 y será atendidos con mucho gusto.

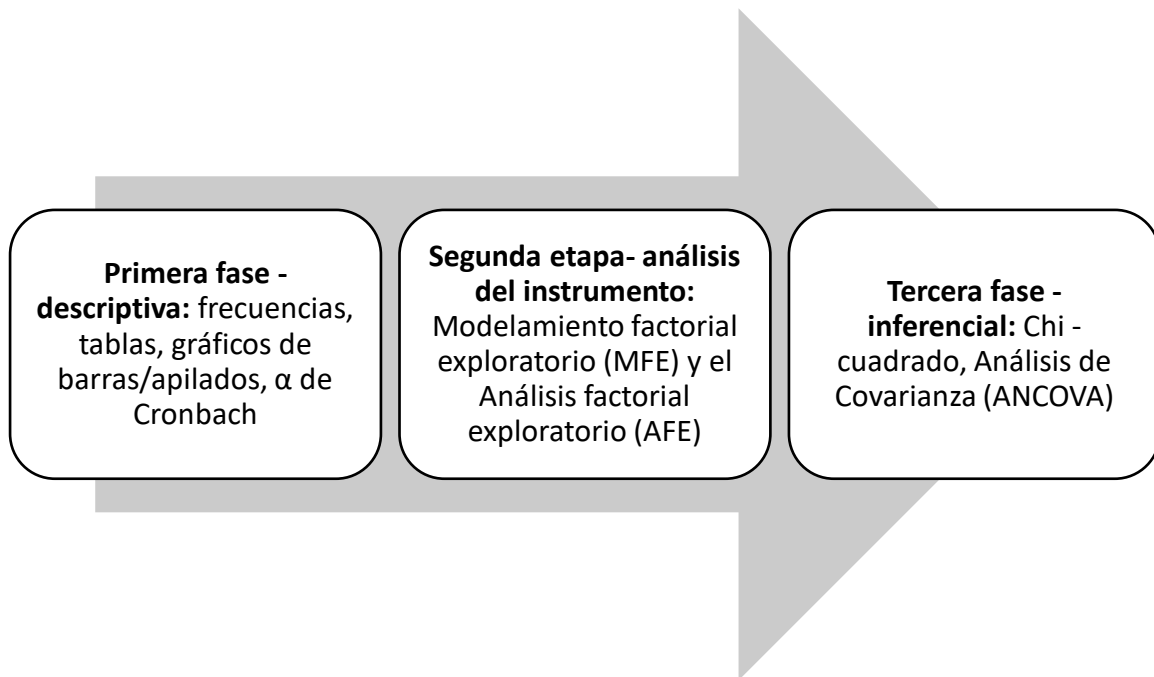
Declaración voluntaria: Yo he sido informado (a) del objetivo del estudio, el procedimiento, he conocido los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es gratuita. Estoy enterado también que si no deseo continuar con la participación no asumiré costo alguno cual sea los motivos por el cual tome esa decisión sin recibir represalias por parte del equipo de investigación, del centro de terapia o de la Universidad Continental. Por lo anterior acepto voluntariamente participar la investigación.

Nota: Si ha aceptado participar, se le agradecería contestar las siguientes preguntas.

Cuestionario breve:

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Como se enteró del servicio de terapia en su centro | 2. Cuanto tiempo demoró en obtener su primera cita | 3. Lleva paralelamente algún tratamiento en otro centro o servicio de terapia física. |
| ○ Derivación de otro servicio | ○ Menos de 2 semanas | ○ Si |
| ○ Información de familiares externos | ○ Más de 2 semanas | ○ NO |
| ○ Cuanta propia | | |

Anexo G. Análisis estadístico



Nota: Fuente propia



Anexo H. Comentarios de Juicios de expertos

Tabla 14. Recomendaciones de los expertos - validación de contenido

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NIVEL EDUCATIVO
Beatriz Horna Zevallos	Fisioterapeuta CTMP: 8345	Magister
Aníbal Gustavo Yllesca Ramos	Fisioterapeuta CTMP: 11161	Doctor
Tania Maribel Llanto Herrera	Enfermera CE: 032865	Magister
Yiset La Rosa Gonzales	Fisioterapeuta CTMP: 10593	Licenciada Bachiller
Elsa Melgarejo Castro	Ama De Casa	Secundario
Diana Gamarra Oblitas	Comerciante	Secundario
Maritza Gálvez Barrantes	Ama De Casa	Secundario
Juan Francisco Llanos Avalos	Obrero	Secundario
Miguel Alejandro Bustamante Ubilla	Ing. Comercial, Docente Universitario https://orcid.org/0000-0002-5079-9856	Doctor

Nota: fuente propia



Maritza Gálvez Barrantes



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5 X
---	---	---	---	-----
2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3 X	4	5
---	---	-----	---	---
3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4 A	5
---	---	---	-----	---
4. ¿Considera Ud. Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5 A
---	---	---	---	-----
5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4 A	5
---	---	---	-----	---
6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1 A	2	3	4	5
-----	---	---	---	---
7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas interpretaciones?

	2	3	4	5 A
--	---	---	---	-----
8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5 A
---	---	---	---	-----
9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	A 4	5
---	---	---	-----	---
10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?
Me parece correcto pero sería bueno colocar una pregunta que evidencie si se realiza actividad física o no.

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

Maritza Gálvez Barrantes



Juan Francisco Llanos Avalos



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
4. ¿Considera Ud, Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas Interpretaciones?

	2	3	4	5
--	---	---	---	---
8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?
Algunas preguntas se repiten

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

JUAN FRANCISCO LLANOS AVALOS



Lic: Beatriz Horna Zevallos



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. ¿Considera Ud, Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas Interpretaciones?

	2	3	4	5
--	---	---	---	---

8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

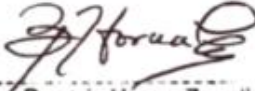
9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?

___ La preguntas son coherentes ___

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla


Lic. Beatriz Horna Zevallos
Tecnólogo Médico
C.T.M.P. 8345



Anibal Gustavo Yllesca Ramos



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5 (X)
---	---	---	---	-------
2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5 (X)
---	---	---	---	-------
3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3 (X)	4	5
---	---	-------	---	---
4. ¿Considera Ud. Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5 (X)
---	---	---	---	-------
5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5 (X)
---	---	---	---	-------
6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5 (X)
---	---	---	---	-------
7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas interpretaciones?

	2	3	4	5 (X)
--	---	---	---	-------
8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4 (X)	5
---	---	---	-------	---
9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5 (X)
---	---	---	---	-------
10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?
 - Con respecto a esta hoja de validación, en el ítem 3, lo califico con 3 porque no entiendo el concepto de universo, materia de estudio.
 - Con respecto al ítem 8, lo califico con 4 porque no se conoce el nivel socio cultural de cada uno de los usuarios.
 - Finalmente, debo sugerir que, si esta investigación se piensa desarrollar en un nivel RELACIONAL, debería formularse bien el enunciado del título de investigación y mejorar el dimensionamiento de las variables a estudiar.

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

Firma del experto

Nombre Completo: Anibal Gustavo Yllesca Ramos

Profesión: Tecnólogo Médico en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación



Tania Maribel Llanto Herrera



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. ¿Considera Ud. Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas interpretaciones?

	2	3	4	5
--	---	---	---	---

8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?

se sugiere quizás menos preguntas ya que no debería ser tantas, que no están acostumbrados a leer textos extensos

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

Tania M. Llanto H.

Firma del experto

Nombre Completo: *LIC. TANIA MARIBEL LLANTO HERRERA*



Yiset La Rosa Gonzales



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

4. ¿Considera Ud, Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas Interpretaciones?

	2	3	4	5
--	---	---	---	--------------

8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	--------------

10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?

Ninguna, Todo esta dentro el parámetro de tu tema de investigación, sugiero que, para una mejor praxis tu cuestionario adecuarlo al Google Forms y se mas viable para poder levantar la información con una mejor claridad.

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

Firma del experto



Elsa Melgarejo Castro



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
4. ¿Considera Ud. Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas Interpretaciones?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?

--	--	--	--	--

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

Firma del experto

Nombre Completo:

Profesión:

Elsa Melgarejo Castro



Diana Gamarra Oblitas



Hoja de validación del cuestionario de recolección de datos

1. ¿Considera Ud. ¿Que las preguntas del instrumento, miden lo que pretenden medir?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
2. ¿Considera Ud. ¿Que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficiente para tener comprensión de la materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
3. Considera Ud. ¿Que las preguntas contenidas de este instrumento, son una muestra representativa del universo materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
4. ¿Considera Ud. Si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares obtendremos también datos similares?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
5. Considera Ud. ¿Que los conceptos utilizados en este instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
6. Considera Ud. ¿Que todos y cada una de las preguntas contenidos en este instrumento tienen los mismos objetivos?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
7. ¿Considera Ud. ¿Que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro, sencillo y no da lugares a diversas Interpretaciones?

	2	3	4	5
--	---	---	---	---
8. ¿Considera Ud. ¿Que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
9. ¿Estima Ud. ¿Que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a los objetivos materia de estudio?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
10. ¿Qué aspecto habría que modificar o que aspectos tendrían que incrementarse o suprimirse?

--	--	--	--	--

Agradece su colaboración: Magister Janet Carito Quispe Corilla

Firma del experto

Nombre Completo:

Profesión:

Diana Gamarra Oblitas
[Firma]



Anexo I. Base de datos

Esta base de datos muestra las respuestas de las Cuestionario de Características poblacionales y Cuestionario de calidad de vida SF – 36 de 177 participantes de centros de terapia física de la zona de San Juan de Lurigancho.

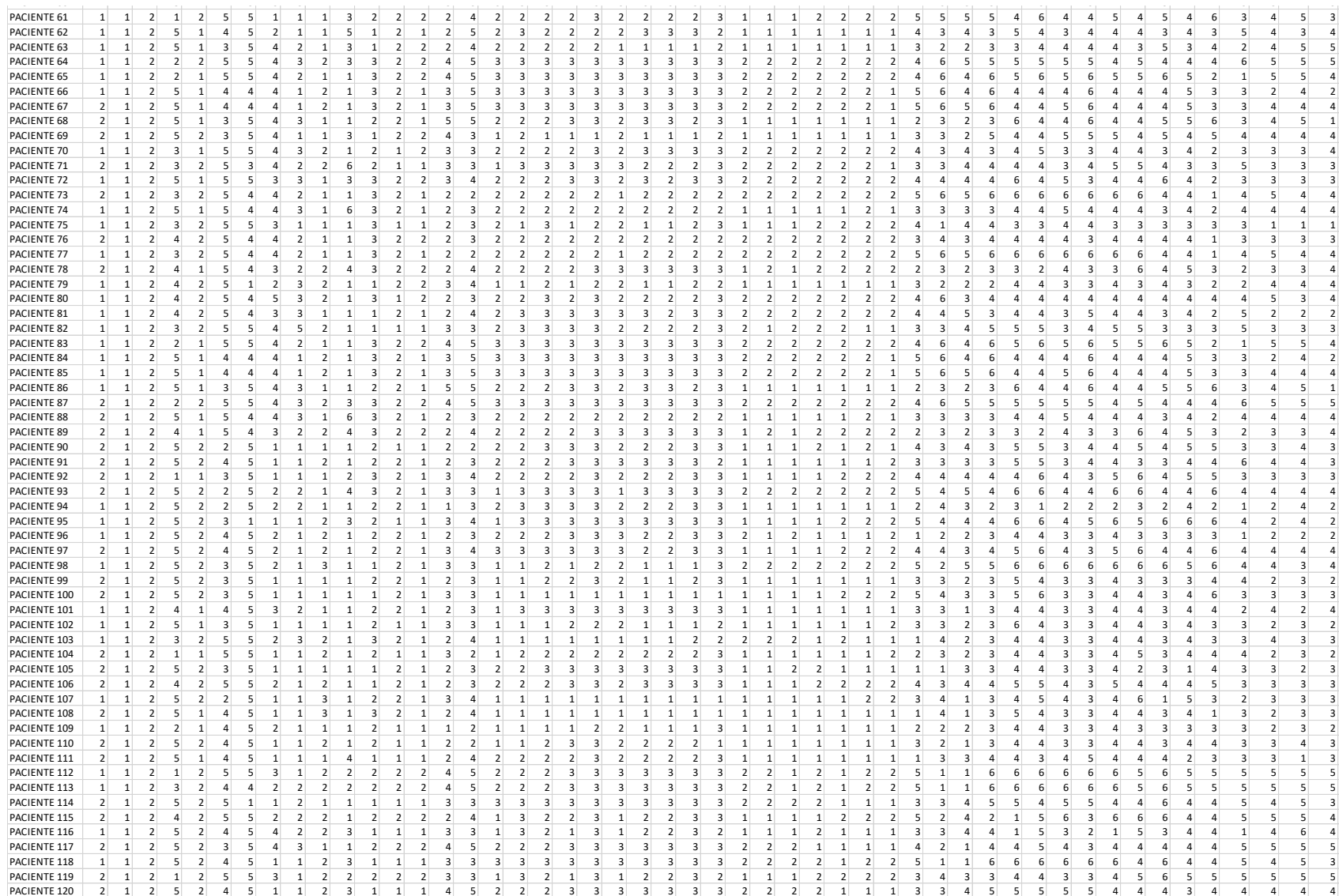
P1 a P3: Preguntas del consentimiento informado

P4 a P14: Preguntas del Cuestionario de Características poblacionales

P15 a P50: Preguntas del Cuestionario de calidad de vida SF – 36

Las preguntas fueron tabuladas en códigos para ser ingresados al programa de SPSS29

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50			
PACIENTE 1	1	1	2	5	1	3	5	4	2	1	3	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	3	4	4	4	4	3	5	3	4	2	4	5	5		
PACIENTE 2	1	1	2	2	2	5	5	4	3	2	3	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	6	5	5				
PACIENTE 3	2	1	2	2	1	5	5	4	2	1	1	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	4	6	5	6	5	6	5	5	2	1	5	5	4				
PACIENTE 4	1	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	4	6	4	4	4	6	4	4	5	3	3	2	4	2			
PACIENTE 5	2	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	5	6	4	4	5	6	4	4	4	5	3	4	4	4			
PACIENTE 6	1	1	2	5	1	3	5	4	3	1	1	2	2	1	5	5	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	6	4	4	6	4	4	5	5	6	3	4	5	1	
PACIENTE 7	1	1	2	5	2	3	5	4	1	1	3	1	2	2	4	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4		
PACIENTE 8	1	1	2	3	1	5	5	4	3	2	1	2	1	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	3	4	5	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3	4		
PACIENTE 9	1	1	2	3	2	5	3	4	2	2	6	2	1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	4	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	5	3	3	3		
PACIENTE 10	1	1	2	5	1	5	5	3	3	1	3	3	2	2	3	4	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	4	5	3	4	4	6	4	2	3	3	3	3		
PACIENTE 11	1	1	2	3	2	5	4	4	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1	4	5	4	4		
PACIENTE 12	1	1	2	5	1	5	4	4	3	1	6	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	
PACIENTE 13	1	1	2	3	2	5	5	3	1	1	1	3	1	1	2	3	2	1	3	1	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	2	4	1	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	1	1	1	1	
PACIENTE 14	1	1	2	4	2	5	4	4	2	1	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	3	3		
PACIENTE 15	1	1	2	3	2	5	4	4	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1	4	5	4	4		
PACIENTE 16	1	1	2	4	1	5	4	3	2	2	4	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	4	3	3	6	4	5	3	2	3	3	4			
PACIENTE 17	1	1	2	4	2	5	1	2	3	2	1	1	2	2	3	4	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	4	4	3	3	4	4	3	2	2	4	4	4	4		
PACIENTE 18	1	1	2	4	2	5	4	5	3	2	1	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4		
PACIENTE 19	1	1	2	4	2	5	4	3	3	1	1	1	2	1	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	3	4	4	4	3	5	4	4	3	4	2	5	2	2	2	
PACIENTE 20	1	1	2	3	2	5	5	4	5	2	1	1	2	1	1	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2	1	3	3	4	5	5	5	3	4	5	5	3	3	3	5	3	3	3		
PACIENTE 21	1	1	2	2	1	5	5	4	2	1	1	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	4	6	4	6	5	6	5	6	5	5	6	5	2	1	5	5	4		
PACIENTE 22	1	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	4	6	4	4	4	6	4	4	4	5	3	3	2	4	2		
PACIENTE 23	1	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	5	6	4	4	4	5	6	4	4	5	3	3	4	4		
PACIENTE 24	1	1	2	5	1	3	5	4	3	1	1	2	2	1	5	5	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	2	3	2	3	6	4	4	6	4	4	5	6	3	4	5	1	4		
PACIENTE 25	1	1	2	2	2	5	5	4	3	2	3	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	6	5	5	5			
PACIENTE 26	1	1	2	5	1	5	4	4	3	1	6	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	
PACIENTE 27	1	1	2	4	1	5	4	3	2	2	4	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	2	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2	4	3	3	6	4	5	3	2	3	3	4		
PACIENTE 28	1	1	2	5	2	2	5	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	2	1	2	1	4	3	4	3	5	5	3	4	4	5	4	5	5	3	3	4	3	
PACIENTE 29	1	1	2	5	2	4	5	1	1	2	1	2	2	1	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	5	5	3	4	4	3	3	4	6	4	4	3	4		
PACIENTE 30	1	1	2	1	1	3	5	1	1	1	2	3	2	1	3	4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	6	4	3	5	6	4	4	5	5	3	3	3	3	
PACIENTE 31	1	1	2	5	2	2	5	2	2	1	4	3	2	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	5	4	6	6	4	4	6	6	4	4	6	4	4	4	4	4		
PACIENTE 32	1	1	2	5	2	2	5	2	2	1	1	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	2	3	1	2	2	2	3	2	4	1	2	4	2	2		
PACIENTE 33	2	1	2	5	2	3	1	1	1	2	3	2	1	1	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	5	4	4	4	6	6	4	5	6	5	6	6	6	4	2	4	2	2	
PACIENTE 34	2	1	2	5	2	4	5	2	1	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	1	2	1	2	1	2	2	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	1	2	2	2	2	
PACIENTE 35	2	1	2	5	2	4	5	2	1	2	1	2	2	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	5	6	4	3	5	6	4	4	6	4	4	4	4	4	
PACIENTE 36	1	1	2	5	2	3	5	2	1	3	1	1	2	1	3	3	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	5	2	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	4	4	3	4	3	4
PACIENTE 37	1	1	2	5	2	3	5	1	1	1	1	2	2	1	2	3	1	1	2	2	3	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	5	4	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	2	2	
PACIENTE 38	1	1	2	5	2	3	5	1	1																																												





PACIENTE 121	2	1	2	4	1	5	5	3	2	2	1	2	1	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5		
PACIENTE 122	2	1	2	5	2	4	5	3	3	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	5	4	3	4	5	4	5	2	2	3	3	1	3		
PACIENTE 123	1	1	2	1	2	5	5	1	1	1	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	5	5	5	5	4	6	4	4	5	4	5	4	6	3	4	5	3		
PACIENTE 124	1	1	2	5	1	4	5	2	1	1	5	1	2	1	2	5	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	4	3	5	4	3	4	4	4	3	4	3	5	4	3	4		
PACIENTE 125	1	1	2	5	1	3	5	4	2	1	3	1	2	2	2	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	3	4	4	4	4	3	5	3	4	2	4	5	5		
PACIENTE 126	2	1	2	2	2	5	5	4	3	2	3	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	6	5	5	5		
PACIENTE 127	1	1	2	2	1	5	5	4	2	1	1	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	4	6	5	6	5	6	5	5	6	5	2	1	5	5	4		
PACIENTE 128	2	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	4	6	4	4	4	4	6	4	4	4	5	3	3	2	4	2	
PACIENTE 129	2	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	5	6	4	4	5	6	4	4	4	5	3	3	4	4	4		
PACIENTE 130	2	1	2	5	1	3	5	4	3	1	1	2	2	1	5	5	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	6	4	4	6	4	4	5	5	6	3	4	5	1		
PACIENTE 131	2	1	2	5	2	3	5	4	1	1	3	1	2	2	4	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4		
PACIENTE 132	2	1	2	3	1	5	5	4	3	2	1	2	1	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	3	4	5	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3	4		
PACIENTE 133	1	1	2	3	2	5	3	4	2	2	6	2	1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	3	3	4	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	5	3	3	
PACIENTE 134	1	1	2	5	1	5	5	3	3	1	3	3	2	2	3	4	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	4	5	3	4	4	6	4	2	3	3	3	3	3		
PACIENTE 135	1	1	2	3	2	5	4	4	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1	4	5	4	4		
PACIENTE 136	2	1	2	5	1	5	4	4	3	1	6	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	2	4	4	4	
PACIENTE 137	1	1	2	3	2	5	5	3	1	1	1	3	1	1	2	3	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	4	1	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	1	1	1	1	
PACIENTE 138	2	1	2	4	2	5	4	4	2	1	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	3	3	3	3		
PACIENTE 139	2	1	2	3	2	5	4	4	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1	4	5	4	4		
PACIENTE 140	2	1	2	4	1	5	4	3	2	2	4	3	2	2	2	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	2	4	4	3	3	6	4	5	3	2	3	2	3	3	4		
PACIENTE 141	2	1	2	4	2	5	1	2	3	2	1	1	2	2	3	4	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	4	4	3	3	4	3	4	3	2	2	4	4	4	4		
PACIENTE 142	2	1	2	4	2	5	4	5	3	2	1	3	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	
PACIENTE 143	1	1	2	4	2	5	4	3	3	1	1	1	2	1	2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	3	4	4	3	5	4	4	3	4	2	5	2	2	2		
PACIENTE 144	1	1	2	3	2	5	5	4	5	2	1	1	1	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	4	5	5	5	3	4	5	5	3	3	3	5	3	3	3		
PACIENTE 145	1	1	2	2	1	5	5	4	2	1	1	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	4	6	5	6	5	6	5	5	6	5	2	1	5	5	4		
PACIENTE 146	2	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	4	6	4	4	4	4	6	4	4	4	5	3	3	2	4	2	
PACIENTE 147	1	1	2	5	1	4	4	4	1	2	1	3	2	1	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	5	6	5	6	4	4	5	6	4	4	4	5	3	3	4	4	4	
PACIENTE 148	2	1	2	5	1	3	5	4	3	1	1	2	1	1	5	5	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	6	4	4	6	4	4	5	5	6	3	4	5	1		
PACIENTE 149	2	1	2	2	5	5	4	3	3	2	3	3	2	2	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	6	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	6	5	5	5	5		
PACIENTE 150	2	1	2	5	1	5	4	3	1	6	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	2	4	4	4	
PACIENTE 151	1	1	2	4	1	5	4	3	2	2	4	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	4	3	6	4	5	3	2	3	2	3	3	4		
PACIENTE 152	1	1	2	5	2	2	5	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	2	1	2	1	4	3	4	3	5	5	3	4	4	5	4	5	5	3	3	4	3
PACIENTE 153	2	1	2	5	2	4	5	1	1	2	1	2	2	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3	3	4	6	4	4	3		
PACIENTE 154	1	1	2	1	1	3	5	1	1	1	2	3	2	1	3	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6	4	3	5	6	4	5	5	3	3	3	
PACIENTE 155	1	1	2	5	2	2	5	2	2	1	4	3	2	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	5	4	5	4	6	6	4	4	6	6	4	4	6	4	4	4	4		
PACIENTE 156	1	1	2	5	2	2	5	2	2	1	1	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	2	3	1	2	2	2	3	2	4	2	1	2	4	2	
PACIENTE 157	2	1	2	5	2	3	1	1	1	2	3	2	1	1	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	5	4	4	4	6	6	4	5	6	5	6	6	6	4	2	4	2	
PACIENTE 158	2	1	2	5	2	4	5	2	1	2	1	2	2	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	1	2	2		